

Buku Ajar
**ASUHAN KEBIDANAN
PERSALINAN**
DAN KEGAWATDARURATAN INTRAPARTUM

Veryudha Eka Prameswari • Imtihanatun Najahah • Meidayana Refisiliyani
Dewi Hanifah • Naning Suryani • Arti Wardani

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



BUKU AJAR

ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN KEGAWATDARURATAN INTRAPARTUM

Penulis:

Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes.
Imtihanatun Najahah, SST., M.Kes.
Bdn.Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb., M.Keb.
Dewi Hanifah, S.ST., M.Keb.
Naning Suryani, SST., BDN., M.Keb.
Arti Wardani, SST., M.Keb.

Editor:

Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Kegawatdaruratan Intrapartum

Penulis:

Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes.
Imtihanatun Najahah, SST., M.Kes.
Bdn.Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb., M.Keb.
Dewi Hanifah, S.ST., M.Keb.
Naning Suryani, SST., Bdn ., M.Keb.
Arti Wardani, SST., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Muftililah, S.SIT., M.Sc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-46-6

Cetakan Pertama : Juni, 2026

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kegawatdaruratan Intrapartum ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai salah satu bahan referensi pembelajaran dalam bidang kebidanan, khususnya terkait asuhan kebidanan pada masa persalinan dan penanganan kegawatdaruratan intrapartum.

Persalinan merupakan proses fisiologis yang sangat penting dalam kehidupan seorang perempuan. Meskipun pada umumnya persalinan berlangsung secara normal, bidan tetap harus memiliki kemampuan dalam melakukan pemantauan, pengkajian, pengambilan keputusan, serta penatalaksanaan yang tepat apabila terjadi penyulit atau kondisi kegawatdaruratan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep persalinan dan kegawatdaruratan intrapartum menjadi dasar penting bagi mahasiswa kebidanan dalam mempersiapkan diri sebagai calon bidan yang profesional.

Buku ajar ini memuat pembahasan mengenai konsep dasar persalinan, tahapan persalinan, pemantauan kondisi ibu dan janin, prinsip asuhan sayang ibu, serta pengenalan tanda bahaya selama proses intrapartum. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai kondisi kegawatdaruratan yang dapat terjadi selama persalinan, sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami langkah-langkah penanganan awal secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kewenangan bidan.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi secara sistematis, baik dalam pembelajaran teori, praktik laboratorium, maupun praktik klinik. Materi yang disajikan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat mendukung proses belajar mengajar serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan kebidanan.

Melalui buku ajar ini, diharapkan mahasiswa kebidanan mampu menerapkan asuhan kebidanan persalinan yang aman, bermutu, komprehensif, dan berpusat pada kebutuhan ibu serta bayi. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi dosen, pembimbing klinik, dan tenaga kebidanan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan kebidanan, khususnya pada masa persalinan.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kelengkapan pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan buku ajar ini. Semoga Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kegawatdaruratan Intrapartum ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, bidan, serta seluruh pihak yang berkecimpung dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Penulis

Juni, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN KESELAMATAN INTRAPARTUM..... 1

A. Ruang lingkup, prinsip, dan standar asuhan persalinan berorientasi ibu-bayi.....	11
B. Isu etik–legal, hak pasien, dan keselamatan intrapartum pada skenario pelayanan.....	23
C. Latihan Soal.....	25
D. Portofolio	27
E. Ringkasan	33
F. Tabel Red Flags & Eskalasi	34
G. Daftar Pustaka.....	36

BAB 2 PENGKAJIAN IBU BERSALIN : ANAMNESIS, PEMERIKSAAN FISIK, DAN PENILAIAN KESEJAHTERAAN JANIN 39

A. Teori Dasar	44
B. Konsep Dasar Pengkajian Ibu Bersalin.....	45
C. Persiapan Pengkajian Ibu Bersalin.....	46
D. Anamnesis pada Ibu Bersalin.....	47
E. Penilaian Kesejahteraan Janin	49
F. Template Soal Osce Kebidanan.....	51
G. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan	56
H. Ringkasan	67
I. Tabel Red Flags & Eskalasi	68
J. Daftar Pustaka.....	72

BAB 3 PEMANTAUAN KEMAJUAN PERSALINAN DENGAN PARTOGRAF DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KLINIS 73

A. Partograf	74
B. Manfaat Penggunaan Partograf dalam Pemantauan Persalinan.....	75
C. Komponen Partograf.....	75

D. Interpretasi Partograf	82
E. Partograf Digital	83
F. Tanda Bahaya / Red flag	83
G. Pengambilan Keputusan Klinis.....	84
H. Template Soal Osce Partograf.....	86
I. Ringkasan	102
J. Daftar Pustaka.....	107

BAB 4 ASUHAN PERSALINAN KALA I: DUKUNGAN, KENYAMANAN, DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI.....109

A. Deskripsi Materi Pembelajaran	111
B. Konsep dasar persalinan Kala I	111
C. Asuhan Dukungan Pada Persalinan Kala I	112
D. Asuhan Kenyamanan pada Kala I.....	113
E. Pencegahan Komplikasi pada Kala I	114
F. Pendekatan Praktis Asuhan Kala I.....	115
G. Latihan Soal.....	117
H. Ringkasan	122
I. Daftar Pustaka.....	123

BAB 5 MANAJEMEN NYERI PERSALINAN: TEKNIK NONFARMAKOLOGIS DAN KOLABORASI FARMAKOLOGIS.....125

A. Manajemen Nyeri Persalinan.....	136
B. Teknik Farmakologis.....	142
C. Kolaborasi	146
D. Latihan Soal.....	149
E. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan	153
F. Ringkasan	164
G. Tabel Red Flags & Eskalasi	165
H. Daftar Pustaka.....	167

BAB 6 ASUHAN PERSALINAN KALA II: PIMPINAN PERSALINAN, PERLINDUNGAN PERINEUM, DAN PENCEGAHAN ASFIKSIA169

A. Konsep Dasar Kala II Persalinan.....	172
B. Prinsip Pimpinan Persalinan Kala II	172
C. Perlindungan Perineum.....	173

D. Pencegahan Asfiksia Neonatorum	175
E. Red Flags Kala II dan Eskalasi	179
F. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan	188
G. Portofolio.....	198
H. Ringkasan	213
I. Tabel Red Flags & Eskalasi	214
J. Daftar Pustaka.....	218
PROFIL PENULIS	219

BAB 1

KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN KESELAMATAN INTRAPARTUM

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi efektif dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko pada asuhan intrapartum.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan clinical reasoning berbasis data untuk penapisan masalah dan pengambilan keputusan intrapartum.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV serta tindakan awal kegawatdaruratan intrapartum secara aman dan bermutu.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Mendokumentasikan asuhan dan rujukan secara akurat serta memanfaatkan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi mutu dan pengembangan diri.	CPMK-7; CPMK-4; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam asuhan persalinan dan situasi kegawatdaruratan intrapartum.
CPMK-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, informed consent, dan kolaborasi interprofesional pada asuhan dan rujukan intrapartum.
CPMK-3	Menerapkan keselamatan ibu-bayi melalui PPI, K3, pemantauan terstruktur, dan manajemen risiko intrapartum.
CPMK-4	Melakukan pengkajian komprehensif ibu bersalin dan kesejahteraan janin serta menafsirkan temuan untuk penetapan masalah/prioritas.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Merencanakan dan melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV berbasis bukti termasuk dukungan, kenyamanan, manajemen nyeri, dan pencegahan komplikasi.
CPMK-6	Melakukan penatalaksanaan awal kegawatdaruratan intrapartum dan menetapkan indikasi rujukan berdasarkan kondisi klinis.
CPMK-7	Menyusun dokumentasi klinis (termasuk partograf) dan dokumen rujukan secara akurat serta menggunakan data untuk evaluasi mutu.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Keselamatan Intrapartum	1.1 Menjelaskan ruang lingkup, prinsip, dan standar asuhan persalinan berorientasi ibu-bayi.	1.2 Menganalisis isu etik–legal, hak pasien, dan keselamatan intrapartum pada skenario pelayanan.	CPMK-1	CPMK-3; CPMK-7
Bab 2. Anatomi–Fisiologi Persalinan dan Faktor yang Mempengaruhi Kemajuan Persalinan	2.1 Menguraikan anatomi jalan lahir dan fisiologi persalinan yang relevan untuk pemantauan kemajuan.	2.2 Mengevaluasi faktor maternal–janin–lingkungan yang memengaruhi kemajuan persalinan dan implikasi klinisnya.	CPMK-4	CPMK-5
Bab 3. Pengkajian Ibu Bersalin: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Penilaian Kesejahteraan Janin	3.1 Melakukan anamnesis terarah dan pemeriksaan obstetri untuk memperoleh data klinis prioritas.	3.2 Menilai kesejahteraan janin dan menginterpretasikan temuan untuk identifikasi risiko.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-7
Bab 4. Pemantauan Kemajuan Persalinan dengan Partograf dan Pengambilan Keputusan Klinis	4.1 Mengisi partograf tepat waktu, lengkap, dan konsisten berdasarkan data pemantauan.	4.2 Menetapkan keputusan klinis (observasi, tindakan, kolaborasi, rujukan) berdasarkan tren partograf dan kondisi ibu–janin.	CPMK-7	CPMK-4; CPMK-6
Bab 5. Asuhan Persalinan Kala I:	5.1 Merancang dan memberikan	5.2 Menerapkan pencegahan	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-4

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Dukungan, Kenyamanan, dan Pencegahan Komplikasi	dukungan, kenyamanan, serta pemenuhan kebutuhan dasar ibu pada kala I.	komplikasi kala I melalui pemantauan terstruktur dan intervensi sesuai indikasi.		
Bab 6. Manajemen Nyeri Persalinan: Teknik Nonfarmakologis dan Kolaborasi Farmakologis	6.1 Memilih dan menerapkan teknik nonfarmakologis untuk manajemen nyeri dan kecemasan ibu.	6.2 Melakukan kolaborasi farmakologis secara aman (indikasi, monitoring efek, edukasi) sesuai kewenangan.	CPMK-5	CPMK-2; CPMK-3
Bab 7. Asuhan Persalinan Kala II: Pimpinan Persalinan, Perlindungan Perineum, dan Pencegahan Asfiksia	7.1 Memimpin kala II dengan teknik aman sesuai kondisi ibu-janin (posisi, bimbingan, pemantauan).	7.2 Menerapkan perlindungan perineum dan pencegahan asfiksia melalui tindakan intrapartum yang tepat.	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-4
Bab 8. Asuhan Persalinan Kala III: Manajemen Aktif, Penilaian Plasenta, dan Pencegahan Perdarahan	8.1 Melaksanakan manajemen aktif kala III sesuai standar untuk menurunkan risiko perdarahan.	8.2 Menilai kelengkapan plasenta/selaput dan melakukan tindak lanjut pencegahan/penanganan dini perdarahan.	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-7
Bab 9. Asuhan Persalinan Kala IV: Pemantauan, Deteksi Dini Syok, dan Stabilitas Ibu	9.1 Melaksanakan pemantauan kala IV dan mencatat hasil pemantauan secara sistematis.	9.2 Mengidentifikasi dini tanda syok dan melakukan stabilisasi awal serta eskalasi kolaborasi sesuai prioritas.	CPMK-3	CPMK-6; CPMK-7
Bab 10. Kegawatdaruratan Intrapartum: Perdarahan, Syok, dan Stabilisasi Awal	10.1 Mengenali cepat perdarahan intrapartum/postpartum awal dan melakukan	10.2 Melakukan stabilisasi awal pada syok dan menyiapkan kolaborasi/rujukan	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-3

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
	tindakan awal sesuai algoritme.	dengan komunikasi efektif.		
Bab 11. Distosia dan Partus Lama: Identifikasi, Tindakan Awal, dan Indikasi Rujukan	11.1 Menganalisis distosia/partus lama berdasarkan data klinis dan pemantauan kemajuan persalinan.	11.2 Melakukan tindakan awal yang aman dan menetapkan indikasi rujukan tepat waktu.	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-7
Bab 12. Gawat Janin dan Masalah Air Ketuban: Deteksi Dini, Tindakan Awal, dan Rujukan	12.1 Menginterpretasikan tanda gawat janin dan masalah air ketuban untuk penetapan derajat urgensi.	12.2 Melakukan tindakan awal dan rencana rujukan untuk mencegah perburukan kondisi ibu-janin.	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-2
Bab 13. Preeklamsia/Eklamsia saat Intrapartum: Penanganan Awal, Pencegahan Kejang, dan Rujukan	13.1 Mengidentifikasi preeklamsia berat/eklamsia intrapartum dan melakukan penanganan awal hipertensi sesuai protokol.	13.2 Melaksanakan pencegahan kejang, monitoring ibu-janin, serta koordinasi rujukan aman dan cepat.	CPMK-6	CPMK-3; CPMK-2
Bab 14. Rujukan Intrapartum dan Transport Aman: Komunikasi, Dokumentasi, dan Pendampingan Keluarga	14.1 Menyampaikan informasi rujukan terstruktur (mis. SBAR) dan memperoleh persetujuan tindakan secara etis.	14.2 Menyusun dokumentasi rujukan dan rencana transport aman termasuk pendampingan keluarga dan serah-terima.	CPMK-2	CPMK-7; CPMK-1

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian kasus tertulis; esai refleksi terstruktur	Mengidentifikasi ≥ 3 isu etik–legal dan hak pasien pada skenario; memilih tindakan sesuai kewenangan & standar	10	Lembar jawaban kasus; esai refleksi

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Observasi role-play; lembar rating komunikasi	Menyampaikan informasi dengan empati & bahasa jelas; melakukan komunikasi kolaboratif terstruktur (serah-terima/rujukan) tanpa kehilangan data kunci	10	Lembar observasi; rekaman/skrip role-play
CPMK-3	Checklist praktik PPI/K3; audit mini skenario	Melaksanakan hand hygiene & APD tepat; melakukan pemantauan terstruktur dan mengeksekusi pencegahan risiko (mis. identifikasi bahaya & eskalasi)	15	Checklist keterampilan; lembar audit
CPMK-4	Ujian studi kasus; OSCE pengkajian	Mengumpulkan data prioritas lengkap; menginterpretasikan temuan ibu-janin dan menetapkan masalah/prioritas yang konsisten dengan data	15	Lembar kerja kasus; lembar OSCE
CPMK-5	OSCE manajemen persalinan; demonstrasi terstruktur	Melaksanakan langkah asuhan kala I-IV sesuai SOP; menerapkan dukungan/nyeri dan tindakan pencegahan komplikasi sesuai indikasi	20	Checklist OSCE; logbook/dokumentasi simulasi
CPMK-6	Simulasi skenario kegawatdaruratan; uji keputusan klinis	Melakukan penilaian cepat dan stabilisasi awal sesuai prioritas; menetapkan indikasi rujukan/kolaborasi tepat waktu berdasarkan kondisi klinis	20	Checklist simulasi; catatan keputusan klinis
CPMK-7	Penugasan partograf &	Mengisi partograf lengkap dan konsisten; menyusun catatan	10	Partograf; catatan asuhan; dokumen rujukan; portofolio

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
	dokumentasi; portofolio	asuhan & dokumen rujukan dengan data kunci utuh; menyajikan 1 temuan perbaikan berbasis data		

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Identifikasi isu etik–legal	Isu kunci tidak dikenali atau keliru; mengabaikan hak pasien	Mengenali sebagian isu namun ada yang terlewat/kurang tepat	Mengenali mayoritas isu dan mengaitkan dengan hak pasien	Mengenali isu secara lengkap, memprioritaskan, dan menjustifikasi secara konsisten
1.2 Keputusan profesional sesuai kewenangan	Keputusan tidak sesuai standar/kewenangan; risiko keselamatan meningkat	Keputusan sebagian sesuai namun ragu/tidak konsisten	Keputusan sesuai standar dengan koreksi minor	Keputusan tepat, tegas, berbasis standar, dan mempertimbangkan keselamatan serta martabat pasien

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Komunikasi terapeutik ibu/keluarga	Tidak empatik; informasi membingungkan; tidak cek pemahaman	Empati terbatas; informasi sebagian jelas; cek pemahaman tidak konsisten	Empatik; informasi jelas; cek pemahaman dilakukan	Sangat empatik; informasi ringkas-akurat; cek pemahaman & respons kebutuhan emosional konsisten
2.2 Komunikasi kolaboratif terstruktur (serah-terima/rujukan)	Data kunci hilang; struktur tidak jelas	Struktur ada namun data penting belum lengkap	Struktur jelas; data kunci lengkap; pesan utama tersampaikan	Struktur sangat baik; data lengkap + prioritas/pemintaan tindakan jelas;

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
				meminimalkan miskomunikasi

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Penerapan PPI dan K3	Tidak konsisten; langkah kritis terlewat	Cukup konsisten namun ada langkah yang kurang tepat	Konsisten dan benar pada langkah utama	Sangat konsisten; benar pada seluruh langkah; mampu mengoreksi risiko di tempat
3.2 Pemantauan terstruktur dan manajemen risiko	Pemantauan tidak terarah; risiko tidak dikenali	Pemantauan ada namun tidak sistematis; risiko dikenali terlambat	Pemantauan sistematis; risiko dikenali dan dicegah	Pemantauan sangat sistematis; antisipasi risiko proaktif dan eskalasi tepat waktu

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kelengkapan pengkajian (anamnesis & fisik)	Data prioritas banyak hilang; teknik tidak tepat	Data cukup namun masih ada bagian prioritas terlewat	Data prioritas lengkap; teknik pemeriksaan tepat	Data sangat lengkap, terfokus, dan efisien; mampu menyesuaikan pada kondisi klinis
4.2 Interpretasi temuan & penetapan prioritas	Interpretasi keliru; prioritas tidak sesuai data	Interpretasi sebagian benar; prioritas belum jelas	Interpretasi benar; prioritas logis dan konsisten	Interpretasi sangat akurat; prioritas tajam; menautkan data dengan rencana tindak lanjut yang tepat

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Pelaksanaan asuhan kala I–IV sesuai standar	Urutan kerja tidak tepat; langkah kritis terlewat	Urutan cukup benar namun ada langkah kurang tepat	Urutan benar; langkah kritis terpenuhi	Sangat terampil; langkah kritis lengkap; adaptif terhadap respons ibu-bayi
5.2 Dukungan/nyeri dan pencegahan komplikasi	Intervensi tidak sesuai kebutuhan/indikasi	Intervensi sesuai sebagian; evaluasi kurang	Intervensi sesuai kebutuhan; evaluasi respons dilakukan	Intervensi sangat tepat; edukasi + evaluasi respons konsisten; pencegahan komplikasi terintegrasi

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Pengenalan dan stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda gawat terlewat; stabilisasi tidak sesuai prioritas	Tanda gawat dikenali namun respon lambat/kurang tepat	Tanda gawat dikenali cepat; stabilisasi sesuai prioritas	Sangat cepat dan sistematis; stabilisasi tepat + antisipasi perburukan
6.2 Keputusan rujukan/kolaborasi dan persiapan aman	Indikasi rujukan tidak tepat; persiapan tidak aman	Indikasi rujukan cukup tepat namun persiapan belum lengkap	Indikasi tepat; persiapan dan komunikasi memadai	Indikasi sangat tepat; persiapan komprehensif; komunikasi jelas; monitoring selama proses terjaga

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan partograf dan catatan asuhan	Banyak data tidak tercatat/keliru; tidak konsisten	Data tercatat namun ada bagian kunci belum lengkap	Data lengkap dan konsisten; mudah ditelusuri	Sangat lengkap, rapi, konsisten; mendukung keputusan klinis secara kuat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.2 Dokumen rujukan dan evaluasi mutu berbasis data	Informasi rujukan tidak utuh; tanpa refleksi	Informasi cukup namun ringkasannya kurang jelas; refleksi dangkal	Informasi utuh; ringkasan jelas; ada temuan perbaikan	Informasi sangat utuh + prioritas jelas; refleksi tajam berbasis data dan menghasilkan rencana perbaikan konkret

Uraian Materi

Teori Dasar

Persalinan merupakan proses fisiologis yang kompleks yang menandai akhir dari masa kehamilan dan awal kehidupan ekstrauterin bagi bayi. Proses ini melibatkan interaksi antara faktor ibu, janin, dan lingkungan yang berlangsung secara dinamis dan berkesinambungan. Menurut World Health Organization (WHO, 2018), persalinan adalah serangkaian kejadian yang dimulai dari kontraksi uterus yang teratur hingga keluarnya janin, plasenta, dan selaput ketuban.

Persalinan menjadi salah satu fase paling kritis dalam siklus reproduksi karena berkontribusi besar terhadap angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Secara global, komplikasi intrapartum seperti perdarahan, infeksi, dan asfiksia masih menjadi penyebab utama kematian maternal dan neonatal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep persalinan guna memastikan asuhan yang aman dan berkualitas.

Dalam praktik kebidanan modern, pendekatan asuhan persalinan tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga mencakup pendekatan holistik yang meliputi aspek psikologis, sosial, dan emosional ibu. Konsep *woman-centered care* menekankan bahwa ibu merupakan subjek utama dalam proses persalinan yang berhak mendapatkan informasi, dukungan, dan kebebasan dalam mengambil keputusan terkait tubuhnya.

Selain itu, keselamatan pasien (*patient safety*) menjadi komponen penting dalam pelayanan intrapartum. Penerapan standar keselamatan seperti penggunaan partograf, pencegahan infeksi, serta sistem rujukan yang efektif dapat menurunkan risiko komplikasi secara signifikan. WHO (2022) menegaskan bahwa pelayanan persalinan harus dilakukan berdasarkan prinsip *evidence-based practice* untuk meningkatkan outcome ibu dan bayi.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik persalinan juga mengalami transformasi yang signifikan. Tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki kompetensi klinis yang tinggi serta kemampuan dalam menganalisis aspek etik dan legal dalam pelayanan kebidanan. Isu seperti informed consent, hak pasien, dan tanggung jawab profesional menjadi bagian integral dalam praktik asuhan persalinan.

Dalam konteks pendidikan, pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) menjadi strategi penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa kebidanan. OBE menekankan pada pencapaian hasil belajar yang terukur, termasuk kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif dalam memberikan asuhan persalinan. Dengan

demikian, pemahaman konsep persalinan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan praktik klinik.

A. Ruang lingkup, prinsip, dan standar asuhan persalinan berorientasi ibu-bayi.

Beberapa jam terakhir pada kehamilan ditandai dengan kontraksi uterus yang menyebabkan dilatasi serviks dan mendorong terjadinya penurunan janin dalam melewati jalan lahir. Banyak tenaga yang dikeluarkan pada waktu ini, sehingga pada fase persalinan sering digunakan istilah *labor* (kerja keras) yang menggambarkan proses ini. Kontraksi miometrium pada persalinan terasa nyeri, sehingga istilah nyeri persalinan digunakan untuk mendeskripsikan proses ini. Sebelum kontraksi yang kuat dan terasa nyeri ini dimulai, uterus harus dipersiapkan untuk persalinan. Pada usia kehamilan 36 sampai 38 minggu, miometrium tidak responsif atau tidak berkontraksi, setelah masa tenang yang panjang ini, diperlukan fase transisi agar ketidakresponsifan miometrium menghilang dan serviks melunak dan mendatar. Kondisi fungsional uterus terjadi selama kehamilan dan masa nifas. Kontraksi miometrium yang tidak menyebabkan dilatasi serviks dapat dirasakan kapan pun selama kehamilan. Kontraksi-kontraksi ini ditandai dengan kejadian yang tidak dapat diramalkan, intensitas rendah, dan durasinya singkat.

Rasa tidak nyaman yang ditimbulkan biasanya terbatas di abdomen bawah dan lipat paha. Menjelang akhir masa kehamilan, ketika uterus mengalami persiapan untuk bersalin, kontraksi makin sering terjadi, khususnya pada multipara, dan kadangkala disebut sebagai persalinan palsu. Pada beberapa ibu, kontraksi kuat uterus yang menimbulkan dilatasi serviks, penurunan janin, dan kelahiran konseptus dimulai secara mendadak, dan tampaknya tanpa disertai tanda dan gejala. Kontraksi dalam persalinan, Kontraksi otot polos uterus pada persalinan terasa sangat nyeri, dan hal ini merupakan sesuatu yang unik dibanding kontraksi otot fisiologis lainnya. Penyebab nyeri tidak diketahui secara pasti, diduga disebabkan oleh Hipoksia pada miometrium yang berkontraksi (seperti pada angina pectoris), penekanan ganglia saraf di serviks dan uterus bagian bawah oleh berkas-berkas otot yang saling bertautan, peregangan serviks sewaktu dilatasi dan peregangan peritonium yang terletak di atas fundus.

1. Pengertian Persalinan

Persalinan sering diistilahkan partus dan intranatal. Menurut Prawiro H persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Persalinan menurut WHO (2023) adalah pengeluaran hasil konsepsi (janin atau uri) yang telah cukup bulan (37 - 42 minggu) atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan dengan presentasi belakang kepala yang

berlangsung dalam waktu 18 jam tanpa adanya komplikasi pada ibu maupun janin. Persalinan ialah proses membuka dan menipisnya serviks, dari janin turun ke dalam jalan lahir.

Persalinan normal atau yang disebut juga partus alami adalah proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala dengan tenaga ibu sendiri, tanpa bantuan alat, dan tidak melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam. Persalinan normal ialah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) dan lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi, baik pada ibu maupun pada janin.

2. Etiologi persalinan

Sebab lainnya persalinan belum diketahui dengan jelas. Agaknya banyak faktor yang memegang peranan dan bekerjasama sehingga terjadi persalinan. Beberapa teori yang dikemukakan adalah: penurunan kadar progesteron, teori oksitosin, keregangan otot-otot, pengaruh janin, dan teori prostaglandin. Beberapa teori yang menyebabkan lainnya persalinan adalah sebagai berikut :

- a. Penurunan kadar progesteron menimbulkan relaxasi otot-otot rahim, sebaliknya estrogen meningkatkan kerentanan otot rahim. Selama kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen dalam darah, tetapi pada akhir kehamilan kadar progesteron menurun sehingga timbul his. Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 minggu, dimana terjadi penimbunan jaringan ikat, dan pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu. Produksi progesterone mengalami penurunan, sehingga otot rahim lebih sensitive terhadap oksitosin. Akibatnya otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesterone tertentu.
- b. Teori oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis pars posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesterone dapat mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi Braxton Hicks. Di akhir kehamilan kadar progesteron menurun sehingga oksitocin bertambah dan meningkatkan aktivitas otot-otot rahim yang memicu terjadinya kontraksi sehingga terdapat tanda-tanda persalinan.
- c. Keregangan Otot-otot. Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Setelah melewati batas tertentu terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. Seperti halnya dengan Bladder dan Lambung, bila dindingnya teregang oleh isi yang bertambah maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim, maka dengan majunya kehamilan makin teregang otot-otot dan otot-otot rahim makin rentan.

Contoh, pada kehamilan ganda sering terjadi kontraksi setelah keregangan tertentu sehingga menimbulkan proses persalinan.

- d. Pengaruh janin hipofise dan kelenjar suprarenal janin juga memegang peranan karena pada anencephalus kehamilan sering lebih lama dari biasa, karena tidak terbentuk hipotalamus. Pemberian kortikosteroid dapat menyebabkan maturasi janin, dan induksi (mulainya) persalinan.
- e. Teori Prostaglandin, konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu yang dikeluarkan oleh desidua. Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua diduga menjadi salah satu sebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa prostaglandin F2 atau E2 yang diberikan secara intravena, intra dan extra amnial menimbulkan kontraksi miometrium pada setiap umur kehamilan. Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dapat keluar. Prostaglandin dapat dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan. Hal ini juga didukung dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi baik dalam air ketuban maupun daerah perifer pada ibu hamil, sebelum melahirkan atau selama persalinan.

3. Tahapan persalinan

Persalinan dianggap "normal," jika wanita berada terdapat satu janin dengan presentasi puncak kepala, dan persalinan selesai dalam 24 jam. Proses persalinan normal yang berlangsung sangat konstan terdiri dari (1) kemajuan teratur kontraksi uterus, (2) penipisan dan dilatasi serviks yang progresif, dan (3) kemajuan penurunan bagian presentasi. Tahap persalinan dimulai dari ada tanda inpartu. Adapun tanda inpartu adalah keluar lendir campur darah (*blood show*), terdapat pembukaan dan dilatasi serviks serta terdapat kontraksi uterus (his) minimal 2 kali dalam 10 menit durasi 30 detik. Ada empat dibahas lebih terinci bersama asuhan kebidanan tahap persalinan yang dikenal.

Dalam persalinan terdapat 4 (empat) tahap/kala :

a. Persalinan Kala I

Tahap pertama persalinan ditetapkan sebagai tahap yang berlangsung sejak terjadi kontraksi uterus yang teratur sampai dilatasi serviks lengkap. Asuhan dimulai ketika pasien mengeluh tanda-tanda berikut: ada kontraksi uterus yang progresif, teratur, meningkat kekuatan, frekuensi dan durasinya, adanya pengeluaran lendir campur darah (*bloody show*) dan ada pembukaan dan dilatasi serviks. *Bloody show* atau lendir yang bersemu darah berasal dari lendir kanalis servikalis karena serviks mulai membuka dan mendatar, sedangkan darahnya berasal dari pembuluh-pembuluh kapiler yang berada disekitar

kanalis servikalis itu pecah karena pergeseran-pergeseran ketika serviks membuka.

Proses membukanya serviks sebagai akibat his dibagi dalam 2 fase yaitu :

- 1) Fase laten yaitu berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm. Sedangkan WHO mendefinisikan fase laten adalah periode waktu persalinan yang ditandai oleh nyeri kontraksi rahim, disertai penipisan servik dan terjadi perlambatan pembukaan servik sampai 5 cm untuk awal dan kelanjutan persalinan.
- 2) Fase aktif adalah periode waktu persalinan yang ditandai dengan nyeri kontraksi Rahim yang teratur, derajat penipisan servik sudah tipis dan pembukaan servik cepat, mulai 5 cm sampai pembukaan lengkap. Fase aktif dibagi menjadi 3 (tiga) fase yaitu (1) fase akselerasi adalah dalam 2 (dua) jam pembukaan 3 cm tadi menjadi 4 cm, (2) fase dilatasi maksimal yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm, (3) fase deselerasi yaitu pembukaan menjadi lambat kembali dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap. Fase-fase tersebut dijumpai pada primigravida, pada multigravida terjadi juga akan tetapi fase laten, fase aktif, dan fase deselerasi terjadi lebih pendek.

Mekanisme pembukaan serviks berbeda antara primigravida dan multigravida. Pada yang pertama ostium uteri internum akan membuka lebih dahulu, sehingga serviks akan mendatar dan menipis, baru kemudian diikuti dengan pembukaan ostium uteri eksternum. Pada multigravida ostium uteri internum sudah sedikit, ostium uteri internum dan eksternum serta penipisan dan pendataran serviks terjadi dalam saat yang sama. Ketuban akan pecah dengan sendiri ketika pembukaan hampir atau telah lengkap. Tidak jarang ketuban harus dipecahkan ketika pembukaan hampir lengkap atau telah lengkap.

Kala I selesai apabila pembukaan serviks uteri telah lengkap. Pada primigravida kala I berlangsung kira-kira 13 jam, sedangkan pada multipara kira-kira 7 jam. WHO merekomendasikan Ibu harus diberi tahu bahwa standar durasi kala I fase laten belum ditetapkan dan sangat bervariasi dari satu wanita ke wanita lain. Namun, durasi kala I aktif (dari 5 cm sampai pembukaan serviks lengkap) biasanya tidak lebih dari 12 jam pada persalinan pertama, dan biasanya tidak lebih dari 10 jam pada persalinan berikutnya.

Pada wanita hamil dengan awal persalinan spontan, dilatasi servik mengalami kemajuan 1 cm/jam selama kala I fase aktif (tergambar pada garis waspada dalam partogram), tidak akurat digunakan pada kasus ibu bersalin dengan risiko, tidak direkomendasikan pada kondisi ini. Pada kemajuan kala I persalinan Laju pembukaan serviks minimal 1 cm/jam selama kala satu fase

aktif tidak terlalu cepat untuk beberapa wanita dan oleh karena itu tidak direkomendasikan untuk mengidentifikasi kemajuan persalinan normal. Laju pembukaan serviks yang lebih lambat dari 1 cm/jam saja tidak boleh menjadi rutinitas indikasi intervensi obstetri. Persalinan mungkin tidak berakselerasi secara alami sampai ambang pembukaan serviks 5 cm tercapai. Oleh karena itu penggunaan intervensi medis untuk mempercepat persalinan dan kelahiran (seperti pemberian oksitosin atau operasi caesar) sebelum ambang batas ini tidak dianjurkan, asalkan kondisi janin dan ibu baik.

Pada umumnya, awitan persalinan sulit ditentukan. Wanita mungkin datang ke bangsal dalam keadaan hampir melahirkan, sehingga awitan persalinan hanya dapat diperkirakan. Tahap pertama biasanya berlangsung jauh lebih lama daripada waktu yang diperlukan untuk tahap kedua dan ketiga. Akan tetapi, banyak variasi yang terjadi, tergantung pada faktor-faktor esensial. Dilatasi lengkap dapat berlangsung kurang dari satu jam pada sebagian kehamilan multipara. Pada kehamilan pertama, dilatasi serviks jarang terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam.

b. Persalinan kala II

Tahap persalinan kedua dimulai dari pembukaan serviks lengkap sampai bayi lahir. Penggunaan definisi dan durasi kala dua persalinan berikut ini direkomendasikan oleh WHO untuk praktik. Kala II adalah periode waktu antara pembukaan serviks lengkap dan kelahiran bayi, di mana wanita memiliki dorongan yang tidak disengaja untuk mengejan, sebagai akibat dari ekspulsi dan kontraksi rahim. Ibu harus diberitahu bahwa durasi kala II bervariasi dari satu wanita ke wanita lainnya. Pada persalinan pertama, kelahiran biasanya selesai dalam waktu 3 jam sedangkan pada persalinan berikutnya, kelahiran biasanya selesai dalam waktu 2 jam. Pada kala II his menjadi lebih kuat dan lebih cepat, kira-kira 2 sampai 3 menit sekali. Karena biasanya dalam hal ini kepala janin sudah masuk di ruang panggul, maka pada his dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara reflektoris menimbulkan rasa mengedan. Wanita merasa pula tekanan kepada rektum dan hendak buang air besar. Kemudian perineum mulai menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka. Labia mulai membuka dan tidak lama kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada waktu his. Bila dasar panggul sudah lebih berelaksasi, kepala janin tidak masuk lagi di luar his, dan dengan his dan kekuatan mengedan maksimal kepala janin dilahirkan dengan suboksiput di bawah simfisis dan dahi, muka, dan dagu melewati perineum. Setelah istirahat sebentar, his mulai lagi untuk mengeluarkan badan, dan anggota bayi. Para

primigravida kala II berlangsung rata-rata 1,5 jam dan pada multipara rata-rata 0,5 jam.

Mekanisme persalinan adalah serangkaian gerakan janin saat melewati jalan lahir akibat interaksi antara kekuatan (*power*), jalan lahir (*passage*) dan janin (*passenger*). Mekanisme persalinan terdiri dari 7 (tujuh) tahap yaitu :

1) Masuknya kepala janin dalam Pintu Atas Panggul (PAP) (Engagement).

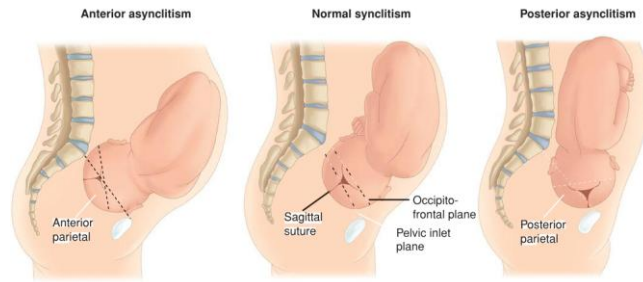
Masuknya kepala ke dalam PAP terutama pada primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan tetapi pada multipara biasanya terjadi pada permulaan persalinan. Masuknya kepala ke dalam PAP biasanya dengan sutura sagitalis melintang menyesuaikan dengan letak punggung (Contoh: apabila dalam palpasi didapatkan punggung kiri maka sutura sagitalis akan teraba melintang kekiri/ posisi jam 3 atau sebaliknya apabila punggung kanan maka sutura sagitalis melintang ke kanan/posisi jam 9) dan pada saat itu kepala dalam posisi fleksi ringan. Jika sutura sagitalis dalam diameter anteroposterior dari PAP maka masuknya kepala akan menjadi sulit karena menempati ukuran yang terkecil dari PAP.



Gambar 1.1 Posisi bagian terendah memasuki PAP

Jika sutura sagitalis pada posisi di tengah-tengah jalan lahir yaitu tepat di antara symphysis dan promontorium, maka dikatakan dalam posisi "synclitismus" pada posisi synclitismus os parietale depan dan belakang sama tingginya. Jika sutura sagitalis agak ke depan mendekati symphysis atau agak ke belakang mendekati promontorium, maka yang kita hadapi adalah posisi "asynclitismus"

Acynclitismus posterior adalah posisi sutura sagitalis mendekati symphysis dan os parietale belakang lebih rendah dari os parietale depan. Acynclitismus anterior adalah posisi sutura sagitalis mendekati promontorium sehingga os parietale depan lebih rendah dari os parietale belakang Pada saat kepala masuk PAP biasanya dalam posisi asynclitismus posterior ringan. Pada saat kepala janin masuk PAP akan terfiksasi yang disebut dengan engagement.



Gambar 1.2 Posisi bagian terendah memasuki PAP berdasarkan sutura sagitalis

2) Maju/turunnya Kepala janin (Descent)

Pada primi gravida majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala II. Pada multigravida majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi bersamaan. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan-gerakan yang lain yaitu: fleksi, putaran paksi dalam, dan ekstensi. Majunya kepala disebabkan karena: tekanan cairan intrauterine, tekanan langsung oleh fundus uteri oleh bokong, kekuatan mengejan dan melurusnya badan bayi oleh perubahan bentuk rahim.

3) Fleksi

Fleksi kepala janin memasuki ruang panggul dengan ukuran yang paling kecil yaitu dengan diameter suboccipito bregmatikus (9,5 cm) menggantikan suboccipito frontalis (11 cm). Fleksi disebabkan karena janin didorong maju dan sebaliknya mendapat tahanan dari pinggir PAP, cervix, dinding panggul atau dasar panggul akibat adanya dorongan di atas kepala janin menjadi fleksi karena momement yang menimbulkan fleksi lebih besar daripada moment yang menimbulkan defleksi sampai di dasar panggul kepala janin berada dalam posisi fleksi maksimal. Kepala turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke bawah depan akibat kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intra uterin yang disebabkan oleh his yang berulang-ulang, kepala mengadakan rotasi yang disebut sebagai putaran paksi dalam.

4) Putaran paksi dalam

Putaran paksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan ke bawah symphysis. Pada presentasi belakang kepala bagian terendah adalah daerah ubun-ubun kecil dan bagian ini akan memutar ke depan ke bawah symphysis.

Putaran paksi dalam mutlak diperlukan untuk kelahiran kepala, karena putaran paksi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir khususnya bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul.

Putaran paksi dalam terjadi bersamaan dengan majunya kepala dan tidak terjadi sebelum kepala sampai di Hodge III, kadang-kadang baru terjadi setelah kepala sampai di dasar panggul. Sebab-sebab terjadinya putaran paksi dalam adalah pada letak fleksi, bagian kepala merupakan bagian terendah dari kepala. Bagian terendah dari kepala mencari tahanan yang paling sedikit terdapat sebelah depan atas dimana terdapat hiatus genitalis antara muskulus levator ani kiri dan kanan. Ukuran terbesar dari bidang tengah panggul ialah diameter anteroposterior.

5) Ekstensi

Setelah putaran paksi dalam selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan di atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk dapat melewati pintu bawah panggul. Dalam rotasi UUK akan berputar ke arah depan, sehingga di dasar panggul UUK berada di bawah simfisis, dengan suboksiput sebagai hipomoklion kepala mengadakan gerakan defleksi untuk dapat dilahirkan. Pada saat ada his vulva akan lebih membuka dan kepala janin makin tampak. Perineum menjadi makin lebar dan tipis, anus membuka dinding rektum. Dengan kekuatan his dan kekuatan mengejan, maka berturut-turut tampak bregmatikus, dahi, muka, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Sesudah kepala lahir, kepala segera mengadakan rotasi, yang disebut putaran paksi luar.

6) Putaran paksi luar

Putaran paksi luar adalah gerakan kembali sebelum putaran paksi dalam terjadi, untuk menyesuaikan kedudukan kepala dengan punggung janin. Bahu melintasi PAP dalam posisi miring. Di dalam rongga panggul bahu akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul yang dilaluinya hingga di dasar panggul, apabila kepala telah dilahirkan bahu akan berada dalam posisi depan belakang. Selanjutnya dilahirkan bahu depan terlebih dulu baru kemudian bahu belakang, kemudian bayi lahir seluruhnya.

7) Ekspulsi

Pengeluaran janin, setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai hypomochlion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian setelah

kedua bahu lahir disusul lahirlah trochanter depan dan belakang sampai lahir janin seluruhnya. Gerakan kelahiran bahu depan, bahu belakang dan seluruhnya

c. Persalinan Kala III

Tahap ketiga persalinan didefinisikan sebagai periode waktu antara kelahiran janin hingga keluarnya plasenta. Selama tahap ketiga persalinan normal, kontraksi uterus menyebabkan pemisahan dan pengeluaran plasenta dari uterus. Perdarahan postpartum merupakan komplikasi yang relatif umum pada tahap ketiga persalinan. Berbagai strategi telah dipelajari untuk mengurangi risiko perdarahan postpartum, yang mengarah pada penerapan manajemen aktif tahap ketiga persalinan secara luas. Awalnya, manajemen aktif tahap ketiga persalinan terdiri dari serangkaian intervensi termasuk pemberian agen uterotonik, penjepitan tali pusat dini, peregangan tali pusat terkendali dan masase/pijat uterus eksternal.

Efektivitas intervensi ini sebagai satu paket telah dipertanyakan, yang menyebabkan beberapa komponennya ditinggalkan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, setelah meninjau beberapa pedoman internasional terpilih, kami menemukan bahwa istilah "manajemen aktif tahap ketiga persalinan" masih digunakan, tetapi rekomendasi untuk dan terhadap intervensi individual bervariasi dan tidak selalu didukung oleh bukti terkini.

Selama tahap ketiga persalinan, rahim berkontraksi, menyebabkan pemisahan dan pengeluaran plasenta. Kontraksi rahim ini terjadi pada intensitas kontraksi miometrium yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahap persalinan sebelumnya, dan membantu melepaskan plasenta dari dinding rahim, mengurangi ukuran dasar plasenta dan menutup aliran darahnya. Tanda-tanda khas pemisahan plasenta meliputi kontraksi rahim, yang seringkali mengubah bentuk fundus menjadi lebih bulat, keluarnya darah deras dari vagina, dan pemanjangan tali pusat. Deskripsi awal tentang tahap ketiga persalinan melaporkan bahwa plasenta biasanya dikeluarkan setelah 2 hingga 3 kontraksi rahim selama 6 hingga 10 menit setelah kelahiran janin. Dalam sebuah studi besar tentang persalinan tunggal cukup bulan, median durasi tahap ketiga persalinan adalah 6 menit (rentang interkuartil, 10 menit), dan kejadian komplikasi meningkat setelah 30 menit tanpa pengeluaran plasenta. Tahap ketiga persalinan berbeda menurut usia kehamilan, dengan durasi yang semakin pendek seiring bertambahnya usia kehamilan. Kehilangan darah pascapersalinan normal selama kehamilan, ekspansi volume darah memberikan banyak manfaat fisiologis, salah satunya adalah mengurangi dampak kehilangan darah pascapersalinan.

Sistem koagulasi tubuh juga berkontribusi untuk mendukung pembentukan bekuan dan penghentian kehilangan darah. Kehilangan darah normal setelah melahirkan sangat bervariasi. Sebagian besar wanita dapat mentolerir hingga 1000 mL kehilangan darah tanpa konsekuensi kesehatan dan mungkin tidak mulai mengalami perubahan hemodinamik sampai kehilangan darah melebihi 25% dari volume darah sebelum melahirkan. Riwayat kesehatan setiap wanita, termasuk komorbiditas medis seperti anemia atau perdarahan antepartum, dapat melibatkan peningkatan risiko hipovolemia simptomatik, dan konsekuensi yang lebih besar dari tingkat kehilangan darah yang lebih rendah. Anemia pasca persalinan dapat menyebabkan konsekuensi yang substansial termasuk gangguan fisik, tekanan emosional, depresi pasca persalinan, dan kematian, dan juga dapat mengganggu kemampuan untuk merawat bayi baru lahir.

d. Persalinan Kala IV

Dua jam pertama setelah persalinan merupakan waktu yang kritis bagi ibu dan bayi. Keduanya baru saja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, ibu melahirkan bayi dari perutnya dan bayi sedang menyesuaikan diri dari dalam perut ibu ke dunia luar. Petugas/bidan harus tinggal bersama ibu dan bayi untuk memastikan bahwa keduanya dalam kondisi yang stabil dan mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan stabilisasi.

4. Prinsip persalinan

Asuhan yang dilakukan selama proses persalinan dan kelahiran bayi adalah

a. 1.3.4.1 Asuhan sayang ibu

Asuhan yang aman, berdasarkan temuan, dan turut meningkatkan angka kelangsungan hidup ibu. Prinsip asuhan sayang ibu meliputi : (1) Membantu ibu merasa nyaman dan aman selama proses persalinan, (2) Menghargai kebiasaan budaya, praktek keagamaan dan kepercayaan, (3) Melibatkan ibu dan keluarga sebagai pembuat keputusan, secara emosional sifatnya mendukung, (4) Mengikut sertakan suami dan keluarga selama proses persalinan dan kelahiran bayi. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ibu diperhatikan dan diberikan dukungan selama persalinan dan kelahiran bayi serta mengetahui dengan baik mengenai proses persalinan dan asuhan yang akan mereka terima, mereka akan mendapatkan rasa aman dan hasil yang diperoleh akan lebih baik serta dapat mengurangi persalinan dengan tindakan

atau seksiosesaria, dan persalinan berlangsung lebih cepat. Melindungi hak-hak ibu untuk mendapatkan privasi dan menggunakan sentuhan hanya seperlunya. Intervensi medis (persalinan sesar, episiotomi) dan tindakan invasif yang berlebihan (pemeriksaan vagina berulang) berdampak negatif terhadap nilai asuhan sayang ibu, sehingga penting untuk mempromosikan perawatan yang berpusat pada perempuan yang melindungi hak perempuan atas tubuh mereka. Dengan demikian, perempuan yang menderita komplikasi seperti perdarahan pascapersalinan dan persalinan yang berkepanjangan tetap dapat memiliki pengalaman persalinan yang baik.

b. Komunikasi efektif

WHO merekomendasikan komunikasi efektif antara bidan/tenaga kesehatan dengan ibu bersalin menggunakan metode sederhana dan dapat diterima secara budaya.

c. Asuhan berkelanjutan

WHO merekomendasikan model asuhan kebidanan berkelanjutan yang dikelola oleh bidan, seperti diketahui bahwa bidan maupun sekelompok bidan mendukung dalam memberikan asuhan menyeluruh pada saat kehamilan, persalinan dan nifas berkelanjutan, direkomendasikan untuk program kebidanan pada ibu hamil dapat berfungsi dengan baik.

d. Asuhan sayang bayi

Pada bayi lahir dengan air ketuban jernih, bernafas spontan, hisap lendir tidak dianjurkan, Bayi baru lahir tanpa komplikasi harus tetap melakukan kontak kulit ke kulit (skin-to-skin contact/SSC) dengan ibunya selama satu jam pertama setelah lahir untuk mencegah hipotermia dan mendorong pemberian ASI, Semua bayi baru lahir, termasuk bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang dapat disusui, harus disusui sesegera mungkin setelah lahir ketika mereka secara klinis stabil, dan ibu dan bayinya siap, Semua bayi baru lahir harus diberikan 1 mg vitamin K secara intramuskular setelah lahir (yaitu setelah satu jam pertama saat bayi melakukan kontak kulit-ke-kulit dengan ibu dan menyusui), mandi harus ditunda sampai 24 jam setelah melahirkan. Jika hal ini tidak memungkinkan karena alasan budaya, mandi harus ditunda untuk perawatan pasca kelahiran yang direkomendasikan setidaknya enam jam, pakaian bayi yang sesuai untuk lingkungan bayi yang baru lahir suhu dianjurkan, ini berarti satu sampai dua lapisan pakaian lebih dari orang dewasa, dan penggunaan topi/topi, ibu dan bayi tidak boleh dipisahkan dan harus tinggal di kamar yang sama 24 jam sehari.

5. Standar asuhan persalinan berorientasi pada ibu dan bayi

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan, bidan memberikan asuhan kebidanan yang bersifat holistik, humanistik berdasarkan evidence based dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan, dan memperhatikan aspek fisik, psikologi, emosional, sosial budaya, spiritual, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kewenangannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Standar asuhan persalinan berorientasi pada ibu dan bayi menurut Kepmenkes nomor 320 tahun 2020 meliputi :

- Pemeriksaan fisik terfokus dalam persalinan
- Penapisan awal persalinan
- Penentuan inpartu
- Dukungan fisik dan psikologis dalam persalinan
- Pemantauan persalinan dengan partograph
- Penilaian rupture uteri
- Penilaian kesesuaian antara panggul dan janin dari hasil pemeriksaan palpasi dan panggul dalam
- Asuhan persalinan Kala I normal
- Teknik mengurangi nyeri secara nonfarmakologi selama persalinan dan kelahiran
- Teknik mengurangi nyeri secara farmakologi dalam persalinan dan kelahiran dengan kolaborasi
- Amniotomi saat kala II
- Anastesi Perineum
- Episiotomi
- Pertolongan persalinan Kala II normal
- Jepit, potong dan ikat tali pusat
- Inisiasi Menyusu Dini
- Pertolongan persalinan Kala III normal
- Manajemen Aktif kala III
- Pemeriksaan placenta (kotiledon, selaput dan kelainan)
- Pemeriksaan jumlah pengeluaran darah pervaginam
- Pemeriksaan luka jalan lahir
- Penjahitan Luka Jalan Lahir derajat 1 dan 2
- Penjahitan Luka Jalan Lahir derajat 3, 4 dan luka portio dengan rujukan
- Pemasangan IUD pasca plasenta

- Pemantauan persalinan Kala IV
- Manual Placenta dengan perdarahan dengan kolaborasi
- Kompresi Bimanual (Eksterna, Interna) dengan kolaborasi
- Kompresi Bimanual Aorta dengan kolaborasi

B. Isu etik–legal, hak pasien, dan keselamatan intrapartum pada skenario pelayanan.

1. Isu etik-legal

Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar, serta membutuhkan pembuktian. Issue etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya. Issue moral adalah topik yang penting berhubungan dengan benar dan salah kehidupan sehari - hari. Dilema yaitu suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternatif pilihan, yang sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah, terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau Dilema dalam kelihatannya muncul karena pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada.

2. Hak pasien

Hak Ibu dalam Persalinan diantaranya yaitu mendapatkan informasi, memberikan persetujuan tindakan (*informed consent*), menjaga privasi, didampingi, bebas dari kekerasan.

3. Keselamatan intrapartum

a. Pengertian keselamatan pasien

Suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Penyelenggaraan keselamatan pasien

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien, pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan:

standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien dan tujuh langkah menuju keselamatan pasien. Sistem pelayanan harus menjamin pelaksanaan:

- 1) Asuhan pasien lebih aman, melalui upaya yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien
- 2) Pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjutnya
- 3) Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

c. Standar keselamatan pasien

Standar keselamatan pasien meliputi hak pasien, pendidikan bagi pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.

d. Kriteria standar keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan

Kriteria standar keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan meliputi pelayanan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan, pemindahan pasien, rujukan, dan saat pasien keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan, koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan ketersediaan sumber daya fasilitas pelayanan kesehatan, koordinasi pelayanan dalam meningkatkan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, asuhan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi, rujukan, dan tindak lanjut lainnya dan komunikasi dan penyampaian informasi antar profesi kesehatan sehingga tercapai proses koordinasi yang efektif.

e. Keselamatan intrapartum

Safe Intrapartum Care Evidence-based practices during active labour and delivery	
01 Continuous Fetal Monitoring CTG for high-risk; intermittent auscultation for low-risk. Document findings every 15–30 min. Escalate decelerations promptly.	02 Active Labour Management WHO partograph use reduces prolonged labour. Augmentation only when clinically indicated with senior review.
03 Infection Control During Delivery Sterile technique for all invasive procedures. Prophylactic antibiotics for GBS-positive mothers.	04 Pain Management Safety Epidural requires anaesthetic consent, monitoring of maternal BP, and continuous FHR assessment.
05 Active Management of Third Stage Oxytocin 10 IU IM within 1 min of birth. Controlled cord traction. Assess uterine tone.	06 Perineal Care & Repair Structured assessment of tears (Grade I–IV). Aseptic repair with appropriate suturing technique.

Gambar 1.3 Keselamatan Impatrum

C. Latihan Soal

- Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 39 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mulas teratur sejak tadi malam. Hasil anamnesis : keluar lendir campur darah sejak tadi malam dan tidak ada pengeluaran air. Hasil pemeriksaan : TD 120/80 mmHg, N 80 x/menit, P 20 x/menit, S 36,8°C, TFU 32 cm, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ 140 x/menit, PD serviks 4 cm, ketuban (+), denominator sutura sagitalis melintang, kepala turun Hodge II.
Apa masalah yang paling tepat pada kasus tersebut ?
 A. Ketidaknyamanan (mulas)
 B. Keluar lendir campur darah
 C. Persalinan Kala I fase aktif
 D. His kuat
 E. Air ketuban belum keluar
- Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 39 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mulas teratur sejak tadi malam. Hasil anamnesis : keluar lendir campur darah sejak tadi malam dan tidak ada pengeluaran air. Hasil pemeriksaan : TD 120/80 mmHg, N 80 x/menit, P 20 x/menit, S 36,8°C, TFU 32 cm, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ 140 x/menit, PD serviks 4 cm, ketuban (+), denominator sutura sagitalis melintang, kepala turun Hodge II.
Apa penyebab terjadinya pengeluaran lendir pada kasus tersebut ?
 A. Adanya peregangan otot-otot rahim

- B. Peningkatan hormon progesteron
 - C. Pembukaan dan pendataran serviks
 - D. Produksi prostaglandin
 - E. Pergeseran-pergeseran ketika serviks membuka
3. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mulas teratur sejak tadi malam. Hasil anamnesis : keluar lendir campur darah sejak tadi malam dan tidak ada pengeluaran air. Hasil pemeriksaan : TD 120/80 mmHg, N 80 x/menit, P 20 x/menit, S 36,8°C, TFU 32 cm, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ 140 x/menit, PD serviks 4 cm, ketuban (+), denominator sutura sagitalis melintang, kepala turun Hodge II.
Apa penyebab terjadinya pengeluaran darah pada kasus tersebut ?
- A. Adanya peregangan otot-otot rahim
 - B. Peningkatan hormon progesteron
 - C. Pembukaan dan pendataran serviks
 - D. Produksi prostaglandin
 - E. Pergeseran-pergeseran ketika serviks membuka
4. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mulas teratur sejak tadi malam. Hasil anamnesis : keluar lendir campur darah sejak tadi malam dan tidak ada pengeluaran air. Hasil pemeriksaan : TD 120/80 mmHg, N 80 x/menit, P 20 x/menit, S 36,8°C, TFU 32 cm, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ 140 x/menit, PD serviks 4 cm, ketuban (+), denominator sutura sagitalis melintang, kepala turun Hodge II.
Apa diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut ?
- A. Belum inpartu
 - B. Inpartu kala I fase laten
 - C. Inpartu kala I fase aktif
 - D. Inpartu kala II
 - E. Inpartu kala III
5. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mulas teratur sejak tadi malam. Hasil anamnesis : keluar lendir campur darah sejak tadi malam dan tidak ada pengeluaran air. Hasil pemeriksaan : TD 120/80 mmHg, N 80 x/menit, P 20 x/menit, S 36,8°C, TFU 32 cm, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ 140 x/menit, PD serviks 4 cm, ketuban (+), denominator sutura sagitalis melintang, kepala turun Hodge II. Bidan melibatkan keluarga dalam mendampingi ibu selama proses persalinan.

Apa sikap bidan yang paling tepat pada kasus tersebut ?

- A. Asuhan sayang ibu
- B. Komunikasi efektif
- C. Asuhan berkelanjutan
- D. Keselamatan pasien
- E. Menerapkan etika kebidanan

Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. C
- 3. E
- 4. C
- 5. A

D. Portofolio

Tabel. Case Report pada persalinan

Komponen	Deskripsi	Persalinan Kala I
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang diamati/diobservasi oleh mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu bersalin multigravida dengan persalinan fase aktif
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, dan kebutuhan ibu.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan identitas pasien, keluhan mulas disertai pengeluaran lendir bercampur darah tanpa disertai pengeluaran air, Hasil pemeriksaan : TD 120/80 mmHg, N 80 x/menit, P 20

Komponen	Deskripsi	Persalinan Kala I
		x/menit, S 36,8°C, TFU 32 cm, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ 140 x/menit, PD serviks 4 cm, ketuban utuh, denominator sutura sagitalis melintang, kepala turun Hodge II, dan menuliskan penyebab dari keluhan yang dialami ibu.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan penyebab dari keluhan dengan kasus yang ditemukan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus persalinan kala I fase aktif, mahasiswa belajar bahwa mengetahui keluhan dan masalah yang dialami oleh pasien adalah kasus yang fisiologis merupakan inti keselamatan dalam asuhan persalinan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep persalinan kala I fase aktif, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada persalinan kala I fase aktif

Komponen	Deskripsi	Kasus persalinan kala I fase aktif dan pemeriksaan obstetri
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus persalinan kala I fase aktif, mahasiswa merefleksikan bahwa pemeriksaan obstetri yang mendukung/sesuai dengan masalah ibu dapat menjaga keselamatan pasien.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran	Mahasiswa memahami bahwa dengan memperhatikan keluhan dan melakukan

	mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	pemeriksaan obstetric yang tepat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah persalinan kala I fase aktif memanjang, gawat janin, kelelahan ibu, dan keterlambatan penanganan bila kemajuan persalinan tidak dipantau dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain kesalahan diagnosis persalinan kala I fase aktif, salah menilai penurunan kepala, pemantauan DJJ yang tidak adekuat, penggunaan stimulasi persalinan yang tidak tepat, dan pemeriksaan obstetri yang tidak kompeten.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya melakukan pengkajian, dan pemeriksaan fisik dan obstetri, pemantauan tanda vital dan DJJ.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada persalinan kala I fase aktif adalah kasus yang fisiologis dan tidak perlu ada intervensi di luar asuhan persalinan serta merupakan bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu memahami teori saja, akan tetapi juga mampu mengaplikasikan teori persalinan kala I fase aktif

■ CHECKLIST KESELAMATAN PASIEN PERSALINAN

Nama Mahasiswa : _____
Tingkat/Semester : _____
Tanggal : _____
Observer : _____

1. IDENTIFIKASI PASIEN

No	Kriteria	Ya	Tidak
1	Menggunakan ≥ 2 identitas pasien	☐	☐
2	Verifikasi sebelum tindakan	☐	☐
3	Gelang identitas terpasang	☐	☐

2. KOMUNIKASI EFEKTIF

No	Kriteria	Ya	Tidak
1	Menggunakan SBAR	☐	☐
2	Memberikan informasi jelas	☐	☐
3	Melibatkan keluarga	☐	☐

3. KEAMANAN TINDAKAN MEDIS

No	Kriteria	Ya	Tidak
1	Informed consent tersedia	☐	☐
2	Tindakan sesuai SOP	☐	☐
3	Alat & obat dicek	☐	☐

4. PENCEGAHAN INFEKSI

No	Kriteria	Ya	Tidak
1	Cuci tangan 5 momen	☐	☐
2	APD sesuai indikasi	☐	☐
3	Teknik aseptik benar	☐	☐

5. KESELAMATAN IBU

No	Kriteria	Ya	Tidak
1	Pemantauan partograf	☐	☐
2	Deteksi dini komplikasi	☐	☐
3	AMTSL dilakukan	☐	☐

6. KESELAMATAN BAYI

No	Kriteria	Ya	Tidak
1	Penilaian APGAR	☐	☐
2	Kontak kulit ke kulit	☐	☐
3	IMD dilakukan	☐	☐

7. PENCEGAHAN CEDERA

No	Kriteria	Ya	Tidak
1	Posisi ibu aman	☐	☐
2	Lingkungan aman	☐	☐
3	Pengawasan adekuat	☐	☐

PENILAIAN

Total Skor : _____ / _____

Kategori:

- $\geq 80\%$ = Baik
- 60–79% = Cukup
- $< 60\%$ = Kurang

LEMBAR AUDIT KESELAMATAN PASIEN

Audite : _____

Tanggal : _____

Auditor : _____

HASIL AUDIT

No	Komponen	Skor Maks	Skor
1	Identifikasi pasien	3	___
2	Komunikasi	3	___
3	Tindakan medis	3	___
4	Pencegahan infeksi	3	___
5	Keselamatan ibu	3	___
6	Keselamatan bayi	3	___
7	Pencegahan cedera	3	___
Total		21	___

TEMUAN

- _____
- _____

REKOMENDASI

- _____

TINDAK LANJUT

- ☐ Edukasi
- ☐ Supervisi
- ☐ Audit ulang

E. Ringkasan

Persalinan merupakan proses fisiologis yang kompleks yang menandai akhir dari masa kehamilan dan awal kehidupan ekstrauterin bagi bayi. Proses ini melibatkan interaksi antara faktor ibu, janin, dan lingkungan yang berlangsung secara dinamis dan berkesinambungan. Menurut World Health Organization (WHO, 2018), persalinan adalah serangkaian kejadian yang dimulai dari kontraksi uterus yang teratur hingga keluarnya janin, plasenta, dan selaput ketuban. Beberapa teori yang menyebabkan mulainya persalinan antara lain: penurunan kadar progesteron, teori oksitosin, keregangan otot-otot, pengaruh janin hipofise dan kelenjar suprarenal janin dan teori prostaglandin.

Proses persalinan normal yang berlangsung sangat konstan terdiri dari (1) kemajuan teratur kontraksi uterus, (2) penipisan dan dilatasi serviks yang progresif, dan (3) kemajuan penurunan bagian presentasi. Tahap persalinan dimulai dari ada tanda inpartu. Adapun tanda inpartu adalah keluar lendir campur darah (blood show), terdapat pembukaan dan dilatasi serviks serta terdapat kontraksi uterus (his) minimal 2 kali dalam 10 menit durasi 30 detik. Ada empat tahap atau kala dalam persalinan yaitu kala I dimulai dari adanya tanda inpartu sampai pembukaan lengkap, Kala II mulai pembukaan lengkap sampai keluarnya bayi, kala III di mulai dari keluarnya bayi sampai lahirnya plasenta dan kala IV dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam postpartum.

Dalam praktik kebidanan modern, pendekatan asuhan persalinan tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga mencakup pendekatan holistik yang meliputi aspek psikologis, sosial, dan emosional ibu. Konsep *woman-centered care* menekankan bahwa ibu merupakan subjek utama dalam proses persalinan yang berhak mendapatkan informasi, dukungan, dan kebebasan dalam mengambil keputusan terkait tubuhnya.

Selain itu, keselamatan pasien (*patient safety*) menjadi komponen penting dalam pelayanan intrapartum. Penerapan standar keselamatan seperti penggunaan partograf, pencegahan infeksi, serta sistem rujukan yang efektif dapat menurunkan risiko komplikasi secara signifikan. WHO (2022) menegaskan bahwa pelayanan persalinan harus dilakukan berdasarkan prinsip *evidence-based practice* untuk meningkatkan outcome ibu dan bayi.

F. Tabel Red Flags & Eskalasi

Konsep persalinan : persalinan kala I fase aktif dan pemeriksaan obstetri

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pembukaan serviks tidak menunjukkan kemajuan bermakna pada pemantauan serial	Persalinan tidak maju dan perlu evaluasi lebih lanjut terhadap power, passenger, dan passage	Lapor ke pembimbing/DPJP, evaluasi ulang lengkap, siapkan kolaborasi atau rujukan
Kepala janin tetap tinggi atau tidak turun meskipun his adekuat	Curiga distosia, malposisi, malpresentasi, atau disproporsi sefalopelvik	Jangan menunda evaluasi; siapkan rujukan ke fasilitas yang lebih mampu
DJJ <110 x/menit atau >160 x/menit	Menunjukkan kemungkinan gawat janin	Reposisi ibu, nilai cepat kondisi ibu-janin, lapor segera, percepat eskalasi
Ketuban pecah dengan mekonium	Meningkatkan kecurigaan kompromi janin	Pantau janin ketat, lapor segera, siapkan rujukan
Ibu tampak sangat lelah, gelisah, dehidrasi, nadi meningkat, atau suhu meningkat	Menunjukkan perburukan kondisi maternal dan risiko infeksi/kelelahan persalinan	Stabilisasi awal, cairan sesuai kebutuhan, pantau ketat, kolaborasi/rujukan
Moulage/caput bertambah, edema serviks, atau nyeri abdomen menetap	Meningkatkan kecurigaan persalinan obstruktif	Hentikan penundaan, lapor dan rujuk segera
Tanda syok atau penurunan kesadaran	Kegawatdaruratan maternal	Resusitasi awal sesuai kewenangan, panggil bantuan, rujuk emergensi
Keputusan rujukan sudah jelas tetapi proses tertunda	Menambah risiko ibu dan janin	Aktifkan rencana rujukan tanpa ditunda, lengkapi pendokumentasian, komunikasikan ke keluarga dan fasilitas penerima

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab: KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN KESELAMATAN INTRAPARTUM**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian persalinan	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan penyebab atau etiologi persalinan	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menyebutkan dan menjelaskan tahap-tahap persalinan	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menjelaskan prinsip persalinan	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menjelaskan standar asuhan persalinan berfokus pada ibu dan bayi	☐	☐	
6	Saya sudah bisa melakukan pengkajian pada pasien bersalin	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ibu	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan obstetri pada ibu bersalin	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memahami tindakan awal yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	
10	Saya sudah bisa membedakan isu etik dan dilema	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menyiapkan pemantauan ibu dan janin secara cepat dan sistematis	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan janin kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	
13	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan hasil pemeriksaan obstetri secara ringkas dan tepat	☐	☐	
14	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover singkat dengan jelas	☐	☐	
15	Saya sudah bisa mengaplikasikan menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

G. Daftar Pustaka

- Alyssa R.H., et al. (2024). Third stage of labor: evidence based practice for prevention of adverse maternal and neonatal outcomes. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*
- Ari Kurniarum. (2016). *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi baru lahir*. Kemenkes RI. Jakarta
- Bobak et al. (2017). *Buku ajar Keperawatan Maternitas*. EGC. Jakarta
- Bohren, M. A., Vogel, J. P., Hunter, E. C., et al. (2015). The mistreatment of women during childbirth in health facilities globally: A mixed-methods systematic review. *PLOS Medicine*, 12(6), e1001847.
- Borovac Pinheiro A, Pacagnella RC, Cecatti JG, et al. (2018). Postpartum hemorrhage: new insights for definition and diagnosis. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*
- Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. (2018). *Williams obstetrics*, 25th ed. New York, NY: Mc Graw-Hill Education;.
- Kemenkes RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien*. Jakarta
- Kemenkes RI. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan*. Jakarta
- Kemenkes RI. (2017). *Asuhan Persalinan Normal*. Jakarta
- Kerr RS, Weeks AD. (2017). Postpartum haemorrhage: a single definition is no longer enough. *BJOG* 2017;124:723–6.
- K.H Endah Widhi Astuti. (2016). *Konsep Kebidanan dan Etikolegal Dalam Praktek Kebidanan*. Kemenkes RI. Jakarta
- Milman N. (2011). Postpartum anemia I: definition, prevalence, causes, and consequences. *Ann Hematol* 2011;90:1247–53.
- Renfrew, M. J., et al. (2014). Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework. *The Lancet*.
- Sarwono Prawirohardjo. (2022). *Ilmu Kebidanan*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta

- Sofia Al Farizi et. Al. (2025). Respectful maternity care in Indonesia: A factor analysis with a multicenter study approach. *Midwifery an International Journal*. Volume 147, August 2025, 104442.
- World Health Organization. (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care.
- World Health Organization. (2018). Intrapartum care for a positive childbirth experience.
- World Health Organization. (2009). WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care.

BAB 2

PENGKAJIAN IBU BERSALIN : ANAMNESIS, PEMERIKSAAN FISIK, DAN PENILAIAN KESEJAHTERAAN JANIN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL 1 – Sikap	Menunjukkan sikap profesional, etis, empatik, bertanggung jawab, serta menghargai privasi, kenyamanan, dan keselamatan ibu bersalin dalam memberikan asuhan kebidanan.
CPL 2 – Pengetahuan	Menguasai konsep dasar persalinan, pengkajian ibu bersalin, anamnesis, pemeriksaan fisik obstetri, penilaian kesejahteraan janin, serta deteksi dini komplikasi selama proses intrapartum.
CPL 3 – Keterampilan Umum	Mampu menerapkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, pengambilan keputusan klinis, serta pendokumentasian asuhan kebidanan secara sistematis dan bertanggung jawab.
CPL 4 – Keterampilan Khusus	Mampu melakukan pengkajian ibu bersalin secara komprehensif melalui pengumpulan data subjektif dan objektif, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetri, penilaian denyut jantung janin, serta interpretasi hasil pengkajian untuk menentukan diagnosis dan rencana asuhan kebidanan.
CPL 5 – Keselamatan Pasien	Mampu menerapkan prinsip patient safety dalam pengkajian ibu bersalin, termasuk pencegahan infeksi, penggunaan APD, pembatasan tindakan yang tidak perlu, deteksi red flags, dan rujukan tepat waktu apabila ditemukan kondisi kegawatdaruratan.
CPL 6 – Kolaborasi dan Komunikasi	Mampu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada ibu dan keluarga, serta berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam upaya menjaga keselamatan ibu dan janin.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:

Kode CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
CPMK 1	Menjelaskan konsep dasar pengkajian ibu bersalin, meliputi pengertian, tujuan, indikasi, persiapan alat, persiapan pasien, serta prinsip keselamatan dalam pengkajian persalinan.
CPMK 2	Mengidentifikasi data subjektif penting pada ibu bersalin melalui anamnesis terarah, meliputi keluhan utama, riwayat persalinan sekarang, pengeluaran pervaginam, gerakan janin, riwayat obstetri, riwayat kesehatan, serta faktor risiko kehamilan dan persalinan.
CPMK 3	Melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan obstetri terfokus pada ibu bersalin secara sistematis, meliputi penilaian keadaan umum, tanda vital, his, pemeriksaan abdomen, palpasi Leopold, serta pemeriksaan dalam sesuai indikasi dan kewenangan.
CPMK 4	Melakukan penilaian kesejahteraan janin melalui pemantauan denyut jantung janin, gerakan janin, respons janin terhadap kontraksi, serta mengenali tanda-tanda gawat janin.
CPMK 5	Menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengkajian ibu bersalin berdasarkan data subjektif dan objektif untuk menentukan kondisi ibu, kondisi janin, kemajuan persalinan, serta kemungkinan adanya penyimpangan atau komplikasi.
CPMK 6	Menegakkan diagnosis atau masalah kebidanan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetri, penilaian kesejahteraan janin, serta pemantauan kemajuan persalinan menggunakan partograf.
CPMK 7	Menyusun rencana asuhan kebidanan yang tepat pada ibu bersalin, termasuk tindakan awal, edukasi, pemantauan lanjutan, kolaborasi, dan rujukan apabila ditemukan tanda bahaya atau kondisi kegawatdaruratan.
CPMK 8	Mendokumentasikan hasil pengkajian ibu bersalin secara lengkap, akurat, dan sistematis menggunakan format SOAP, partograf, rekam medis, atau catatan kebidanan sesuai standar praktik.
CPMK 9	Menunjukkan perilaku profesional dalam melakukan pengkajian ibu bersalin, meliputi komunikasi terapeutik, informed consent, menjaga privasi, penggunaan APD, hand hygiene, empati, serta keselamatan ibu dan janin.

Sub-CPMK

Kode Sub-CPMK

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

- | | |
|--------------------|---|
| Sub-CPMK 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, indikasi, dan prinsip dasar pengkajian ibu bersalin. |
| Sub-CPMK 2 | Mahasiswa mampu menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pengkajian ibu bersalin, seperti tensimeter, stetoskop, Doppler atau fetoskop, partograf, sarung tangan, APD, dan format pengkajian. |
| Sub-CPMK 3 | Mahasiswa mampu melakukan persiapan sebelum pengkajian, meliputi mencuci tangan, menggunakan APD, menjaga privasi, menjelaskan prosedur, dan meminta persetujuan tindakan. |
| Sub-CPMK 4 | Mahasiswa mampu melakukan anamnesis terarah pada ibu bersalin, meliputi keluhan mulas, lama kontraksi, pola his, pengeluaran lendir darah, ketuban, perdarahan, gerakan janin, dan riwayat obstetri. |
| Sub-CPMK 5 | Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan tanda vital ibu bersalin, meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. |
| Sub-CPMK 6 | Mahasiswa mampu menilai kontraksi uterus berdasarkan frekuensi, durasi, interval, dan kekuatan his. |
| Sub-CPMK 7 | Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan abdomen dengan metode Leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri, letak, posisi, presentasi, dan penurunan kepala janin. |
| Sub-CPMK 8 | Mahasiswa mampu melakukan auskultasi denyut jantung janin serta menginterpretasikan hasil DJJ normal dan abnormal. |
| Sub-CPMK 9 | Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan dalam, seperti pembukaan serviks, penipisan serviks, kondisi ketuban, presentasi janin, dan penurunan kepala. |
| Sub-CPMK 10 | Mahasiswa mampu mengenali tanda bahaya pada ibu bersalin, seperti perdarahan abnormal, tekanan darah tinggi, tanda infeksi, syok, nyeri abdomen hebat, dan persalinan tidak maju. |
| Sub-CPMK 11 | Mahasiswa mampu mengenali tanda bahaya pada janin, seperti DJJ kurang dari 110 kali/menit, DJJ lebih dari 160 kali/menit, gerakan janin berkurang, dan air ketuban bercampur mekonium. |
| Sub-CPMK 12 | Mahasiswa mampu menentukan diagnosis kebidanan berdasarkan data pengkajian ibu dan janin. |

**Kode Sub-
CPMK**

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Sub- CPMK 13	Mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan kebidanan sesuai kondisi ibu dan janin, termasuk pemantauan, stabilisasi awal, kolaborasi, atau rujukan.
Sub- CPMK 14	Mahasiswa mampu memberikan KIE singkat kepada ibu dan keluarga mengenai kondisi persalinan, hasil pemeriksaan, tindakan yang akan dilakukan, serta tanda bahaya.
Sub- CPMK 15	Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil pengkajian menggunakan format SOAP dan partograf secara sistematis.

Pemetaan CPL, CPMK, dan Metode Penilaian

CPL	CPMK Terkait	Metode Penilaian
CPL 1	CPMK 9	Observasi perilaku profesional, OSCE, DOPS, refleksi patient safety
CPL 2	CPMK 1, CPMK 2, CPMK 4	Tes tertulis, mini-case, diskusi kelompok
CPL 3	CPMK 5, CPMK 6, CPMK 8	Case report, portofolio, analisis kasus, dokumentasi SOAP
CPL 4	CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, CPMK 6	OSCE, DOPS, checklist keterampilan klinis
CPL 5	CPMK 5, CPMK 7, CPMK 9	Refleksi patient safety, red flags analysis, OSCE
CPL 6	CPMK 7, CPMK 8, CPMK 9	KIE/konseling, OSCE, DOPS, portofolio

Indikator Pencapaian CPMK

CPMK	Indikator Pencapaian
CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengkajian ibu bersalin dengan benar.
CPMK 2	Mahasiswa mampu mengumpulkan data subjektif secara lengkap dan terarah.
CPMK 3	Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik dan obstetri sesuai prosedur.

CPMK	Indikator Pencapaian
CPMK 4	Mahasiswa mampu menilai DJJ dan kesejahteraan janin secara tepat.
CPMK 5	Mahasiswa mampu menginterpretasikan data ibu dan janin secara klinis.
CPMK 6	Mahasiswa mampu merumuskan diagnosis atau masalah kebidanan berdasarkan data.
CPMK 7	Mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan, kolaborasi, atau rujukan sesuai kondisi.
CPMK 8	Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil pengkajian secara lengkap dan sistematis.
CPMK 9	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, menjaga privasi, dan menerapkan patient safety.

Uraian Materi

A. Teori Dasar

Pengkajian ibu bersalin merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan data subjektif dan objektif yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, serta penilaian kesejahteraan janin untuk menentukan kondisi ibu dan janin selama proses persalinan secara komprehensif. Anamnesis dilakukan melalui wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai identitas ibu, riwayat obstetri, riwayat kehamilan saat ini, serta keluhan yang dirasakan. Sementara itu, pemeriksaan fisik dilakukan melalui teknik inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi guna menilai kondisi umum ibu serta kemajuan persalinan. Penilaian kesejahteraan janin dilakukan dengan memantau denyut jantung janin (DJJ), gerakan janin, serta respons terhadap kontraksi untuk memastikan tidak terjadi kondisi gawat janin (Rizkia et al., 2025; Zuliyanti & Priyanto, 2021).

Tujuan pengkajian ibu bersalin adalah untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan ibu dan janin secara menyeluruh, menegaskan diagnosis kebidanan secara tepat, mendeteksi secara dini adanya komplikasi, serta menentukan rencana asuhan yang sesuai guna meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Pengkajian ini juga berperan penting dalam upaya menurunkan angka morbiditas dan mortalitas maternal dan neonatal melalui tindakan yang cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat (Jurnal Kebidanan, 2025).

Pengkajian ibu bersalin diindikasikan pada seluruh ibu yang memasuki proses persalinan, baik pada kala I sampai kala IV, serta pada ibu dengan tanda-tanda persalinan seperti kontraksi uterus, pembukaan serviks, dan keluarnya lendir bercampur darah. Selain itu, pengkajian juga diperlukan pada ibu dengan faktor risiko obstetri seperti preeklampsia, anemia, atau riwayat persalinan sebelumnya yang bermasalah. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat kondisi yang memerlukan kehati-hatian, seperti pembatasan pemeriksaan vaginal pada ibu dengan ketuban pecah dini untuk mencegah infeksi, serta pada kondisi perdarahan aktif atau gawat janin yang membutuhkan tindakan segera tanpa penundaan (Jurnal Ilmu Kesehatan, 2023).

Pelaksanaan pengkajian memerlukan alat dan bahan seperti alat pemeriksaan tanda vital, Doppler atau fetoskop untuk mendeteksi DJJ, sarung tangan steril, pelumas, partograf, serta alat pelindung diri (APD). Selain itu, diperlukan pula dokumen pendukung seperti buku KIA dan format pengkajian untuk mencatat hasil pemeriksaan secara sistematis. Sebelum tindakan dilakukan, petugas harus melakukan persiapan dengan mencuci tangan, menggunakan APD, serta memberikan penjelasan kepada ibu untuk memperoleh persetujuan tindakan (informed consent). Persiapan pasien juga penting dilakukan dengan menjaga

privasi, memberikan kenyamanan, serta mengatur posisi ibu sesuai kebutuhan pemeriksaan (Modul Kebidanan, 2023).

Langkah tindakan dalam pengkajian dimulai dengan anamnesis yang mencakup identitas ibu, riwayat obstetri, serta keluhan utama. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik meliputi penilaian keadaan umum, pemeriksaan abdomen dengan metode Leopold untuk menentukan posisi dan presentasi janin, serta auskultasi DJJ. Pemeriksaan dalam (vaginal touché) dilakukan untuk menilai pembukaan serviks, penurunan kepala janin, dan kondisi ketuban. Penilaian kesejahteraan janin dilakukan dengan memantau DJJ normal antara 120–160 kali per menit, variabilitas, serta respons janin terhadap kontraksi (Rizkia et al., 2025).

Aspek keselamatan dalam pengkajian sangat penting, meliputi penerapan teknik aseptik untuk mencegah infeksi, pembatasan pemeriksaan yang tidak perlu, serta deteksi dini tanda-tanda komplikasi seperti gawat janin. Komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dengan ibu dan keluarga juga menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan pasien. Selain itu, rujukan harus dilakukan secara tepat waktu apabila ditemukan kondisi yang tidak dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut (Zuliyanti & Priyanto, 2021).

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan memantau kemajuan persalinan menggunakan partograf, menilai perubahan kondisi ibu dan janin, serta mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diberikan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis selanjutnya. Seluruh hasil pengkajian harus didokumentasikan secara lengkap dan sistematis menggunakan format SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Planning), partograf, serta rekam medis sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional dan untuk menjamin kesinambungan asuhan kebidanan (Rizkia et al., 2025).

B. Konsep Dasar Pengkajian Ibu Bersalin

Pengkajian ibu bersalin merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pemberian asuhan kebidanan selama proses persalinan. Pengkajian ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi ibu dan janin. Data yang diperoleh dari pengkajian menjadi dasar bagi bidan dalam menentukan diagnosis atau masalah kebidanan, menyusun rencana asuhan, melakukan tindakan yang tepat, serta mengevaluasi perkembangan persalinan. Oleh karena itu, pengkajian ibu bersalin tidak boleh dilakukan secara terburu-buru atau hanya berdasarkan satu aspek pemeriksaan saja, tetapi harus mencakup data subjektif dan objektif secara menyeluruh.

Pengkajian ibu bersalin mencakup beberapa komponen utama, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetri, dan penilaian kesejahteraan janin. Anamnesis dilakukan untuk menggali keluhan ibu, riwayat kehamilan, riwayat

persalinan, riwayat obstetri, serta faktor risiko yang dapat memengaruhi proses persalinan. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menilai keadaan umum ibu, tanda-tanda vital, kondisi tubuh secara umum, serta tanda-tanda yang menunjukkan adanya komplikasi. Pemeriksaan obstetri dilakukan untuk mengetahui kemajuan persalinan, posisi dan presentasi janin, kontraksi uterus, pembukaan serviks, penurunan kepala janin, serta keadaan ketuban. Sementara itu, penilaian kesejahteraan janin dilakukan untuk memastikan bahwa janin berada dalam kondisi baik selama proses persalinan.

Tujuan utama pengkajian ibu bersalin adalah untuk mengetahui kondisi ibu dan janin secara komprehensif. Melalui pengkajian yang tepat, bidan dapat membedakan antara persalinan normal dan persalinan yang mengalami penyulit. Pengkajian juga berfungsi untuk mendeteksi secara dini adanya tanda bahaya, seperti perdarahan abnormal, ketuban pecah dini, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, persalinan lama, malpresentasi, maupun tanda-tanda gawat janin. Deteksi dini sangat penting karena keterlambatan mengenali komplikasi dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian pada ibu maupun bayi.

Selain sebagai dasar pengambilan keputusan klinis, pengkajian ibu bersalin juga berperan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Bidan harus mampu mengintegrasikan seluruh data yang diperoleh untuk menentukan apakah ibu dapat ditangani di fasilitas pelayanan saat ini atau memerlukan kolaborasi dan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap. Dengan demikian, pengkajian ibu bersalin merupakan bagian penting dari asuhan kebidanan yang aman, bermutu, dan berpusat pada kebutuhan ibu serta janin.

C. Persiapan Pengkajian Ibu Bersalin

Persiapan pengkajian ibu bersalin merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum bidan melaksanakan pemeriksaan kepada ibu. Persiapan yang baik bertujuan agar proses pengkajian berjalan lancar, aman, nyaman, dan sesuai dengan prinsip pelayanan kebidanan. Persiapan ini mencakup kesiapan petugas, kesiapan alat dan bahan, kesiapan lingkungan, serta kesiapan ibu sebagai pasien yang akan dilakukan pemeriksaan. Semua aspek tersebut perlu diperhatikan karena pengkajian ibu bersalin dilakukan dalam situasi yang dapat berubah cepat, terutama apabila ditemukan tanda bahaya atau kondisi kegawatdaruratan.

Sebelum melakukan pengkajian, bidan harus memastikan bahwa dirinya telah melakukan prosedur pencegahan infeksi dengan benar, seperti mencuci tangan atau melakukan hand hygiene, menggunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan, serta menyiapkan alat pemeriksaan dalam keadaan bersih dan siap pakai. Alat yang diperlukan dalam pengkajian ibu bersalin antara lain tensimeter, stetoskop,

termometer, jam tangan, Doppler atau fetoskop untuk memantau denyut jantung janin, sarung tangan, pelumas, kain penutup, partograf, serta format pengkajian atau rekam medis. Kelengkapan alat sangat penting agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis tanpa harus menunda proses pengkajian.

Persiapan pasien juga merupakan bagian penting dalam pengkajian ibu bersalin. Bidan perlu menyapa ibu dengan ramah, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan, serta meminta persetujuan tindakan atau informed consent sebelum pemeriksaan dilakukan. Penjelasan yang baik dapat membantu mengurangi kecemasan ibu dan meningkatkan kerja sama selama proses pemeriksaan. Selain itu, bidan juga harus menjaga privasi ibu, mengatur posisi yang nyaman, serta memastikan lingkungan pemeriksaan aman dan tidak menimbulkan rasa malu atau tidak nyaman bagi ibu.

Dalam pengkajian ibu bersalin, kenyamanan dan keselamatan ibu harus selalu menjadi perhatian utama. Ibu yang sedang mengalami kontraksi sering kali merasa nyeri, cemas, atau takut. Oleh karena itu, bidan perlu melakukan komunikasi terapeutik, memberikan dukungan emosional, serta menyesuaikan waktu pemeriksaan dengan kondisi ibu, terutama saat kontraksi berlangsung. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan dengan lembut, tidak tergesa-gesa, dan hanya dilakukan sesuai indikasi. Pemeriksaan dalam, misalnya, harus dibatasi terutama pada kondisi ketuban pecah dini untuk mengurangi risiko infeksi.

Persiapan dokumentasi juga tidak kalah penting. Setiap hasil pengkajian harus dicatat secara lengkap, jelas, dan sistematis. Partograf perlu disiapkan untuk memantau kemajuan persalinan, kondisi ibu, kondisi janin, dan tindakan yang telah dilakukan. Dokumentasi yang baik akan membantu bidan dalam melakukan evaluasi berkelanjutan, memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan, serta menjadi bukti pertanggungjawaban profesional dalam pelayanan kebidanan.

D. Anamnesis pada Ibu Bersalin

Anamnesis pada ibu bersalin merupakan proses pengumpulan data subjektif melalui wawancara terarah antara bidan dengan ibu atau keluarga. Anamnesis menjadi bagian penting dalam pengkajian karena banyak informasi klinis yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pemeriksaan fisik. Melalui anamnesis, bidan dapat mengetahui keluhan utama ibu, awal mula tanda persalinan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan sebelumnya, serta faktor risiko yang mungkin memengaruhi proses persalinan saat ini.

Pada awal anamnesis, bidan perlu menggali keluhan utama yang dirasakan ibu. Keluhan yang sering disampaikan oleh ibu bersalin adalah mulas atau nyeri perut yang hilang timbul, keluarnya lendir bercampur darah, keluarnya air ketuban, atau

adanya rasa ingin meneran. Bidan perlu menanyakan sejak kapan keluhan tersebut dirasakan, bagaimana frekuensi dan kekuatan kontraksi, apakah nyeri semakin sering dan teratur, serta apakah terdapat pengeluaran cairan atau darah dari jalan lahir. Informasi ini penting untuk menentukan apakah ibu benar-benar sudah memasuki proses persalinan dan berada pada kala berapa.

Selain keluhan utama, bidan juga perlu menanyakan riwayat kehamilan saat ini. Riwayat tersebut meliputi usia kehamilan, jumlah kunjungan antenatal, hasil pemeriksaan selama kehamilan, keluhan atau komplikasi yang pernah dialami, serta obat atau suplemen yang dikonsumsi. Informasi mengenai riwayat anemia, hipertensi, preeklampsia, diabetes gestasional, perdarahan, infeksi, atau kelainan letak janin sangat penting karena kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan.

Riwayat obstetri juga harus dikaji secara lengkap. Bidan perlu mengetahui jumlah kehamilan, jumlah persalinan, jumlah keguguran, jumlah anak hidup, riwayat persalinan sebelumnya, cara persalinan, berat badan bayi sebelumnya, riwayat perdarahan, riwayat operasi sesar, serta adanya komplikasi pada persalinan terdahulu. Riwayat tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan risiko pada persalinan saat ini. Misalnya, riwayat persalinan lama, bayi besar, perdarahan postpartum, atau operasi sesar sebelumnya perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi keputusan klinis.

Anamnesis juga harus mencakup pengkajian gerakan janin. Ibu perlu ditanyakan apakah gerakan janin masih aktif, berkurang, atau tidak dirasakan. Gerakan janin yang berkurang dapat menjadi salah satu tanda awal gangguan kesejahteraan janin dan perlu segera dikonfirmasi dengan pemeriksaan denyut jantung janin. Selain itu, bidan juga perlu menanyakan pengeluaran air ketuban, termasuk waktu pecahnya ketuban, warna, bau, dan jumlah cairan. Ketuban yang berwarna hijau atau bercampur mekonium dapat menunjukkan kemungkinan gangguan pada janin.

Data lain yang perlu dikaji meliputi riwayat penyakit ibu, riwayat alergi, riwayat penggunaan obat, riwayat operasi, serta kondisi psikologis ibu. Ibu yang tampak cemas, takut, atau tidak memiliki pendamping mungkin membutuhkan dukungan emosional lebih intensif. Bidan juga dapat menanyakan pola makan dan minum terakhir, buang air kecil terakhir, tingkat kelelahan, serta dukungan keluarga. Seluruh data tersebut membantu bidan dalam memberikan asuhan yang lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan ibu.

Anamnesis yang baik harus dilakukan dengan komunikasi yang sopan, jelas, dan empatik. Bidan perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak menghakimi, serta memberikan kesempatan kepada ibu untuk menyampaikan

keluhannya. Data yang diperoleh dari anamnesis kemudian dikombinasikan dengan hasil pemeriksaan objektif untuk menentukan diagnosis atau masalah kebidanan secara tepat.

E. Penilaian Kesejahteraan Janin

Penilaian kesejahteraan janin merupakan bagian penting dalam pengkajian ibu bersalin karena kondisi janin harus dipantau secara berkelanjutan selama proses persalinan. Janin dapat mengalami perubahan kondisi akibat kontraksi uterus, gangguan aliran darah plasenta, kompresi tali pusat, ketuban bercampur mekonium, atau komplikasi lain yang terjadi selama persalinan. Oleh karena itu, pemantauan janin bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya tanda-tanda gawat janin sehingga tindakan yang tepat dapat segera dilakukan.

Salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan janin adalah denyut jantung janin atau DJJ. Secara umum, DJJ normal berada pada rentang 120 sampai 160 kali per menit. Pemantauan DJJ dapat dilakukan menggunakan Doppler atau fetoskop, dan hasilnya harus dicatat secara teratur pada partograf atau catatan persalinan. DJJ perlu diperiksa terutama setelah kontraksi, karena perubahan denyut jantung janin setelah kontraksi dapat menunjukkan respons janin terhadap tekanan selama persalinan.

Interpretasi DJJ harus dilakukan secara hati-hati. DJJ kurang dari 110 kali per menit disebut bradikardia janin, sedangkan DJJ lebih dari 160 kali per menit disebut takikardia janin. Kedua kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya gangguan kesejahteraan janin, terutama apabila disertai dengan faktor risiko lain seperti gerakan janin berkurang, air ketuban bercampur mekonium, persalinan lama, atau tanda infeksi pada ibu. Apabila ditemukan DJJ abnormal, bidan harus segera melakukan tindakan awal sesuai kewenangan, seperti memposisikan ibu miring kiri, memantau ulang DJJ, menilai tanda vital ibu, serta melakukan kolaborasi atau rujukan apabila kondisi tidak membaik.

Selain DJJ, gerakan janin juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan janin. Gerakan janin yang aktif menunjukkan bahwa janin dalam kondisi baik, sedangkan gerakan yang berkurang atau tidak dirasakan dapat menjadi tanda awal gangguan janin. Pada ibu bersalin, informasi mengenai gerakan janin diperoleh melalui anamnesis dan dapat dikonfirmasi dengan pemantauan DJJ. Bidan perlu memberikan perhatian khusus apabila ibu melaporkan bahwa gerakan janin berkurang sejak beberapa jam terakhir.

Kondisi air ketuban juga perlu diperhatikan dalam penilaian kesejahteraan janin. Ketuban yang jernih umumnya menunjukkan kondisi yang lebih baik, sedangkan ketuban yang berwarna hijau atau bercampur mekonium dapat menjadi

tanda kemungkinan hipoksia janin. Ketuban yang berbau tidak sedap dapat mengarah pada infeksi. Oleh karena itu, setiap pengeluaran cairan ketuban harus dinilai dari segi waktu, warna, bau, dan jumlahnya. Pemeriksaan ini sangat membantu dalam menentukan apakah ibu memerlukan pemantauan ketat atau rujukan.

Penilaian kesejahteraan janin juga tidak dapat dipisahkan dari penilaian kemajuan persalinan. Persalinan yang tidak maju, kepala janin yang tetap tinggi, kontraksi yang tidak efektif, atau adanya tanda obstruksi dapat meningkatkan risiko gangguan pada janin. Oleh sebab itu, penggunaan partograf sangat penting untuk memantau kemajuan pembukaan serviks, penurunan kepala janin, frekuensi kontraksi, DJJ, serta kondisi ibu. Dengan partograf, bidan dapat mengenali penyimpangan lebih awal dan mengambil keputusan klinis secara tepat.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus

Seorang ibu, Ny. B, usia 32 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 40 minggu, datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri perut sejak 8 jam yang lalu dan semakin kuat sejak 3 jam terakhir. Ibu juga mengatakan air ketuban sudah keluar sejak ± 1 jam yang lalu dengan warna jernih.

Hasil anamnesis menunjukkan ibu mengalami anemia ringan selama kehamilan dan merasakan gerakan janin berkurang sejak pagi hari. Pemeriksaan fisik menunjukkan keadaan umum ibu tampak cemas, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 96 x/menit, suhu 37,2°C, dan pernapasan 22 x/menit. Pada pemeriksaan abdomen didapatkan presentasi kepala, tetapi kepala belum masuk PAP.

Auskultasi denyut jantung janin (DJJ) 110 x/menit. Kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit dengan durasi ± 45 detik. Pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan serviks 6 cm, effacement 80%, ketuban sudah pecah, dan penurunan kepala di Hodge I–II.

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi data subjektif dan objektif penting dari kasus di atas?
2. Data tambahan apa yang perlu dikaji dalam anamnesis untuk melengkapi pengkajian ibu bersalin?
3. Bagaimana interpretasi hasil pemeriksaan fisik (tanda vital, kontraksi, dan penurunan kepala) pada kasus tersebut?
4. Bagaimana interpretasi denyut jantung janin (DJJ) 110 x/menit dan apa maknanya terhadap kesejahteraan janin?
5. Apa diagnosis kebidanan yang dapat ditegakkan berdasarkan data kasus tersebut?
6. Apakah terdapat tanda penyimpangan atau risiko komplikasi? Jelaskan alasan Anda?
7. Apa rencana asuhan kebidanan yang tepat serta tindakan segera yang harus dilakukan bidan?

F. Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Pengkajian Ibu Bersalin
3	Kasus	Pengkajian ibu bersalin kala I fase aktif melalui anamnesis, pemeriksaan fisik obstetri, dan penilaian kesejahteraan janin
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam melakukan pengkajian ibu bersalin secara komprehensif

No.	Komponen	Isi
		meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penilaian kesejahteraan janin.
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau pemeriksaan sederhana 3. Perumusan diagnosis/masalah kebidanan 4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 5. Perilaku profesional
6	Soal : Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke ruang bersalin dengan keluhan nyeri perut sejak ±6 jam yang lalu. Nyeri dirasakan semakin sering dan kuat. Hasil anamnesis awal : • Lendir bercampur darah (+) • Belum ada pengeluaran air ketuban • Gerakan janin masih aktif Hasil pemeriksaan : • TD: 110/70 mmHg • Nadi: 88 x/menit • RR: 22 x/menit • Suhu: 36,8°C • His: 3x/10 menit/40 detik • DJJ: 144 x/menit TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik dan obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan hasil interpretasi/diagnosis kebidanan berdasarkan data. 4. Lakukan penilaian kesejahteraan janin. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu terkait kondisi saat ini.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta sesuai kartu ujian. 2. Berikan penilaian menggunakan: • Actual mark (0–3) • Global rating (1–4) 3. Penguji tidak diperkenankan berinteraksi selain ketentuan.

No.	Komponen	Isi
		4. Ikuti standar pelaksanaan OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog. 2. Jika peserta melakukan palpasi Leopold, berikan data: • TFU: 32 cm • Punggung kiri • Presentasi kepala • Kepala sudah masuk PAP (Hodge III) 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan dalam : • Pembukaan serviks: 5 cm • Penipisan: 50% • Ketuban utuh • Presentasi kepala 4. Penilaian kesejahteraan janin : • DJJ: 144 x/menit (normal) 5. Interpretasi yang diharapkan : • Persalinan kala I fase aktif • Kondisi ibu dan janin baik 6. Penguji hanya memberikan data jika diminta. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS : 1. PS berperan sebagai ibu bersalin kala I fase aktif. 2. Tampak meringis saat kontraksi. 3. Sesekali memegang perut dan bernapas cepat saat nyeri. 4. Kooperatif jika diberi penjelasan.
9	Dialog PS	Peserta : Selamat pagi/siang, Bu. PS : Pagi/siang, Bu. Peserta : Saya bidan yang akan memeriksa ibu, apakah bersedia? PS : Iya, Bu.

No.	Komponen	Isi
		Peserta : Apa keluhan utama ibu? PS : Saya mulas sejak tadi, Bu. Peserta : Sejak kapan? PS : Sekitar 6 jam yang lalu. Peserta : Apakah keluar lendir darah? PS : Iya, ada sedikit. Peserta : Apakah air ketuban sudah keluar? PS : Belum, Bu. Peserta : Bagaimana gerakan bayi? PS : Masih sering terasa. Peserta : Ini kehamilan ke berapa? PS : Kehamilan kedua. Peserta : Ada riwayat penyakit? PS : Tidak ada.
10	Kebutuhan manikin	• Phantom abdomen hamil • Phantom panggul/serviks
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran : • Menyiapkan alat dan manikin • Mengganti lembar instruksi • Menjaga kesiapan stasiun
12	Kebutuhan alat	• Tempat tidur/periksa — 1 • Phantom abdomen — 1 • Phantom panggul — 1 • Tensimeter — 1 • Stetoskop — 1 • Doppler/Pinard — 1 • Jam tangan — 1 • Termometer — 1 • Sarung tangan — 1 pasang • Handrub — 1 • Kain penutup — 1 • Tisu — 1 pack • Lembar jawaban peserta — 1 lembar • Pena — 1
13	Penulis	Bdn.Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb.,M.Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan RI. (2020). <i>Standar Profesi Bidan</i>. 2. Kementerian Kesehatan RI. (2022). <i>Standar Kompetensi Kebidanan</i>. 3. World Health Organization. (2018). <i>Intrapartum care</i>.

No.	Komponen	Isi
		4. National Institute for Health and Care Excellence. (2023). <i>Intrapartum care for healthy women and babies.</i> 5. Cunningham, F. G., et al. (2022). <i>Williams Obstetrics.</i>

G. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan

Stase 1: Pengkajian Ibu Bersalin

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama (nyeri/mulas, durasi, intensitas)		
2. Riwayat persalinan sekarang (sejak kapan mulas, pola his, kemajuan persalinan)		
3. Riwayat pengeluaran pervaginam (lendir darah, air ketuban, perdarahan)		
4. Gerak janin		
5. Rasa ingin meneran		
6. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
7. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
8. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Menilai his (frekuensi, durasi, kekuatan)		
d. Menilai DJJ		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
e. Menilai ketuban/pengeluaran darah pervaginam		
f. Melakukan pemeriksaan obstetri terfokus atau meminta data yang relevan sesuai kewenangan station		
g. Menilai kemajuan persalinan melalui data partograf/hasil pemeriksaan dalam yang tersedia		
h. Menyimpulkan adanya partus lama/distosia dan kecurigaan kondisi janin/ibu yang memburuk		
i. Memposisikan ibu miring kiri		
j. Menyiapkan/memasang infus cairan sesuai kewenangan dan fasilitas		
k. Menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih		
l. Melakukan pemantauan ulang kondisi ibu dan janin		
m. Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera dan aman		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada partograf/catatan medis/form rujukan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **15–19 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **10–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....
Penguji:.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pengkajian Ibu Bersalin: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Dan Penilaian Kesejahteraan Janin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Ibu Bersalin
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinik mahasiswa dalam melakukan pengkajian ibu bersalin. Penilai mengamati secara langsung proses anamnesis, pemeriksaan fisik obstetri, dan penilaian kesejahteraan janin, kemudian memberikan umpan balik segera setelah tindakan selesai. Domain yang dinilai meliputi komunikasi, pengumpulan data, keterampilan pemeriksaan, interpretasi klinis, dan profesionalisme.	Pembimbing mengamati bagaimana mahasiswa melakukan anamnesis pada ibu bersalin, melakukan pemeriksaan Leopold, mengukur DJJ, serta menilai kondisi ibu dan janin secara menyeluruh, kemudian memberikan umpan balik terkait kelengkapan dan ketepatan pengkajian.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian ibu bersalin secara komprehensif, sistematis, dan aman, sebagai dasar pengambilan keputusan klinis. Penilaian juga menekankan pendekatan woman-centred care serta keselamatan ibu dan janin.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari kemampuan bertanya, tetapi juga dari kemampuan menghubungkan data anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil DJJ untuk menentukan kondisi ibu dan janin secara tepat.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi umum praktik kebidanan yaitu ibu bersalin kala I yang memerlukan pengkajian lengkap untuk menentukan fase persalinan dan kesejahteraan janin. Penggunaan data klinis sederhana seperti kontraksi, DJJ, dan pembukaan serviks menjadi fokus utama.	Seorang perempuan 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang dengan mulas sejak 6 jam. Lendir darah (+), ketuban belum pecah, DJJ 144 x/menit, his 3x/10 menit. Pembukaan serviks 5 cm.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan prosedur pengkajian secara langsung, meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik umum dan obstetri, serta penilaian kesejahteraan janin. Keterampilan	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, melakukan anamnesis lengkap, melakukan palpasi Leopold untuk menentukan posisi janin, mengukur DJJ,

	utama meliputi komunikasi terapeutik, teknik palpasi Leopold, pengukuran DJJ, dan interpretasi hasil.	dan menyimpulkan kondisi ibu dalam kala I fase aktif dengan janin dalam kondisi baik.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi kelengkapan anamnesis, ketepatan teknik pemeriksaan fisik, kemampuan menilai kesejahteraan janin, interpretasi klinis, komunikasi, dan profesionalisme. Penilaian juga mencakup kemampuan mengintegrasikan data subjektif dan objektif.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali data penting seperti his, pengeluaran pervaginam, gerak janin, melakukan Leopold dengan benar, serta menyimpulkan kondisi ibu dan janin secara tepat.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi adalah performa nyata mahasiswa dalam melakukan pengkajian secara sistematis dan aman. Penilai memperhatikan urutan tindakan, ketepatan teknik, serta kemampuan berpikir klinis.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa melakukan pengkajian secara runtut (anamnesis → pemeriksaan → interpretasi), tidak melewatkan data penting, serta mampu menjelaskan hasil kepada pasien.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, mencakup kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik bersifat konstruktif dan spesifik untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.	Pembimbing menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan pemeriksaan DJJ, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam menggali riwayat persalinan dan memperjelas interpretasi hasil pemeriksaan.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS dikategorikan menjadi: kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Penentuan didasarkan pada kelengkapan pengkajian, ketepatan interpretasi, dan keselamatan pasien.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan pengkajian lengkap dan benar. Perlu supervisi jika masih kurang sistematis. Remedial jika tidak mampu melakukan pengkajian dasar atau salah interpretasi.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai	Mahasiswa tidak hanya memahami teori pengkajian

	capaian pembelajaran pada level praktik nyata (does). Metode ini sangat sesuai dengan Outcome-Based Education karena menilai performa langsung di lahan praktik.	ibu bersalin, tetapi mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penilaian janin secara langsung, sistematis, dan profesional di hadapan pembimbing.
--	--	--

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Pengkajian Ibu Bersalin: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Dan Penilaian Kesejahteraan Janin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Ibu Bersalin
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan dalam melakukan pengkajian ibu bersalin. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dalam anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penilaian kesejahteraan janin.	Pada topik ini, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan anamnesis lengkap, pemeriksaan Leopold, pengukuran DJJ, serta menilai kondisi ibu dan janin secara tepat, dan memperbaiki keterampilan berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses pembelajaran, capaian kompetensi, refleksi diri, serta perbaikan berkelanjutan mahasiswa dalam melakukan pengkajian ibu bersalin.	Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuan dari awal praktik (belum sistematis) hingga mampu melakukan pengkajian ibu bersalin secara lengkap, runtut, dan benar secara klinis.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Ibu Bersalin
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio sebagai bukti keterampilan terstruktur (OSCE) dan performa nyata di lahan praktik (DOPS).	OSCE memuat hasil ujian keterampilan anamnesis dan pemeriksaan obstetri. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pengkajian ibu bersalin di ruang bersalin, termasuk pemeriksaan DJJ dan interpretasi kondisi janin.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus berisi ringkasan pasien yang ditangani mahasiswa, meliputi data subjektif, objektif, analisis, dan hasil asuhan kebidanan.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu, mulas sejak 6 jam, DJJ 144 x/menit, pembukaan 5 cm, hasil pengkajian menunjukkan persalinan kala I fase aktif dengan kondisi ibu dan janin baik.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi risiko, menganalisis potensi kesalahan, dan merencanakan pencegahan dalam pengkajian ibu bersalin.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya ketelitian dalam menilai DJJ, tidak melewatkan tanda penurunan gerak janin, serta pentingnya pengkajian lengkap untuk mencegah keterlambatan deteksi komplikasi.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bagian penting dalam portofolio untuk menunjukkan pembinaan dan peningkatan kompetensi mahasiswa.	CI memberikan masukan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan pemeriksaan DJJ, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam palpasi Leopold dan konsistensi dalam pengkajian data subjektif.
Karakteristik penilaian	Portofolio bersifat longitudinal (berkelanjutan), tidak hanya menilai satu kali performa, tetapi konsistensi	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman praktik pengkajian ibu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Ibu Bersalin
	kemampuan mahasiswa dari waktu ke waktu.	bersalin yang menunjukkan peningkatan kemampuan dalam anamnesis, pemeriksaan fisik, dan interpretasi kondisi janin.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan kompetensi secara konsisten dalam berbagai situasi klinik.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, dan refleksi, terlihat mahasiswa mampu secara konsisten melakukan pengkajian ibu bersalin secara lengkap dan benar.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio menjadi bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dipahami secara teori, tetapi diterapkan dalam praktik nyata secara berulang dan berkembang.	Pada topik ini, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep pengkajian ibu bersalin, tetapi mampu menerapkannya secara langsung, sistematis, dan profesional di lahan praktik.

Tabel. Case Report pada Pengkajian Ibu Bersalin: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Dan Penilaian Kesejahteraan Janin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Ibu Bersalin
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat, sistematis, dan ilmiah mengenai satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian, analisis, dan dokumentasi kasus secara komprehensif.	Mahasiswa 63enyusun laporan tentang seorang ibu bersalin primigravida dengan persalinan kala I fase aktif yang tidak mengalami kemajuan, kepala janin masih tinggi, serta disertai peningkatan denyut jantung janin.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Ibu Bersalin
Tujuan	Case report bertujuan untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data subjektif dan objektif, menetapkan diagnosis/masalah kebidanan, merencanakan tindakan, melakukan implementasi, serta mengevaluasi hasil asuhan secara sistematis.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas berupa partus lama/distosia, melakukan tindakan awal kegawatdaruratan, merencanakan rujukan, serta memantau kondisi ibu dan janin.
Isi laporan	Isi case report meliputi identitas pasien, keluhan utama, data subjektif (anamnesis), data objektif (pemeriksaan fisik dan obstetri), penilaian kesejahteraan janin, analisis data, diagnosis/masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran kasus.	Mahasiswa menuliskan: mulas kuat sejak 10 jam, pembukaan tetap 6 cm selama 4 jam, his adekuat, kepala masih tinggi, ketuban pecah, DJJ 172 x/menit. Analisis menunjukkan partus lama/distosia dengan kecurigaan gawat janin. Dilakukan tindakan awal stabilisasi dan direncanakan rujukan segera.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada kelengkapan dan ketepatan pengkajian, ketajaman analisis masalah, logika penalaran klinis (clinical reasoning), ketepatan tindakan, serta kemampuan evaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan pembukaan yang tidak maju, kepala belum turun, dan DJJ meningkat sebagai kondisi yang memerlukan tindakan awal segera dan rujukan.
Nilai edukatif	Case report memiliki nilai edukatif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, serta refleksi praktik berbasis bukti.	Dari kasus partus lama, mahasiswa belajar bahwa penggunaan partograf, pemantauan DJJ, dan keputusan eskalasi dini merupakan kunci keselamatan ibu dan janin dalam persalinan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam praktik klinik secara	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep pengkajian ibu bersalin dan distosia, tetapi juga mampu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Ibu Bersalin
	sistematis, logis, dan bertanggung jawab.	menyusun laporan kasus yang mencerminkan asuhan kebidanan komprehensif dan profesional.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Pengkajian Ibu Bersalin: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Dan Penilaian Kesejahteraan Janin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Ibu Bersalin
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan analitis yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, serta merencanakan upaya pencegahan dalam praktik kebidanan.	Pada kasus partus lama, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali persalinan tidak maju dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gawat janin, infeksi, hingga ruptur uteri.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam setiap tindakan kebidanan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan seperti tidak membaca partograf dengan tepat, tidak memantau DJJ secara berkala, atau menunda rujukan dapat berdampak fatal pada ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi mencakup identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, serta pembelajaran dari pengalaman klinik yang telah dilakukan.	Mahasiswa mengidentifikasi risiko utama berupa partus lama, kemungkinan obstructed labour, gawat janin, kelelahan ibu, serta keterlambatan penanganan akibat pengkajian yang tidak optimal.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali kondisi atau situasi yang berpotensi	Risiko meliputi keterlambatan diagnosis partus lama, kesalahan dalam menilai penurunan kepala janin,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Ibu Bersalin
	membahayakan keselamatan ibu dan janin.	pemantauan DJJ yang tidak adekuat, penggunaan intervensi yang tidak tepat, serta keterlambatan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya risiko dan meningkatkan keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan partograf secara konsisten, pemantauan DJJ dan tanda vital secara berkala, pengkajian kemajuan persalinan (3P), stabilisasi awal ibu, komunikasi efektif dengan keluarga, serta rujukan tepat waktu.

H. Ringkasan

Pengkajian ibu bersalin merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan data subjektif dan objektif melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta penilaian kesejahteraan janin untuk menentukan kondisi ibu dan janin secara komprehensif. Anamnesis dilakukan melalui wawancara terstruktur, sedangkan pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Penilaian kesejahteraan janin dilakukan dengan memantau denyut jantung janin (DJJ), gerakan janin, dan respons terhadap kontraksi guna mendeteksi kemungkinan gawat janin. Tujuan pengkajian adalah mengidentifikasi kondisi ibu dan janin, menegaskan diagnosis kebidanan, mendeteksi komplikasi secara dini, serta menentukan rencana asuhan yang tepat untuk meningkatkan keselamatan maternal dan neonatal.

Pengkajian dilakukan pada seluruh ibu bersalin, terutama yang menunjukkan tanda-tanda persalinan atau memiliki faktor risiko obstetri, dengan tetap memperhatikan kondisi khusus seperti ketuban pecah dini atau perdarahan. Pelaksanaannya memerlukan alat seperti alat vital sign, Doppler, partograf, dan APD, serta dilakukan dengan persiapan yang mencakup informed consent dan kenyamanan pasien. Prosedur dimulai dari anamnesis, dilanjutkan pemeriksaan fisik termasuk manuver Leopold, auskultasi DJJ, hingga pemeriksaan dalam bila diperlukan. Aspek keselamatan pasien sangat penting, meliputi pencegahan infeksi, pembatasan tindakan yang tidak perlu, komunikasi efektif, dan rujukan tepat waktu.

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan menggunakan partograf dan dokumentasi SOAP untuk memantau kemajuan persalinan serta menjadi dasar pengambilan keputusan klinis selanjutnya, sehingga menjamin kesinambungan dan kualitas asuhan kebidanan.

Alur asuhan singkat

Ibu inpartu → lakukan anamnesis terarah → lakukan pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, auskultasi) → nilai kesejahteraan janin (DJJ, gerak janin) → identifikasi kondisi ibu dan janin → deteksi dini komplikasi → tentukan diagnosis kebidanan → rencanakan asuhan yang tepat → lakukan tindakan sesuai kebutuhan → evaluasi berkelanjutan dengan partograf → dokumentasi SOAP secara sistematis → tentukan tindak lanjut/rujukan bila diperlukan.

I. Tabel Red Flags & Eskalasi

Pengkajian Ibu Bersalin: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Penilaian Kesejahteraan Janin

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Tidak ada kemajuan pembukaan serviks pada pemantauan serial	Mengindikasikan persalinan tidak maju (partus lama)	Lapor ke pembimbing/DPJP, evaluasi 3P (power, passenger, passage), siapkan kolaborasi atau rujukan
His tidak adekuat (lemah/tidak teratur)	Gangguan power yang menyebabkan kemajuan persalinan terhambat	Evaluasi penyebab, observasi ketat, kolaborasi untuk penatalaksanaan lebih lanjut
Kepala janin tidak masuk PAP atau tetap tinggi	Kecurigaan disproporsi sefalopelvik atau malpresentasi	Hindari penundaan, lakukan evaluasi ulang, siapkan rujukan ke fasilitas lebih lengkap
DJJ <110 x/menit atau >160 x/menit	Tanda kemungkinan gawat janin	Posisi miring kiri, oksigenasi bila perlu, pantau ketat, lapor segera, percepat rujukan
Gerakan janin berkurang atau tidak dirasakan	Indikasi awal gangguan kesejahteraan janin	Evaluasi segera DJJ, lakukan pemantauan intensif, kolaborasi/rujukan
Ketuban pecah dini/prolonged rupture	Risiko infeksi ibu dan janin	Batasi pemeriksaan vaginal, pantau tanda infeksi, siapkan rujukan bila perlu
Air ketuban bercampur mekonium	Menandakan kemungkinan hipoksia janin	Pantau DJJ ketat, siapkan rujukan segera
Perdarahan pervaginam abnormal	Mengarah pada komplikasi obstetri (plasenta previa/solusio)	Nilai kondisi ibu, stabilisasi awal, rujuk segera
Tekanan darah tinggi ($\geq 140/90$ mmHg)	Kecurigaan preeklampsia	Pantau ketat, evaluasi tanda bahaya, kolaborasi/rujukan
Nadi meningkat, suhu meningkat	Tanda infeksi atau kelelahan persalinan	Berikan cairan, pantau kondisi, kolaborasi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Nyeri abdomen hebat menetap	Kecurigaan ruptur uteri atau obstruksi	Hentikan tindakan, lapor segera, rujuk emergensi
Edema serviks, moulage bertambah	Indikasi persalinan obstruktif	Jangan menunda, siapkan rujukan segera
Ibu tampak gelisah, lemah, atau dehidrasi	Perburukan kondisi maternal	Stabilisasi cairan, istirahat, kolaborasi
Tanda syok (hipotensi, pucat, penurunan kesadaran)	Kegawatdaruratan maternal	Resusitasi awal, panggil bantuan, rujuk segera
Dokumentasi tidak lengkap atau tidak sesuai	Risiko kesalahan klinis dan kesinambungan asuhan	Lengkapi dokumentasi segera, lakukan klarifikasi data
Rujukan tertunda	Meningkatkan risiko morbiditas/mortalitas	Aktifkan rujukan segera, komunikasi dengan fasilitas penerima

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab: Pengkajian Ibu Bersalin : Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Dan Penilaian Kesejahteraan Janin**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian pengkajian ibu bersalin secara komprehensif	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan pengkajian ibu bersalin	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu bersalin	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menggali riwayat persalinan sekarang (his, durasi, frekuensi, interval)	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi pengeluaran pervaginam (lendir darah, ketuban, perdarahan)	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menilai gerakan janin dari anamnesis	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan tanda vital ibu dengan benar	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan abdomen dengan metode Leopold I-IV	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menentukan posisi, presentasi, dan penurunan janin	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melakukan auskultasi DJJ dengan benar	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menilai kesejahteraan janin berdasarkan DJJ dan kondisi klinis	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya pada ibu bersalin	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya pada janin	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menginterpretasikan hasil pengkajian secara klinis	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menentukan diagnosis/masalah kebidanan	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
16	Saya sudah bisa melakukan komunikasi terapeutik kepada ibu dan keluarga	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menjaga privasi dan keselamatan pasien selama pemeriksaan	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil pengkajian secara sistematis (SOAP/partograf)	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa :

J. Daftar Pustaka

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar profesi bidan* (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020). Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar kompetensi kerja bidang kebidanan* (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022). Kementerian Kesehatan RI.
- Rizkia, A., et al. (2025). Pengkajian ibu bersalin dan penilaian kesejahteraan janin. *Jurnal Kebidanan*, xx(x), xxx–xxx.
- Zuliyanti, E., & Priyanto, S. (2021). Asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan pendekatan komprehensif. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, xx(x), xxx–xxx.
- Jurnal Kebidanan. (2025). Pengkajian ibu bersalin dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. *Jurnal Kebidanan*, xx(x), xxx–xxx.
- Jurnal Ilmu Kesehatan. (2023). Pencegahan infeksi dan manajemen risiko pada persalinan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, xx(x), xxx–xxx.
- Modul Kebidanan. (2023). *Modul praktik pengkajian ibu bersalin*. Institusi Pendidikan Kebidanan.
- World Health Organization. (2008). *Education material for teachers of midwifery: Midwifery education modules (2nd ed.)*. WHO Press.
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. WHO Press.

BAB 3

PEMANTAUAN KEMAJUAN PERSALINAN DENGAN PARTOGRAF DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KLINIS

Capaian Profil Lulusan

1. Melakukan clinical reasoning berbasis data untuk penapisan masalah dan pengambilan keputusan intrapartum
2. Melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV serta tindakan awal kegawatdaruratan intrapartum secara aman dan bermutu.
3. Mendokumentasikan asuhan dan rujukan secara akurat serta memanfaatkan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi mutu dan pengembangan diri.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. Menerapkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam asuhan persalinan dan situasi kegawatdaruratan intrapartum.
2. Melakukan pengkajian komprehensif ibu bersalin dan kesejahteraan janin serta menafsirkan temuan untuk penetapan masalah/prioritas.
3. Merencanakan dan melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV berbasis bukti termasuk dukungan, kenyamanan, manajemen nyeri, dan pencegahan komplikasi.
4. Melakukan penatalaksanaan awal kegawatdaruratan intrapartum dan menetapkan indikasi rujukan berdasarkan kondisi klinis.
5. Menyusun dokumentasi klinis (termasuk partograf) dan dokumen rujukan secara akurat serta menggunakan data untuk evaluasi mutu

Uraian Materi

Aktivitas Belajar

Teori Dasar

A. Partograf

Dalam pelayanan kesehatan maternal, **Angka Kematian Ibu (AKI)** masih menjadi salah satu masalah yang serius. Salah satu kondisi yang berkontribusi terhadap tingginya AKI terjadi pada proses persalinan. Beberapa penyebab yang sering ditemukan antara lain perdarahan obstetrik, persalinan macet, serta berbagai komplikasi selama persalinan. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dideteksi lebih dini melalui penggunaan partograf sebagai alat pemantauan persalinan. Partograf membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis secara tepat dengan mengenali tanda-tanda gangguan persalinan, sehingga penatalaksanaan yang sesuai dapat segera diberikan (Afriani et al., 2023).

WHO merekomendasikan penggunaan partograf untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan diagnosis dini serta penatalaksanaan persalinan yang mengalami hambatan atau persalinan macet. Partograf merupakan lembar pencatatan berbentuk grafik yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk memantau kemajuan persalinan serta kondisi ibu dan janin selama ibu berada pada fase aktif kala I persalinan (WHO, 1994).

Partograf terdiri dari satu lembar yang berisi berbagai komponen pemantauan penting selama proses persalinan. Komponen tersebut meliputi identitas ibu, pemantauan denyut jantung janin, warna air ketuban, keadaan molase (tumpang tindih tulang kepala janin), pembukaan serviks, penurunan kepala janin, frekuensi dan kekuatan kontraksi uterus, pencatatan cairan serta obat-obatan yang diberikan, tanda-tanda vital ibu, serta dokumentasi pengeluaran urine. Melalui pencatatan tersebut, tenaga kesehatan dapat memantau perkembangan persalinan secara sistematis sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan yang tepat (WHO, 1994).

Partograf merupakan alat pemantauan persalinan yang digunakan untuk mencegah terjadinya persalinan lama dan persalinan macet dengan membantu tenaga kesehatan mengenali secara lebih cepat apabila terjadi penyimpangan dari kemajuan persalinan normal. Selain itu, partograf berperan dalam mendeteksi secara dini kondisi gawat janin sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut, seperti sindrom aspirasi mekonium. Oleh karena itu, penggunaan partograf oleh tenaga kesehatan di berbagai tingkat pelayanan kesehatan sangat dianjurkan untuk menurunkan risiko komplikasi persalinan serta meningkatkan keselamatan ibu dan bayi (Getu et al., 2020).

B. Manfaat Penggunaan Partograf dalam Pemantauan Persalinan

Partograf merupakan salah satu alat penting dalam pemantauan kemajuan persalinan yang digunakan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan berbagai penelitian, penggunaan partograf terbukti memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan serta keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sharma S dan kolega menunjukkan bahwa pemantauan persalinan menggunakan partograf dapat menurunkan durasi kala I dan kala II persalinan serta meningkatkan skor Apgar pada bayi baru lahir, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan ibu dan bayi (Sharma et al., 2022).

Selain itu, perkembangan teknologi juga menghadirkan inovasi berupa partograf digital. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Ningrum menunjukkan bahwa penggunaan partograf digital dapat meningkatkan kualitas pemantauan persalinan serta membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis selama proses persalinan. Sistem digital juga mempermudah proses pencatatan serta dapat mengurangi kesalahan dalam dokumentasi (Ningrum, 2023).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tri Larasati dan Rini Dewi menjelaskan bahwa partograf merupakan alat yang efektif untuk memantau kemajuan persalinan dan mendeteksi adanya penyimpangan dalam proses persalinan. Dengan adanya pemantauan yang sistematis melalui partograf, tenaga kesehatan dapat lebih cepat mengambil keputusan klinis yang tepat sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi persalinan (Larasati & Dewi, n.d.).

Selain itu, hasil systematic review yang dilakukan oleh Djimeli Michel dan kolega menunjukkan bahwa penggunaan partograf secara tepat merupakan intervensi yang sederhana, efektif, dan relatif murah dalam upaya pencegahan persalinan lama dan persalinan macet, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di berbagai negara (Djimeli et al., 2025).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan partograf memiliki peran penting dalam pemantauan persalinan. Partograf tidak hanya membantu bidan dalam memantau kemajuan persalinan, tetapi juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap kemungkinan komplikasi sehingga dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan.

C. Komponen Partograf

Partograf menurut WHO mencatat beberapa komponen penting sebagai berikut:

1. Identitas umum pasien

meliputi nama, usia, alamat, serta waktu masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Identitas obstetric

yang mencakup gravida (G), para (P), abortus (A), kondisi ketuban (status pecah, waktu pecah, dan warna air ketuban), serta waktu mulai timbulnya his untuk membantu menentukan fase persalinan serta menilai kemajuan persalinan. Berikut ini adalah gambar identitas umum dan identitas obstetric pada partograf:

LEMBAR PARTOGRAF

No. Register		Nama Ibu :		Umur:		G:		P:		A:	
No.Puskesmas		Tanggal:		Jam:							
Ketuban pecah	sejak jam	mules sejak jam									

3. Kondisi janin

Pemantauan kondisi janin bertujuan untuk menilai kesejahteraan janin selama persalinan. Parameter yang dicatat meliputi denyut jantung janin (DJJ), warna air ketuban, dan molase tulang kepala janin. Denyut jantung janin normal umumnya berada pada rentang 120–160 kali per menit dan dipantau secara berkala. Nilai di luar rentang tersebut dapat menunjukkan adanya gangguan, seperti hipoksia atau asfiksia. Warna air ketuban juga menjadi indikator kondisi janin; air ketuban jernih menunjukkan keadaan normal, sedangkan air ketuban bercampur mekonium dapat mengindikasikan adanya stres pada janin. Air ketuban dicatat dalam partograf menggunakan simbol tertentu. Kode yang digunakan meliputi:

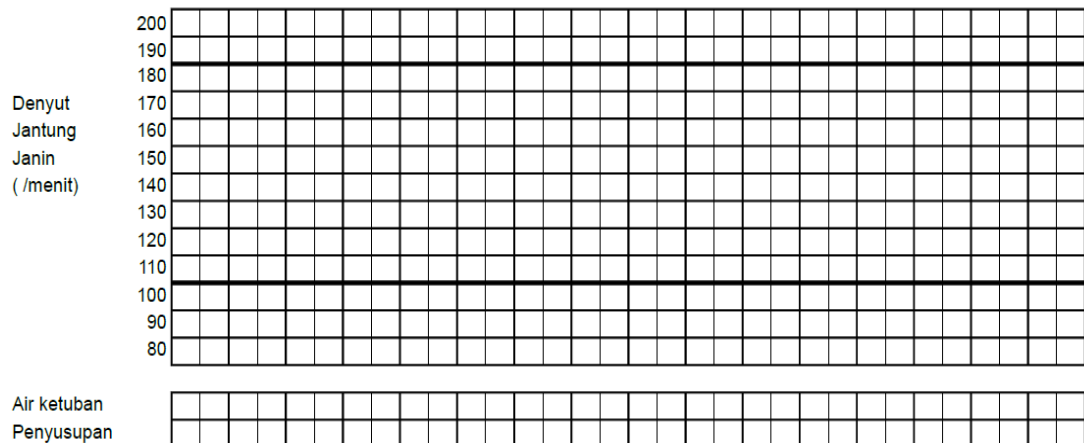
- U yang menunjukkan ketuban masih utuh
- J untuk air ketuban jernih
- M untuk air ketuban yang bercampur meconium
- D untuk darah yang terdapat pada air ketuban
- K untuk kondisi air ketuban yang sedikit atau kering.

Apabila air ketuban bercampur mekonium atau darah atau jumlahnya sangat sedikit, kondisi ini perlu diwaspadai sebagai tanda kemungkinan terjadinya gawat janin, sehingga diperlukan pemantauan denyut jantung janin secara lebih intensif.

Molase menggambarkan derajat tumpang tindih tulang kepala janin akibat tekanan selama persalinan. Pencatatan molase pada partograf menggunakan beberapa kategori, yaitu:

- Angka 0 menunjukkan tidak terjadi molase,
- Tanda (+) menunjukkan tulang kepala saling bersentuhan
- Tanda (++) menunjukkan adanya tumpang tindih tulang kepala
- Tanda (+++) menunjukkan tumpang tindih yang berat. Penilaian ini penting untuk mengetahui adanya hambatan atau tekanan berlebih selama proses

persalinan. Penilaian molase digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan hambatan mekanis, seperti disproporsi sefalopelvik.



Gambar 3.1 Penilaian molase

4. Pembukaan serviks

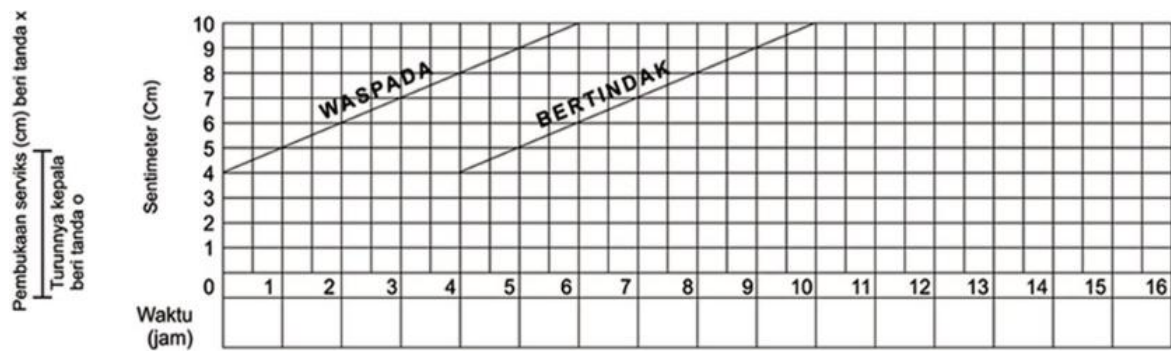
Pencatatan pembukaan serviks dimulai saat ibu memasuki fase aktif persalinan yaitu saat memasuki pembukaan serviks 4 cm. Hasil pemeriksaan pertama dicatat pada garis waspada dengan menggunakan tanda "X" sebagai titik awal pemantauan. Garis waspada ini menjadi acuan untuk menilai apakah kemajuan persalinan masih dalam batas normal. Pemeriksaan pembukaan serviks dilakukan setiap 4 jam atau sesuai indikasi. Jika pada pemeriksaan ditemukan pembukaan kurang dari 4 cm, maka hasil pemantauan dicatat pada lembar observasi.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan pembukaan serviks berikutnya dicatat sesuai dengan waktu pemeriksaan pada partograf. Setiap tanda "X" ditempatkan berdasarkan waktu dan derajat pembukaan, kemudian dihubungkan dengan garis untuk menunjukkan perkembangan persalinan. Dengan cara ini, kemajuan pembukaan serviks dapat dipantau secara berurutan dan memudahkan dalam menilai apakah persalinan berjalan normal atau mengalami keterlambatan.

5. Penurunan Bagian Terbawah atau Presentasi Janin

Penilaian terhadap penurunan bagian terbawah janin dilakukan setiap 4 jam dengan mencatat hasil pemeriksaan pada partograf. Hasil penilaian tersebut ditandai dengan simbol "O" sesuai waktu pemeriksaan, kemudian dihubungkan dengan garis untuk menggambarkan perkembangan penurunan janin.

Derajat penurunan kepala janin dinilai menggunakan skala dari 5/5 hingga 0/5, yang menunjukkan posisi bagian terbawah janin, apakah masih berada di atas simfisis pubis atau telah masuk ke dalam rongga panggul.



Gambar 3.2 Penurunan Bagian Terbawah atau Presentasi Janin

6. Kontraksi uterus

Pencatatan kontraksi uterus dalam partograf bertujuan untuk menilai kekuatan dan efektivitas kontraksi dalam mendukung kemajuan persalinan. Kontraksi yang adekuat akan berperan dalam pembukaan serviks dan penurunan kepala janin selama proses persalinan (Chhugani et al., 2024).

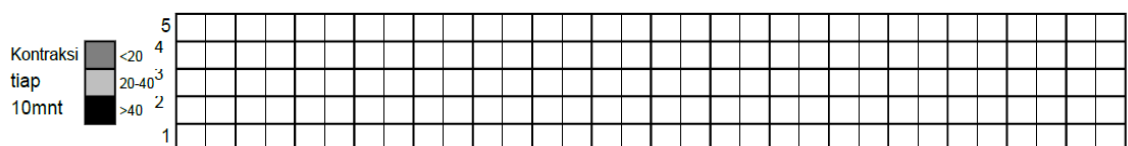
a. Frekuensi Kontraksi

Frekuensi kontraksi dicatat berdasarkan jumlah kontraksi yang terjadi dalam waktu 10 menit. Hasil pengamatan ini kemudian dituliskan dalam bentuk kolom pada partograf. Tinggi kolom menunjukkan jumlah kontraksi dalam 10 menit.

b. Durasi Kontraksi

Durasi kontraksi juga dicatat untuk menilai kekuatan kontraksi uterus. Dalam partograf, durasi kontraksi digambarkan dengan simbol tertentu, yaitu:

- 1) Titik-titik (•) menunjukkan durasi kontraksi kurang dari 20 detik.
- 2) Arsiran menunjukkan durasi kontraksi antara 20–40 detik.
- 3) Blok hitam penuh menunjukkan durasi kontraksi lebih dari 40 detik.



Gambar 3.3 Durasi Kontraksi

Penggunaan simbol ini memudahkan untuk melihat kekuatan kontraksi secara visual dalam grafik partograf. Pengisian kontraksi uterus dilakukan setiap 30 menit dengan cara:

- 1) Mengamati jumlah kontraksi dalam 10 menit.
- 2) Menghitung durasi masing-masing kontraksi.
- 3) Mengisi kolom kontraksi sesuai jumlah kontraksi yang terjadi.
- 4) Memberikan simbol (titik, arsiran, atau hitam penuh) sesuai durasi kontraksi.

Sebaliknya, apabila kontraksi kurang dari 3 kali dalam 10 menit atau durasinya kurang dari 20 detik, kondisi tersebut menunjukkan kontraksi yang tidak adekuat sehingga dapat menyebabkan keterlambatan kemajuan persalinan. Dalam kondisi tertentu, bidan perlu mempertimbangkan intervensi untuk meningkatkan efektivitas kontraksi (Kusumawati et al., 2025).

Di bagian bawah kolom observasi kontraksi uterus tersedia kolom untuk mencatat pemberian obat dan cairan. Pada pemberian oksitosin, apabila infus telah dimulai, maka perlu dicatat jumlah unit oksitosin dalam setiap volume cairan serta laju tetesan per menit dalam 30 menit. Sementara itu, untuk obat dan cairan intravena lainnya, seluruh informasi harus dicatat secara lengkap sesuai dengan kolom waktu yang tersedia pada bagian yang telah disediakan.

[illegible]

Kondisi ibu dalam partograf bertujuan untuk menilai keadaan umum ibu serta mendeteksi adanya penyimpangan atau komplikasi yang dapat terjadi selama persalinan, meliputi pemantauan tekanan darah, nadi, suhu tubuh, produksi urine, pemberian cairan dan obat-obatan (Kusumawati et al., 2025).

Frekuensi nadi mencerminkan kondisi hemodinamik ibu. Peningkatan nadi dapat disebabkan oleh nyeri, kecemasan, dehidrasi, atau infeksi, sedangkan

penurunan nadi dapat menunjukkan gangguan tertentu. Nadi diukur setiap 30 menit dan dicatat dalam kolom nadi dengan menggunakan tanda titik (•).

c. Suhu Tubuh

Suhu tubuh digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi selama persalinan. Peningkatan suhu tubuh dapat menjadi tanda infeksi intrauterin atau komplikasi lainnya. Diukur setiap 2–4 jam dan dicatat dalam kolom suhu dalam satuan derajat Celsius (misalnya: 36,8°C).

d. Produksi Urine

Pemeriksaan urine bertujuan untuk menilai fungsi ginjal dan keseimbangan cairan ibu. Selain volume urine, juga dapat diperiksa kandungan protein dan aseton. Dicatat setiap kali ibu berkemih dalam kolom urine sesuai hasil pemeriksaan.

The form consists of a large grid for recording data over time. The grid is divided into four main sections:

- Nadi:** A vertical column on the left with a scale from 60 to 180 in increments of 10. A double-headed arrow indicates the range.
- Tekanan darah:** A vertical column on the left with a scale from 60 to 180 in increments of 10. A double-headed arrow indicates the range.
- Suhu °C:** A horizontal row at the bottom left with a scale from 60 to 180 in increments of 10.
- Urin:** A horizontal row at the bottom left with a scale from 60 to 180 in increments of 10. It is further divided into three sub-columns: Protein, Aseton, and Volume.

Gambar 3.5 Produksi Urine

9. Halaman Belakang Partograf

Halaman belakang partograf digunakan untuk melengkapi data klinis yang tidak tergambarkan secara rinci pada halaman depan. Halaman belakang berfungsi sebagai lembar dokumentasi yang mencatat kondisi ibu, tindakan yang diberikan, serta hasil persalinan dan kondisi bayi baru lahir. Pada halaman belakang juga berfungsi untuk mencatat hasil pemantauan kala IV selama 2 jam.

Cara pengisian halaman belakang partograf adalah sebagai berikut (Fatriani et al., 2023):

- Lengkapi seluruh data pada kolom yang tersedia sesuai kondisi persalinan. Berikan tanda centang (✓) pada pilihan yang sesuai, lingkari jawaban pada pertanyaan nomor 5, dan untuk nomor 8 dapat dipilih lebih dari satu jawaban.
- Catat informasi persalinan, meliputi tanggal persalinan, nama penolong persalinan, tempat persalinan, riwayat rujukan, pendamping rujukan, serta masalah yang terjadi selama kehamilan dan persalinan.
- Pada Kala I, catat apakah grafik partograf melewati garis waspada atau tidak, masalah yang ditemukan, tindakan yang diberikan, dan hasilnya.

- d. Pada Kala II, dokumentasikan kondisi yang terjadi, seperti episiotomi, pendamping persalinan, gawat janin, distosia bahu, atau masalah lainnya, beserta penatalaksanaan dan hasilnya.
- e. Pada Kala III, catat pelaksanaan IMD, lama kala III, manajemen aktif kala III, kondisi plasenta, jumlah perdarahan, adanya laserasi atau atonia uteri, serta tindakan dan hasil penatalaksanaannya.
- f. Dokumentasikan kondisi ibu setelah persalinan, termasuk hasil pemeriksaan tanda-tanda vital.
- g. Catat kondisi bayi baru lahir, meliputi berat badan, panjang badan, jenis kelamin, penilaian bayi baru lahir, pemberian ASI, dan masalah yang ditemukan.
- h. Pada Kala IV, catat hasil pemantauan selama dua jam pertama postpartum yang meliputi tekanan darah, nadi, suhu, kontraksi uterus, tinggi fundus uteri, kondisi kandung kemih, dan jumlah perdarahan. Pemantauan dilakukan setiap 15 menit pada satu jam pertama dan setiap 30 menit pada satu jam berikutnya. Jika ditemukan komplikasi, dokumentasikan masalah, tindakan yang diberikan, dan hasilnya pada kolom yang tersedia.

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal :
 2. Nama bidan :
 3. Tempat Persalinan :
☐ Rumah Ibu ☐ Puskesmas
☐ Polindes ☐ Rumah Sakit
☐ Klinik Swasta ☐ Lainnya :
 4. Alamat tempat persalinan :
 5. Catatan : ☐ rujuk, kala : I / II / III / IV
 6. Alasan merujuk :
 7. Tempat rujukan :
 8. Pendamping pada saat merujuk :
☐ Bidan ☐ Teman
☐ Suami ☐ Dukun
☐ Keluarga ☐ Tidak ada
- KALA I**
9. Partogram melewati garis waspada : Y / T
 10. Masalah lain, sebutkan :
 11. Penatalaksanaan masalah Tsb :
 12. Hasilnya :
- KALA II**
13. Episiotomi :
☐ Ya, Indikasi
☐ Tidak
 14. Pendamping pada saat persalinan
☐ Suami ☐ Teman ☐ Tidak ada
☐ Keluarga ☐ Dukun
 15. Gawat Janin :
☐ Ya, tindakan yang dilakukan
a.
b.
c.
☐ Tidak
 16. Distosia bahu :
☐ Ya, tindakan yang dilakukan
a.
b.
c.
☐ Tidak
 17. Masalah lain, sebutkan :
 18. Penatalaksanaan masalah tersebut :
 19. Hasilnya :
- KALA III**
20. Lama kala III :menit
 21. Pemberian Oksitosin 10 U im ?
☐ Ya, waktu : menit sesudah persalinan
☐ Tidak, alasan
 22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
☐ Ya, alasan
 23. Penegangan tali pusat terkendali ?
☐ Ya
☐ Tidak, alasan
- KALA IV**
24. Masase fundus uteri ?
☐ Ya
☐ Tidak, alasan
 25. Plasenta lahir lengkap (intact) Ya / Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
a.
b.
 26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
☐ Ya, tindakan :
a.
b.
c.
 27. Lacerasi :
☐ Ya, dimana
☐ Tidak
 28. Jika lacerasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 Tindakan :
☐ Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
☐ Tidak dijahit, alasan
 29. Atoni uteri :
☐ Ya, tindakan
a.
b.
c.
☐ Tidak
 30. Jumlah perdarahan : ml
 31. Masalah lain, sebutkan
 32. Penatalaksanaan masalah tersebut :
 33. Hasilnya :
- BAYI BARU LAHIR :**
34. Berat badangram
 35. Panjang cm
 36. Jenis kelamin : L / P
 37. Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit
 38. Bayi lahir :
☐ Normal, tindakan :
☐ mengeringkan
☐ menghangatkan
☐ rangsang taktil
☐ bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
☐ Asfiksia ringan/pucat/biru/lemas/tindakan :
☐ mengeringkan ☐ bebaskan jalan napas
☐ rangsang taktil ☐ menghangatkan
☐ bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
☐ lain - lain sebutkan
☐ Cacat bawaan, sebutkan :
☐ Hipotermi, tindakan :
a.
b.
c.
 39. Pemberian ASI
☐ Ya, waktu :jam setelah bayi lahir
☐ Tidak, alasan
 40. Masalah lain,sebutkan :
 - Hasilnya :

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi		Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1								
2								

Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :

Gambar 3.6 halaman belakang patograf

D. Interpretasi Partograf

Interpretasi partograf dilakukan dengan melihat posisi grafik pembukaan serviks terhadap garis waspada dan garis tindakan. Apabila grafik pembukaan serviks berada di sebelah kiri garis waspada, maka kemajuan persalinan masih dalam

batas normal. Namun apabila grafik mendekati atau melewati garis tindakan, persalinan. Lembar ini melengkapi halaman depan yang berfokus pada kemajuan persalinan.

E. Partograf Digital

Saat ini partograf telah dikembangkan menjadi aplikasi digital berbasis android yang dapat diakses melalui Google Play Store dan disebut partograf digital. Partograf digital bertujuan untuk mempermudah dalam memantau kemajuan persalinan. Aplikasi ini lebih efektif dibandingkan partograf manual karena memungkinkan pencatatan dan pemantauan kondisi ibu serta janin dilakukan secara elektronik, data persalinan dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur dan mudah diakses sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat waktu. Partograf Digital menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan persalinan yang berfokus pada keselamatan dan kesejahteraan ibu serta bayi (Susiarno, 2024).

F. Tanda Bahaya / Red flag

Red flag merupakan tanda atau kondisi yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses persalinan yang memerlukan perhatian segera dan pengambilan keputusan klinis yang tepat. Dalam penggunaan partograf, red flag membantu bidan untuk lebih waspada terhadap kemungkinan komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan janin.

1. Red Flag Berdasarkan Kemajuan Persalinan

- a. Grafik pembukaan serviks mendekati garis waspada, maka perlu peningkatan pemantauan dan evaluasi ulang
- b. Grafik pembukaan serviks melewati garis waspada merupakan Indikasi kemajuan persalinan tidak sesuai, perlu penilaian menyeluruh
- c. Grafik pembukaan serviks melewati garis Tindakan, memerlukan tindakan segera (intervensi atau rujukan)
- d. Tidak ada kemajuan pembukaan dalam $\geq 2-4$ jam pada fase aktif, curiga persalinan tidak maju

2. Red Flag Kondisi Janin

- a. Denyut jantung janin (DJJ) < 120 atau > 160 x/menit merupakan indikasi kemungkinan gawat janin
- b. DJJ tidak teratur atau sulit didengar, perlu evaluasi segera
- c. Air ketuban bercampur meconium, merupakan risiko aspirasi mekonium / distress janin

3. Red Flag Kondisi Ibu

- a. Tekanan darah meningkat atau menurun drastis, risiko preeklamsia atau syok
- b. Nadi > 100 x/menit secara persisten, tanda kelelahan atau komplikasi
- c. Suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$, Curiga infeksi
- d. Ibu tampak lemah, gelisah, atau kelelahan berat, perlu evaluasi kondisi umum

4. Red Flag Kontraksi Uterus

- a. Kontraksi tidak adekuat (< 3 kali/10 menit, durasi < 40 detik), persalinan berisiko tidak maju
- b. Kontraksi terlalu kuat/terlalu sering, risiko hiperstimulasi

5. Red Flag dalam Pengambilan Keputusan Klinis

- a. Keterlambatan memulai pengisian partograf
- b. Kesalahan dalam plotting atau membaca grafik
- c. Tidak mengenali garis waspada/tindakan
- d. Tidak melakukan evaluasi ulang saat ada penyimpangan
- e. Menunda tindakan atau rujukan
- f. Tidak mempertimbangkan kondisi ibu dan janin secara menyeluruh

Apabila menemukan tanda bahaya maka tindakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Lakukan penilaian ulang secara menyeluruh
- b. Tingkatkan frekuensi pemantauan
- c. Konsultasi atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain
- d. Siapkan tindakan intervensi atau rujukan
- e. Dokumentasikan semua temuan dan tindakan

G. Pengambilan Keputusan Klinis

Pengambilan keputusan klinis merupakan proses memilih tindakan yang paling sesuai berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. Dalam asuhan persalinan, proses ini berlangsung terus-menerus seiring dengan perubahan kondisi ibu dan janin. Oleh karena itu, bidan perlu menggunakan alat bantu yang dapat memberikan gambaran perkembangan persalinan secara jelas dan terarah, salah satunya adalah partograf.

Partograf digunakan untuk mencatat dan memantau kemajuan persalinan, kondisi ibu, serta kondisi janin secara berkala. Data yang dicatat dalam partograf, seperti pembukaan serviks, penurunan kepala janin, denyut jantung janin, serta kontraksi uterus, menjadi dasar dalam menilai apakah persalinan berlangsung sesuai dengan kemajuan yang diharapkan. Dengan adanya pencatatan yang teratur, bidan dapat melihat pola perkembangan persalinan secara lebih mudah.

Partograf dapat membantu memperjelas kapan perlu melanjutkan pemantauan dan kapan harus mulai mempertimbangkan tindakan. Selama grafik pembukaan serviks berada di sebelah kiri garis waspada, persalinan umumnya masih berjalan sesuai dengan kemajuan yang diharapkan, sehingga pemantauan dapat dilanjutkan secara rutin. Ketika grafik mulai mendekati garis waspada, kondisi tersebut menjadi tanda untuk meningkatkan kewaspadaan, misalnya dengan menilai kembali kekuatan kontraksi atau kondisi ibu dan janin.

Apabila grafik melewati garis waspada dan mendekati garis tindakan, bidan perlu melakukan penilaian ulang secara menyeluruh. Pada tahap ini, berbagai kemungkinan mulai dipertimbangkan, seperti adanya hambatan dalam kemajuan persalinan atau kontraksi yang tidak adekuat. Jika grafik telah melewati garis tindakan, maka keputusan yang diambil biasanya mengarah pada tindakan yang lebih lanjut, seperti intervensi atau rujukan, sesuai dengan kondisi yang ditemukan.

Selain melihat kemajuan pembukaan serviks, keputusan klinis juga didasarkan pada komponen lain dalam partograf. Perubahan denyut jantung janin, kondisi air ketuban, maupun tanda-tanda vital ibu dapat memberikan petunjuk tambahan yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan tindakan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan satu parameter, tetapi merupakan hasil dari penilaian menyeluruh terhadap semua data yang tersedia.

Melalui penggunaan partograf, proses pengambilan keputusan klinis menjadi lebih terarah karena didukung oleh data yang tersusun secara sistematis. Bidan tidak hanya mengandalkan perkiraan, tetapi dapat melihat secara langsung perkembangan persalinan dan menyesuaikan tindakan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Hal ini membantu menjaga agar asuhan yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan ibu dan bayi selama proses persalinan berlangsung.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case (diskusi kelompok)

Perempuan berusia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke Puskesmas tanggal 29 Maret 2026 jam 10.00 WIB dengan keluhan mulas sejak 6 jam yang lalu dan belum keluar air-air. Pada pemeriksaan awal didapatkan kontraksi 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 20 detik, dan denyut jantung janin 140 kali/menit, pembukaan serviks 4 cm, penurunan kepala 4/5, ketuban utuh, tidak ada molase.

Pada jam 12.00 WIB dilakukan observasi kembali, kontraksi menjadi lebih kuat, yaitu 3–4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40–45 detik. Tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 80 x/menit, Suhu 36,7°C, DJJ 145 kali/menit. Pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan serviks masih 4 cm, penurunan kepala 4/5, ketuban utuh, tidak ada molase.

Selanjutnya, pada jam 16.00, kontraksi tetap 3–4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40–45 detik, dan denyut jantung janin 150 kali/menit, pembukaan serviks meningkat menjadi 5 cm, penurunan kepala 4/5, ketuban utuh, tidak ada molase.

Pertanyaan Diskusi

1. Pada waktu kapan pengisian partograf mulai dilakukan pada kasus di atas? Jelaskan alasan Anda berdasarkan kondisi kontraksi uterus.?
2. Apakah kemajuan persalinan sesuai dengan kemajuan normal? Jelaskan.
3. Apa masalah yang mungkin terjadi pada kasus ini?
4. Apa keputusan klinis yang sebaiknya diambil berdasarkan hasil interpretasi partograf?
5. Tindakan apa yang perlu dilakukan selanjutnya untuk mendukung kemajuan persalinan dan keselamatan ibu serta janin?

H. Template Soal Osce Partograf

Aktivitas 2 – Shows

OSCE

1.	Nomor stasiun	
2.	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
3.	Judul stasiun/kategori yang diujikan (beri ' <i>bold</i> ' pada kategori yang diujikan) 1. Remaja / Prakonsepsi 2. Hamil normal/deteksi dini/gadar 3. Bersalin normal/deteksi dini/gadar 4. Nifas normal dan Menyusui /deteksi dini 5. Neonatus normal/deteksi dini/gadar 6. KB/Masa antara normal/deteksi dini	
4.	Tujuan stasiun Memberi penilaian pada kompetensi (beri ' <i>bold</i> ' pada kompetensi yang diujikan) 1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau Lab Sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/ masalah	

	4. Keterampilan Klinis Prosedur Tindakan 5. KIE / Konseling 6. Kolaborasi / Rujukan 7. Pendokumentasian 8. Perilaku professional	
5.	Kasus, tugas, intruksi tambahan untuk peserta ujian	<u>Skenario klinik:</u> Seorang Perempuan, Ny. E usia 25 tahun, G1P0A0 datang ke BPM tanggal 10 Desember 2025 jam 10.00 WIB dengan keluhan mules sejak pukul 03.00 WIB. Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik ditemukan bahwa saat ini usia kehamilan aterm, TD 120/80 mmHg, Nadi 84 x/menit, Respirasi 20 x/menit, Suhu 36,3°C, TFU 32 cm, punggung sebelah kanan, presentasi belakang kepala, dengan penurunan kepala 4/5, HIS 4x10 menit, 42 detik, DJJ 145 x/menit, ibu berkemih 100 ml sebelum dilakukan pemeriksaan, protein urin dan aseton (-), pembukaan 7 cm, ketuban utuh, tidak ada penyusupan. Selanjutnya bidan merumuskan diagnosa. <u>Tugas:</u> 1. Rumuskan diagnosa pada kasus tersebut dan tuliskan pada kertas yang telah disediakan 2. Lanjutkan observasi HIS, DJJ, Nadi 3. Dengarkan ketika penguji menyebutkan hasil observasi 4. Lanjutkan dengan pengisian partograf
6.	Instruksi untuk penguji	<u>Instruksi Umum :</u> 1. Pastikan identitas peserta sesuai dengan kartu ujian 2. Tulislah nomor peserta ujian pada lembar penilaian 3. Amati peserta, beri nilai: • Actual mark (0/1/2/3/4) • Global rating (TL/B/L/S) 4. Penguji tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji UK OSCE <u>Instruksi khusus:</u>

		1. Mengamati tindakan yang dilakukan peserta ujian 2. Membacakan hasil observasi: • Jam 10.30 DJJ 130 x/menit, HIS 4 x 10 menit, 45 detik, Nadi 84x/menit • Jam 11.00 DJJ 150 x/menit, HIS 5 x 10 menit, 50 detik, Nadi 80x/menit • Jam 11.30 DJJ 142 x/menit, HIS 5 x 10 menit, 50 detik, Nadi 90 x/menit, HIS 5x10 menit, 50 detik, pembukaan 10 cm, penurunan kepala 1/5,urin 150 ml, selaput ketuban pecah sesaat sebelum pemeriksaan jam 11.20, dan cairan ketubah jernih 3. Memberi penilaian sesuai rubrik penilaian Tugas tambahan: 1. <u>Merapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian sebelumnya agar siap dipakai untuk peserta yang berikutnya.</u>										
7.	Kebutuhan dan interaksi pasien/nakes simulasi yang terstandar	-										
8.	Tipe Ruangan	Ruang pemeriksaan										
9.	Kebutuhan laboran	1. <u>Menjadi keluarga pasien</u> 2. <u>Merapikan merapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian sebelumnya agar siap dipakai untuk peserta yang berikutnya.</u>										
10.	Kebutuhan manekin, peralatan, dan bahan habis pakai	- Model anatomi perut ibu hamil - Model ini diselimuti - Didekat model ini terdapat set pemfis ibu bersalin <table><tr><td>Jenis alat</td><td>Jumlah utama+Cadang</td></tr><tr><td>1. Pengukur waktu</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>2. Lenec</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>3. Hand scon</td><td>40 peserta</td></tr><tr><td>4. Hands sanitizer</td><td>1 botol</td></tr></table>	Jenis alat	Jumlah utama+Cadang	1. Pengukur waktu	1 buah	2. Lenec	1 buah	3. Hand scon	40 peserta	4. Hands sanitizer	1 botol
Jenis alat	Jumlah utama+Cadang											
1. Pengukur waktu	1 buah											
2. Lenec	1 buah											
3. Hand scon	40 peserta											
4. Hands sanitizer	1 botol											

		5. Celemek	1 buah	
		6. Bengkok	1 buah	
		7. Kertas dan ballpoint	40 peserta	
11.	Penulis	Dewi Hanifah, S.ST.,M.Keb		
12.	Referensi	APN, JNPK-KR, 2017		

Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase Persalinan (Partograf)

Kompetensi 1 Pemeriksaan Fisik

Komponen yang dinilai	Skoring	skor
1. Memeriksa DJJ dengan cara mendengarkan pada daerah PM di sebelah kanan bawah pusat, dengan menggunakan lenec dan penunjuk waktu		
2. Memeriksa HIS dengan cara meraba daerah fundus uteri, menghitung frekuensi dan durasi		
3. Memeriksa denyut nadi ibu		

Skoring Kompetensi 1:

- 3 = Jika peserta ujian hanya melakukan observasi dengan lengkap dan tepat
- 2 = Jika Peserta ujian hanya melakukan observasi 2 dari 3 berikut ini dengan tepat/kurang tepat
- 1 = Jika peserta ujian hanya melakukan observasi 1 dari 3 berikut ini dengan tepat/kurang tepat
- 0 = Peserta Ujian tidak melakukan pemeriksaan

Kompetensi 2 Perumusan Diagnosis

Komponen yang dinilai	Skoring	skor
Merumuskan diagnosa dengan tepat		

Skoring Kompetensi 2

- 3 = Peserta ujian merumuskan diagnosa dengan tepat
- 0 = Peserta ujian **tidak** melakukan perumusan diagnosis

Kompetensi 3 Pendokumentasian

Komponen yang dinilai	Skoring	skor
1. Mengisi informasi tentang ibu: Nama ibu, Umur, Gravida, para, abortus, Tanggal dan jam, Waktu pecahnya selaput ketuban, Waktu mulainya mules 2. Mencatat DJJ dan menghubungkan dengan titik lainya dengan garis tidak terputus 3. Mencatat air ketuban dan molase dengan lambang yang sesuai 4. Mencatat pembukaan servik dan menghubungkan tanda "X" dari setiap pemeriksaan dengan garis utuh 5. Mencatat penurunan kepala dengan tanda "O" pada garis waktu yang sesuai 6. Mencatat waktu actual saat pemeriksaan dilakukan 7. Mencatat lamanya kontraksi dalam 10 menit dengan mengisi angka pada kotak yang sesuai dengan lambang – lambang 8. Mencatat nadi setiap 30 menit, tekanan darah tiap 4 jam, temperature tubuh tiap 2 jam pada kolom waktu yang sesuai 9. Mencatat volume urine, protein dan aaseton sedikitnya tiap 2 jam, jika memungkinkan setiap kali berkemih		

Skoring Kompetensi 3

- 3 = Peserta ujian melakukan semua langkah pendokumentasian berikut ini dengan tepat/kurang tepat:
- 2 = Peserta ujian melakukan 6-7 dari 9 langkah pendokumentasian dengan tepat/kurang tepat
- 1 = Peserta ujian melakukan 4-5 dari 9 langkah pendokumentasian dengan tepat/kurang tepat
- 0 = Peserta ujian tidak melakukan pendokumentasian

Kompetensi 4 Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	skor
1. Bersikap hati-hati 2. Menjaga privasi 3. Mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien 4. Menerapkan prinsip PI		

5. Tetap berkomunikasi walaupun berhadapan dengan phantom		
---	--	--

Skoring Kompetensi 4

- 3 = Peserta ujian menunjukkan semua sikap professional
- 2 = Peserta ujian menunjukkan **3-4** dari 5 sikap professional
- 1 = Peserta ujian menunjukkan **1-2** dari 5 sikap professional
- 0 = Peserta ujian tidak menunjukkan sikap professional

Total Skor Dan Kelulusan

Total Skor = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3 (*dicatat di rubrik penilaian*)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =
30

(Kota),

Aktivitas 3

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Komponen	Deskripsi	Kasus
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa saat melakukan tindakan klinis. Penilaian dilakukan secara real time dan diikuti dengan umpan balik segera setelah kegiatan selesai.	Pembimbing mengamati secara langsung mahasiswa saat mengisi partograf pada ibu bersalin, mulai dari menentukan waktu mulai pengisian hingga interpretasi hasil.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan prosedur klinis	Menilai kemampuan mahasiswa dalam

	secara tepat, sistematis, dan sesuai standar praktik serta mampu menginterpretasikan hasil tindakan.	mengisi partograf secara lengkap, akurat, serta menentukan keputusan klinis berdasarkan data persalinan.
Kasus klinik	Kasus yang digunakan merupakan kondisi nyata atau simulasi yang memungkinkan mahasiswa menunjukkan keterampilan klinis secara utuh.	Seorang ibu inpartu fase aktif dengan kontraksi adekuat (≥ 3 kali/10 menit, durasi > 40 detik). Mahasiswa diminta melakukan pengisian partograf berdasarkan hasil pemeriksaan berkala.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama prosedur berlangsung, mulai dari persiapan hingga evaluasi hasil.	Mahasiswa: - Menentukan waktu mulai pengisian partograph - Mengisi data pembukaan serviks, DJJ, kontraksi, dan kondisi ibu - Memplot grafik partograf - Melakukan interpretasi hasil - Menentukan keputusan klinis
Aspek yang dinilai	Komponen kompetensi yang dinilai mencakup domain psikomotor, kognitif, dan afektif.	- Ketepatan waktu mulai pengisian - Ketepatan pengisian partograf - Kemampuan interpretasi

		- Ketepatan keputusan klinis - Ketelitian dan sikap profesional
Fokus observasi pembimbing	Hal-hal yang menjadi perhatian utama penilai selama proses observasi berlangsung.	Pembimbing fokus pada ketelitian mahasiswa dalam pencatatan, kesesuaian dengan data klinis, kemampuan menghubungkan data dengan kondisi pasien, serta logika dalam pengambilan keputusan.
Umpan balik	Diberikan segera setelah tindakan untuk memperkuat kelebihan dan memperbaiki kekurangan mahasiswa.	Pembimbing memberikan masukan terkait kesalahan pengisian, ketidaktepatan interpretasi, serta cara meningkatkan ketelitian dan alur berpikir klinis.
Keputusan penilaian	Hasil akhir penilaian berdasarkan pencapaian kompetensi mahasiswa.	Mahasiswa dinyatakan: - Kompeten - Cukup kompeten - Perlu perbaikan
Makna dalam OBE	Menggambarkan kontribusi penilaian terhadap pencapaian capaian pembelajaran berbasis kompetensi.	DOPS memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori partograf, tetapi mampu menerapkannya dalam praktik klinis secara nyata, termasuk dalam

		pengambilan keputusan klinis.
--	--	-------------------------------

Aktivitas 4

Portofolio

Portofolio disusun sebagai kumpulan bukti yang menunjukkan proses dan perkembangan kemampuan mahasiswa. Bukti yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari satu kegiatan, tetapi dari berbagai pengalaman belajar yang dilakukan secara berulang. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana mahasiswa mencapai kompetensi tersebut.

Beberapa bukti yang dapat dimasukkan dalam portofolio meliputi hasil OSCE dan DOPS terkait pengisian partograf, catatan kasus singkat yang menggambarkan pengalaman mahasiswa dalam memantau persalinan, refleksi mengenai aspek patient safety, serta umpan balik dari pembimbing klinik atau dosen. Melalui catatan kasus, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan keterampilan dalam mencatat data persalinan, menginterpretasikan partograf, dan menentukan langkah asuhan yang sesuai. Refleksi *patient safety* membantu mahasiswa untuk lebih peka terhadap risiko yang mungkin terjadi selama proses persalinan.

Portofolio merupakan penilaian yang dilakukan secara terus-menerus. Penilaian lebih menekankan pada konsistensi kemampuan mahasiswa dalam berbagai kesempatan. Seorang mahasiswa dinilai kompeten apabila mampu menunjukkan keterampilan yang sama secara berulang, misalnya dalam mengisi partograf dengan benar, membaca grafik secara tepat, serta mengambil keputusan klinis yang sesuai dengan kondisi ibu dan janin.

Tabel Portofolio pada Penggunaan Partograf dan Pengambilan Keputusan Klinis

Komponen	Deskripsi	Kasus
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian	Pada topik partograf, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian persalinan, mengisi partograf dengan benar, menginterpretasikan kemajuan persalinan,

		serta mengambil keputusan klinis yang sesuai berdasarkan data ibu dan janin
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah mengisi partograf, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kemampuannya dalam membaca grafik, menilai kemajuan persalinan, dan menentukan keputusan klinis berkembang setelah mendapatkan umpan balik dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium serta performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat hasil ujian keterampilan pengisian dan interpretasi partograf. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa mengisi partograf, memantau kondisi ibu dan janin, serta menentukan keputusan klinis selama persalinan berlangsung.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, termasuk data klinis, masalah kebidanan, tindakan, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu, pembukaan serviks lambat (misalnya dari 4 cm ke 5 cm dalam 4 jam), kontraksi adekuat,

		grafik mendekati garis waspada, interpretasi partograf, serta keputusan klinis yang diambil.
Refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien dan menyusun langkah pencegahan dalam praktik klinis.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya ketepatan waktu memulai partograf, ketelitian dalam membaca grafik, pemantauan DJJ, serta pencegahan keterlambatan pengambilan keputusan ketika kemajuan persalinan tidak sesuai.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan kelebihan dan area yang perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah mampu mengisi partograf dengan urutan yang benar dan memahami garis waspada, namun masih perlu meningkatkan ketelitian dalam plotting grafik dan ketegasan dalam menentukan keputusan klinis.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan, dengan penekanan pada konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari satu kasus, tetapi dari beberapa pengalaman yang menunjukkan bahwa ia mampu secara konsisten mengisi partograf, membaca

		grafik, dan mengambil keputusan klinis dengan tepat.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan partograf sebagai dasar dalam menilai kemajuan persalinan dan menentukan tindakan yang sesuai.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi juga tampak dalam performa nyata yang berulang dan berkembang.	Pada topik partograf, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam praktik kebidanan, khususnya dalam pengambilan keputusan klinis.

Aktivitas 5

Case Report

Tabel Case Report dalam Penggunaan Partograf dan Pengambilan Keputusan Klinis

Komponen	Deskripsi	Kasus
Hakikat <i>case report</i>	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu bersalin primigravida dalam fase aktif, dengan kemajuan

	sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	pembukaan serviks yang lambat, kontraksi adekuat, dan grafik partograf yang mendekati garis waspada.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data persalinan, tetapi juga menjelaskan interpretasi partograf, masalah kebidanan yang muncul, serta keputusan klinis yang diambil berdasarkan kondisi ibu dan janin.
Isi laporan	Isi case report mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, serta pembelajaran dari kasus.	Mahasiswa menuliskan data: mulas sejak beberapa jam, pembukaan serviks dari 4 cm menjadi 5 cm dalam 4 jam, kontraksi adekuat, DJJ dalam batas normal, grafik partograf mendekati garis waspada, analisis kemajuan persalinan lambat, tindakan pemantauan ketat, serta rencana intervensi bila diperlukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinis, ketepatan tindakan, serta kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data partograf dengan kondisi klinis, mengenali

		kemajuan persalinan yang tidak optimal, serta menentukan keputusan klinis yang tepat sesuai kondisi ibu dan janin.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, serta kemampuan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ini, mahasiswa belajar bahwa penggunaan partograf secara tepat, ketelitian dalam membaca grafik, dan ketepatan waktu dalam mengambil keputusan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep partograf, tetapi juga mampu menggunakannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis secara konsisten dalam praktik kebidanan.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Penggunaan Partograf dan Pengambilan Keputusan Klinis

Komponen	Deskripsi	Kasus
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi	Pada kasus persalinan dengan kemajuan lambat, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan

	masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	membaca dan menginterpretasikan partograf dapat menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan dan berdampak pada kondisi ibu dan janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan dalam pengisian atau interpretasi partograf, seperti tidak mengenali garis waspada atau keterlambatan menilai DJJ, dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, serta pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa fokus utama adalah ketepatan penggunaan partograf, pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkala, serta ketepatan dalam menentukan keputusan klinis berdasarkan data yang tersedia.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain keterlambatan memulai pengisian partograf, kesalahan plotting grafik, ketidaktepatan membaca kemajuan persalinan, pemantauan

		DJJ yang tidak adekuat, serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan klinis.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memulai partograf saat kontraksi adekuat, melakukan pencatatan secara berkala dan teliti, memantau DJJ dan tanda vital ibu, mengevaluasi kemajuan persalinan secara terus-menerus, serta mengambil keputusan klinis secara tepat waktu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi praktik selanjutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa ketelitian dalam penggunaan partograf dan kecepatan dalam mengambil keputusan klinis sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinis, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya mampu mengisi partograf, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko, memahami konsekuensi klinis, dan meningkatkan kualitas

		praktik kebidanan secara berkelanjutan.
--	--	--

I. Ringkasan

Partograf merupakan alat bantu yang digunakan untuk memantau kemajuan persalinan serta kondisi ibu dan janin. Pengisian partograf dimulai ketika persalinan telah memasuki fase aktif yaitu pembukaan serviks 4 cm disertai kontraksi yang adekuat, yaitu minimal 3 kali dalam 10 menit dengan durasi lebih dari 40 detik. Melalui pencatatan yang teratur, partograf membantu bidan dalam menilai apakah persalinan berlangsung sesuai dengan kemajuan yang diharapkan atau menunjukkan tanda penyimpangan.

Partograf tidak hanya digunakan sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis. Penilaian kemajuan persalinan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu parameter, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti perubahan pembukaan serviks, penurunan kepala janin, kekuatan kontraksi, serta kondisi ibu dan janin. Pemantauan dilakukan secara serial sehingga pola kemajuan dapat terlihat dengan lebih jelas.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah posisi grafik pembukaan serviks terhadap garis waspada dan garis tindakan. Ketika grafik mendekati atau melewati garis waspada, maka perlu meningkatkan kewaspadaan dan melakukan evaluasi lebih lanjut. Jika grafik melewati garis tindakan, maka diperlukan pengambilan keputusan klinis secara cepat, termasuk mempertimbangkan intervensi atau rujukan. Keterlambatan dalam mengenali kondisi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.

Pengambilan keputusan klinis dalam persalinan harus dilakukan secara tepat waktu dan berbasis data yang akurat. Bidan perlu mampu mengintegrasikan hasil pengkajian, interpretasi partograf, serta kondisi klinis ibu dan janin untuk menentukan langkah asuhan yang paling sesuai. Keputusan tidak hanya berfokus pada kemajuan persalinan, tetapi juga pada keselamatan ibu dan bayi sebagai prioritas utama.

Tindakan yang dilakukan dapat berupa peningkatan pemantauan, pemberian asuhan suportif, hingga kolaborasi atau rujukan ke fasilitas yang lebih mampu apabila ditemukan tanda-tanda penyimpangan. Dalam proses ini, komunikasi dengan ibu dan keluarga menjadi bagian penting agar setiap keputusan dapat dipahami dan didukung dengan baik.

Dengan penggunaan partograf yang tepat dan kemampuan pengambilan keputusan klinis yang baik, dapat mendeteksi lebih dini masalah dalam persalinan dan mencegah terjadinya komplikasi. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan keselamatan ibu dan bayi melalui asuhan kebidanan yang berkualitas dan berbasis bukti.

Alur Asuhan Singkat

Ibu inpartu fase aktif (kontraksi adekuat) → mulai pengisian partograf → lakukan pemantauan ibu dan janin secara berkala → plot pembukaan serviks, kontraksi, DJJ, dan penurunan kepala → telaah kemajuan persalinan secara serial → nilai posisi grafik terhadap garis waspada/tindakan → identifikasi adanya penyimpangan kemajuan persalinan → lakukan penilaian menyeluruh ibu dan janin → tentukan masalah klinis → ambil keputusan (lanjut observasi / intervensi / kolaborasi / rujukan) → lakukan tindakan sesuai kebutuhan → dokumentasi lengkap dan komunikasi (handover) yang jelas

Tabel Red Flag dan Eskalasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Grafik pembukaan serviks mendekati atau melewati garis waspada	Kemajuan persalinan mulai tidak sesuai harapan	Tingkatkan frekuensi pemantauan, evaluasi ulang kondisi ibu dan janin, siapkan kemungkinan intervensi
Grafik pembukaan serviks melewati garis tindakan	Persalinan tidak maju dan memerlukan tindakan segera	Lapor ke pembimbing/DPJP, lakukan evaluasi menyeluruh, siapkan intervensi atau rujukan
Pembukaan serviks tidak menunjukkan kemajuan pada pemantauan serial ($\geq 2-4$ jam fase aktif)	Curiga persalinan tidak maju	Evaluasi power, passenger, passage; tentukan kebutuhan intervensi atau rujukan
Kontraksi adekuat tetapi tidak diikuti kemajuan pembukaan	Kemungkinan distosia atau disproporsi	Jangan menunda evaluasi; siapkan kolaborasi atau rujukan

DJJ <110 x/menit atau >160 x/menit	Menunjukkan kemungkinan gawat janin	Reposisi ibu, nilai cepat kondisi ibu-janin, lapor segera, percepat eskalasi
Air ketuban pecah dengan meconium	Risiko kompromi janin	Pantau DJJ lebih sering, siapkan tindakan lanjutan dan rujukan
Kesalahan atau keterlambatan pengisian partograph	Risiko salah interpretasi dan keterlambatan keputusan	Koreksi pencatatan segera, lakukan evaluasi ulang, tingkatkan ketelitian dokumentasi
Tidak dilakukan evaluasi saat grafik mendekati garis waspada	Risiko keterlambatan deteksi masalah	Tingkatkan kewaspadaan, lakukan penilaian menyeluruh, diskusikan dengan pembimbing
Penurunan kepala tidak sesuai dengan kemajuan pembukaan	Curiga adanya hambatan persalinan	Evaluasi kemungkinan malposisi/disproporsi, siapkan rujukan
Tanda vital ibu tidak stabil (nadi meningkat, suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$, tekanan darah abnormal)	Risiko komplikasi maternal (infeksi, kelelahan, gangguan lain)	Lakukan stabilisasi awal, pantau ketat, kolaborasi atau rujukan
Keputusan klinis sudah jelas tetapi tindakan tertunda	Meningkatkan risiko komplikasi ibu dan janin	Segera lakukan tindakan atau rujukan, pastikan komunikasi dan dokumentasi jelas

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab: Partograf dan Pengambilan Keputusan Klinis

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah dapat menjelaskan pengertian dan fungsi partograf dalam pemantauan persalinan	☐	☐	_____
2	Saya sudah memahami kapan waktu yang tepat untuk mulai mengisi partograf (fase aktif dengan kontraksi adekuat)	☐	☐	_____
3	Saya sudah dapat melakukan pengkajian awal ibu inpartu secara sistematis	☐	☐	_____
4	Saya sudah dapat menilai kontraksi (frekuensi, durasi, kekuatan) secara tepat	☐	☐	_____
5	Saya sudah dapat menilai pembukaan serviks dan penurunan kepala berdasarkan data klinis	☐	☐	_____
6	Saya sudah dapat mengisi partograf secara lengkap dan benar	☐	☐	_____
7	Saya sudah dapat memplot grafik partograf dengan tepat	☐	☐	_____
8	Saya sudah dapat membaca dan menginterpretasikan partograf (garis waspada dan tindakan)	☐	☐	_____
9	Saya sudah dapat mengenali kemajuan persalinan yang tidak sesuai melalui partograph	☐	☐	_____
10	Saya sudah dapat mengidentifikasi masalah klinis berdasarkan data partograf dan kondisi ibu-janin	☐	☐	_____
11	Saya sudah dapat mengenali tanda bahaya pada ibu selama persalinan	☐	☐	_____

12	Saya sudah dapat mengenali tanda bahaya pada janin (misalnya perubahan DJJ)	☐	☐	_____
13	Saya sudah dapat menentukan keputusan klinis yang sesuai (observasi, intervensi, kolaborasi, rujukan)	☐	☐	_____
14	Saya sudah dapat melakukan tindakan awal yang aman sesuai kewenangan	☐	☐	_____
15	Saya sudah dapat melakukan pemantauan ibu dan janin secara berkala dan sistematis	☐	☐	_____
16	Saya sudah dapat mengomunikasikan kondisi ibu dan rencana tindakan kepada keluarga	☐	☐	_____
17	Saya sudah dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan rujukan	☐	☐	_____
18	Saya sudah dapat menyiapkan rujukan dan melakukan handover dengan jelas dan singkat	☐	☐	_____
19	Saya sudah dapat mendokumentasikan hasil pemantauan dan tindakan dalam partograf secara tepat	☐	☐	_____
20	Saya sudah dapat menunjukkan sikap profesional, menjaga keselamatan dan kenyamanan pasien	☐	☐	_____

Refleksi Singkat Mahasiswa:

J. Daftar Pustaka

- Afriani, A., Amdadi, Z. A., & Nengsi, R. (2023). Efektivitas Penggunaan Partograf Dalam Pengambilan Keputusan Klinik. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 18(1), 107–111.
- Chhugani, M., Chauhan, P., & Kharb, R. (2024). *Myles Textbook for Obstetrics and Gynaecology Nursing I and II (Two Volume Set) _ 17e_SAE–1E-E-Book*. Elsevier Health Sciences.
- Djimeli, A. D. K., Ateudjieu, J., & Kenfack, B. (2025). Partograph Utilization During Labor Monitoring in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Maternal and Child Health and AIDS*, 14, e018.
- Fatriani, R., ST, S., Susiatmi, B. S. A., ST, S., Keb, M., Suminar, B. E. R., ST, S., KM, M., Lailiyah, S. R., & SiT, S. (2023). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir (Evaluasi Berbasis Uji Kompetensi)*. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Getu, K., Girma, B., Moshago, T., & Tamru, E. (2020). *Heliyon Utilization of partograph during labour: A case of Wolaita Zone , Southern Ethiopia*. 6(November), 4–8. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05633>
- Kusumawati, B. E., ST, S., Riansih, C., ST, S., Keb, M., Hanum, E. A., Keb, S. S. T., Keb, M. T., & Harahap, H. T. (2025). *Buku Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Kala I*. Mahakarya Citra Utama Group.
- Larasati, T., & Dewi, R. (n.d.). *Analysis of Independent Practice Midwives in West Pasaman District Using Partograph in Normal Delivery Care*.
- Ningrum, W. M. (2023). *Effectiveness of Digital Partographs on Clinical Decision-Making in the Delivery Process by Midwives*.
- Sharma, S., Parwez, S., Batra, K., & Pareek, B. (2022). Enhancing safe motherhood: Effect of novel partograph on labor outcomes and its utility: An Indian perspective. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11(11), 7226–7232. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_1326_22
- Susiarno, H. (2024). *Pengembangan Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Penerbit NEM.
- WHO. (1994). Partograph in management of labour. World Health Organization maternal health and safe motherhood programme. *Lancet*, 343, 1399–1404.

BAB 4

ASUHAN PERSALINAN KALA I: DUKUNGAN, KENYAMANAN, DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi efektif dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko pada asuhan intrapartum.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan clinical reasoning berbasis data untuk penapisan masalah dan pengambilan keputusan intrapartum.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan asuhan persalinan kala I-IV serta tindakan awal kegawatdaruratan intrapartum secara aman dan bermutu.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Mendokumentasikan asuhan dan rujukan secara akurat serta memanfaatkan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi mutu dan pengembangan diri.	CPMK-7; CPMK-4; CPMK-1

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Merencanakan dan melaksanakan asuhan persalinan kala I-IV berbasis bukti termasuk dukungan, kenyamanan, manajemen nyeri, dan pencegahan komplikasi.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab 5. Asuhan Persalinan Kala I: Dukungan, Kenyamanan, dan Pencegahan Komplikasi	5.1 Merancang dan memberikan dukungan, kenyamanan, serta pemenuhan kebutuhan dasar ibu pada kala I.	5.2 Menerapkan pencegahan komplikasi kala I melalui pemantauan terstruktur dan intervensi sesuai indikasi.	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-4
--	---	--	--------	----------------

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

CPMK-5	OSCE manajemen persalinan; demonstrasi terstruktur	Melaksanakan langkah asuhan kala I–IV sesuai SOP; menerapkan dukungan/nyeri dan tindakan pencegahan komplikasi sesuai indikasi	20	Checklist OSCE; logbook/dokumentasi simulasi
--------	--	--	----	--

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Pelaksanaan asuhan kala I–IV sesuai standar	Urutan kerja tidak tepat; langkah kritis terlewat	Urutan cukup benar namun ada langkah kurang tepat	Urutan benar; langkah kritis terpenuhi	Sangat terampil; langkah kritis lengkap; adaptif terhadap respons ibu-bayi
5.2 Dukungan/nyeri dan pencegahan komplikasi	Intervensi tidak sesuai kebutuhan/indikasi	Intervensi sesuai sebagian; evaluasi kurang	Intervensi sesuai kebutuhan; evaluasi respons dilakukan	Intervensi sangat tepat; edukasi + evaluasi respons konsisten; pencegahan komplikasi terintegrasi

Uraian Materi

A. Deskripsi Materi Pembelajaran

Persalinan merupakan proses fisiologis yang menandai akhir kehamilan dan dimulai dengan adanya kontraksi uterus yang efektif hingga lahirnya bayi dan plasenta. Proses ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu kala I, II, III, dan IV. Kala I persalinan dimulai sejak timbulnya kontraksi yang teratur hingga pembukaan serviks lengkap (10 cm).

Kala I merupakan fase yang sangat penting karena menjadi penentu kelancaran proses persalinan selanjutnya. Pada fase ini, ibu sering mengalami nyeri, kecemasan, dan ketidaknyamanan yang dapat memengaruhi kondisi fisiologis maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan asuhan kebidanan yang komprehensif, meliputi dukungan emosional, pemenuhan kenyamanan, serta upaya pencegahan komplikasi.

Pelayanan persalinan yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti infeksi, persalinan lama, hingga kematian ibu dan bayi. Kepatuhan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan sesuai standar sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi.

Selain itu, observasi yang sistematis terhadap kemajuan persalinan (misalnya dengan partograf) terbukti berperan penting dalam mencegah komplikasi dan meningkatkan hasil persalinan yang aman.

Tinjauan Teori

B. Konsep dasar persalinan Kala I

Pengertian Persalinan kala I adalah fase pembukaan serviks yang dimulai dari kontraksi uterus yang efektif hingga pembukaan lengkap (10 cm). Kala ini terdiri dari:

1. Fase laten (0–3 cm) → kontraksi ringan, durasi lebih lama
2. Fase aktif (4–10 cm) → kontraksi kuat, pembukaan cepat

Selama fase ini terjadi perubahan fisiologis berupa:

1. Dilatasi dan efasemen serviks
2. Peningkatan frekuensi dan intensitas kontraksi
3. Penurunan bagian terbawah janin

Pemantauan persalinan secara sistematis sangat penting karena observasi yang kontinu dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi serta mencegah komplikasi.

1. Prinsip Asuhan Persalinan Kala I

Asuhan persalinan kala I harus berlandaskan prinsip:

- a. Aman (safety)
- b. Bersih (clean delivery)
- c. Berbasis evidence
- d. Berpusat pada ibu (woman-centered care)

Asuhan yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko infeksi, perdarahan, dan komplikasi lainnya.

2. Kebutuhan Dasar Ibu Bersalin pada Kala I

- a. Kebutuhan Fisik
 - 1) Nutrisi dan Cairan
 - 2) Istirahat
 - 3) Mobilisasi
- b. Kebutuhan Psikologis
 - 1) Rasa Aman
 - 2) Dukungan Emosional
 - 3) Pengurangan Kecemasan
- c. Kebutuhan Informasi
 - 1) Penjelasan proses persalinan
 - 2) Edukasi teknik relaksasi
- d. Kebutuhan Lingkungan
 - 1) Privasi
 - 2) Kebersihan
 - 3) Kenyamanan Ruang

C. Asuhan Dukungan Pada Persalinan Kala I

1. Konsep Dukungan Persalinan

Konsep dukungan persalinan adalah elemen krusial dalam asuhan kebidanan yang bertujuan memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang kepada ibu selama proses melahirkan.

Dukungan persalinan adalah intervensi non-farmakologis yang diberikan secara kontinu untuk membantu ibu secara fisik, emosional, dan psikologis.

Dukungan yang terus menerus dari seorang pendamping persalinan kepada ibu selama proses persalinan dan melahirkan, memberikan rasa nyaman, semangat, membesarkan hati ibu dan meningkatkan rasa percaya diri ibu, serta mengurangi kebutuhan tindakan medis. Dukungan minimal berupa sentuhan dan katakata pujian yang membuat nyaman serta memberi penguatan pada saat proses persalinan berlangsung hasilnya akan mengurangi durasi kelahiran.

2. Jenis Dukungan

- a. Dukungan Emosional
 - 1) Memberikan rasa aman dan nyaman
 - 2) Mengurangi kecemasan dan ketakutan
 - 3) Memberikan motivasi dan afirmasi positif
 - 4) Kehadiran Pendamping
- b. Dukungan Fisik
 - 1) Membantu mobilisasi (Jalan, duduk, berdiri)
 - 2) Massage punggung bawah
 - 3) Membantu kebutuhan dasar (makan, minum, eliminasi)
 - 4) Ambulasi
- c. Dukungan Informasional
 - 1) Edukasi proses persalinan
 - 2) Instruksi teknik napas
 - 3) Memberikan informasi perkembangan pembukaan
- d. Dukungan Spiritual dan Budaya
 - 1) Memberikan kesempatan berdoa
 - 2) Menghargai nilai budaya dan kepercayaan ibu

3. Tujuan dan Manfaat Dukungan

- 1) Mengurangi rasa takut dan kecemasan
- 2) Memberikan rasa aman dan nyaman
- 3) Meningkatkan kesiapan ibu hamil

4. Dampak Dukungan Persalinan

Dukungan Kontinu persalinan dapat:

- 1) Mempercepat proses persalinan
- 2) Mengurangi intervensi medis
- 3) Meningkatkan kepuasan ibu

D. Asuhan Kenyamanan pada Kala I

Mahasiswa harus mampu mengimplementasikan teknik kenyamanan berbasis evidence, yang dimana dapat mengurangi rasa nyeri pada ibu pada saat Kala I

1. Konsep Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan disebabkan oleh:

- a. Kontraksi uterus
- b. Dilatasi serviks
- c. Penekanan saraf

Nyeri bersifat subjektif dan dipengaruhi faktor psikologis, pengalaman, dan dukungan sosial

2. Teknik Non-Farmakologi

a. Teknik Relaksasi Pernapasan

- 1) Napas dalam dan ritmis
- 2) Sinkron dengan Kontraksi

Teknik ini terbukti efektif menurunkan nyeri dari berat menjadi sedang serta meningkatkan kenyamanan ibu.

b. Massage

- 1) Massage punggung bawah
- 2) Teknik Counterpressure

Efektif mengurangi nyeri dan meningkatkan relaksasi

c. Kompres Hangat/dingin

- 1) Mengurangi ketegangan otot
- 2) Memberikan efek relaksasi

d. Hidroterapi (jika tersedia)

- 1) Air hangat membantu relaksasi
- 2) Mengurangi nyeri kontraksi

3. Posisi Persalinan

Posisi aktif sangat dianjurkan:

- a. Berdiri
- b. Jongkok
- c. Miring kiri
- d. Dorsal recumbent

4. Lingkungan Nyaman

Lingkungan harus:

- a. Bersih
- b. Aroma Terapi
- c. Tenang
- d. Memiliki pencahayaan yang cukup
- e. Menjaga privasi

Lingkungan yang nyaman dapat menurunkan kecemasan dan memperlancar persalinan.

5. Peran Pendamping

Pendamping persalinan:

- a. Memberikan dukungan emosional
- b. Mengurangi kecemasan
- c. Meningkatkan rasa percaya diri

E. Pencegahan Komplikasi pada Kala I

1. Prinsip Pencegahan

- a. Deteksi dini
- b. Monitoring ketat
- c. Intervensi tepat waktu
- d. Rujukan cepat

2. Pemantauan Persalinan

- a. Pemantauan Partograf

Digunakan untuk memantau kemajuan persalinan dan mendeteksi persalinan lama. Pemantauan terstruktur sangat penting untuk mencegah komplikasi.

- b. Pemantauan DJJ (Detak Jantung Janin)

Normal: 120-160 x/menit. Dan menilai kesejahteraan janin

- c. Pemantauan Tanda Vital ibu

Memantau Tekanan darah, Nadi, dan Suhu

3. Pencegahan Infeksi

Infeksi merupakan salah satu penyebab utama komplikasi persalinan maka dari itu perlu dilakukan:

- a. Teknik Aseptik
- b. Sterilisasi alat
- c. Kebersihan lingkungan

4. Deteksi Dini Risiko

- a. Persalinan lama
- b. Ketuban pecah dini, dapat meningkatkan risiko infeksi pada ibu dan janin.
- c. Distres janin

5. Kolaborasi dan Rujukan

- a. Rujukan tepat waktu
- b. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan

F. Pendekatan Praktis Asuhan Kala I

Langkah Asuhan:

1. Pengkajian
 - a. Riwayat obtetri
 - b. Pemeriksaan fisik
2. Diagnosis
 - a. Menentukan fase persalinan
 - b. Identifikasi masalah
3. Perencanaan
 - a. Dukungan
 - b. Kenyamanan
 - c. Monitoring
4. Implementasi

- a. Teknik relaksasi
 - b. Dukungan emosional
 - c. Pemantauan
5. Evaluasi
- a. Kemajuan persalinan
 - b. Kondisi ibu dan janin

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case

Skenario Kasus

Ny. A, usia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu 5 hari, datang ke ruang bersalin pukul 09.00 WIB dengan keluhan nyeri perut hilang timbul sejak 8 jam yang lalu. Ibu mengatakan merasa cemas karena ini adalah persalinan pertama. Suami mendampingi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan: Keadaan umum: baik, tampak cemas. Tekanan darah: 110/70 mmHg, Nadi: 90 x/menit, Pernapasan: 22 x/menit, Suhu: 36,8°C. DJJ: 144 x/menit, His: 3–4x/10 menit, durasi 40–45 detik, Pembukaan: 5 cm, Ketuban: utuh.

Setelah 4 jam observasi didapat hasil: Pembukaan 8 cm, His semakin kuat dan teratur, Tidak ditemukan tanda komplikasi

Selama proses persalinan, ibu tampak meringis saat kontraksi, memegang perut, dan mengatakan “tidak kuat menahan sakit”. Ibu juga tampak tegang dan sulit mengikuti instruksi.

Pertanyaan Diskusi

1. Termasuk fase apakah kondisi Ny. A saat datang ke fasilitas kesehatan ?
2. Bagaimana komunikasi terapeutik dapat mempengaruhi kondisi ibu ?
3. Mengapa dukungan emosional penting dalam persalinan kala I ?
4. Sebutkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri persalinan ?
5. Posisi apakah selama persalinan perlu diperhatikan?
6. Mengapa pemantauan DJJ penting dilakukan secara berkala?
7. Sebutkan tanda-tanda komplikasi yang harus diwaspadai pada kala I?

G. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	5
2	Judul	Memberikan Kenyamanan dan Pencegahan Komplikasi pada Persalinan Kala I
3	Kasus	Penatalaksanaan asuhan pada ibu bersalin kala I untuk memberikan kenyamanan dan mencegah komplikasi selama proses persalinan.
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Mengidentifikasi kebutuhan ibu selama persalinan kala I 2. Memberikan tindakan untuk meningkatkan kenyamanan ibu 3. Mencegah terjadinya komplikasi selama kala I 4. Melakukan komunikasi efektif dengan ibu bersalin
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang ibu berusia 25 tahun, G1P0A0, datang ke ruang bersalin dengan keluhan mulas sejak 6 jam yang lalu. Ibu tampak cemas, takut dan mengeluh nyeri semakin sering. Hasil pemeriksaan: tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu 36,7°C, DJJ 140 x/menit, kontraksi 3x/10 menit durasi 40 detik, pembukaan serviks 4 cm. Tugas 1. Lakukan pengkajian kondisi ibu. 2. Berikan asuhan untuk meningkatkan kenyamanan ibu selama kala I. 3. Lakukan tindakan pencegahan komplikasi pada persalinan kala I. 4. Jelaskan tindakan yang Anda lakukan kepada ibu dengan komunikasi yang efektif.

7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, penguji menjawab sesuai dialog. 2. Mahasiswa diharapkan melakukan langkah berikut: a. Pengkajian: menilai tanda vital, kontraksi, DJJ, pembukaan serviks, kondisi psikologis ibu b. Memberikan kenyamanan: teknik relaksasi, posisi nyaman, dukungan emosional, teknik napas c. Pencegahan komplikasi: pemantauan kemajuan persalinan, menjaga kebersihan, observasi tanda bahaya d. Komunikasi efektif kepada pasien 3. Penguji tidak diperbolehkan menginterupsi. 4. Penguji memberikan data tambahan jika diminta. Tujuan: Menilai kemampuan mahasiswa dalam: 1. Memberikan Asuhan Kala I 2. Meningkatkan kenyamanan ibu
---	-------------------	--

		3. Mencegah Komplikasi 4. Komunikasi Efektif INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapihan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Data Tambahan (Jika Mahasiswa Bertanya)	Peserta: Apakah ibu merasa ingin mengejan? Penguji: Belum, masih fase aktif awal Peserta: Bagaimana kondisi ketuban? Penguji: Ketuban masih utuh Peserta: Apakah ibu merasa sangat nyeri? Penguji: Ya, ibu mengeluh nyeri semakin kuat Peserta: Apakah ada tanda bahaya? Penguji: Tidak ada tanda bahaya saat ini
9	Kebutuhan manikin	-Phantom ibu bersalin -Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan dalam - Lembar partograf kasus
10	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar rujukan bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
11	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Manekin ibu bersalin 3. Pantum Panggul/serviks 4. Tensimeter 5. Stetoskop 6. Partograf 7. Sarung tangan 8. Jam/stopwatch 9. Doppler 10. Kain/selimut 11. Aroma Terapi

		12. Air minum 13. Formulir observasi 14. Hand sanitizer / tempat cuci tangan + sabun 15. Sampah medis dan non medis
12	Penulis	Veryudha Eka Prameswari, SST.,M.Kes
13	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). <i>Pedoman pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal</i>. Kementerian Kesehatan RI. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. Achmad, I., & Hermanses, S. (2025). Observasi persalinan sebagai strategi pencegahan komplikasi. <i>Jurnal Kebidanan</i>. 4. Rahakbauw, G. Z., & Ernawati. (2025). Standar asuhan persalinan yang bersih dan aman. <i>Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan</i>. 5. Wulandari, S., & Wahyuni, I. (2025). Penerapan relaksasi pernapasan untuk mengurangi nyeri persalinan kala I. <i>Jurnal Ilmiah Kesehatan Indonesia</i>. 6. Lestari, N. I., Aslina, W. I., & Safitri, Y. R. (2025). Hubungan kunjungan ANC terhadap komplikasi persalinan. <i>Jurnal Penelitian Perawat Profesional</i>. 7. Aristina, N. E., & Diana, K. I. (2023). Asuhan persalinan kala I fase laten dengan ketuban pecah dini. <i>Jurnal Berita Kesehatan</i>. 8. Sulistyowati, E. (2024). Asuhan kebidanan berkelanjutan pada ibu bersalin. <i>Inovasi Kesehatan Global</i>. 9. Padhan, A. K., et al. (2024). Monitoring persalinan berbasis evidence.

Cuplikan Rubrik Penilaian OSCE

Stasiun: Penatalaksanaan asuhan pada ibu bersalin kala I memberikan kenyamanan dan mencegah komplikasi selama proses persalinan.

Aspek Penilaian	Kriteria Tidak Kompeten (0)	Kriteria Cukup (1)	Kriteria Kompeten (2)
Pengkajian kondisi Ibu dan Janin	Tidak melakukan pengkajian atau salah menilai kondisi ibu dan janin	Melakukan pengkajian sebagian namun tidak lengkap/sistematis	Melakukan pengkajian lengkap dan sistematis (TTV, DJJ, Kontraksi, pembukaan)
Pemantauan kemajuan persalinan	Tidak melakukan pemantauan kemajuan persalinan	Melakukan pemantauan tetapi tidak teratur atau tidak lengkap	Melakukan pemantauan kemajuan persalinan secara teratur (Partograf)
Pemberian dukungan kenyamanan	Tidak memberikan dukungan atau kenyamanan pada ibu	Memberikan dukungan tetapi kurang optimal	Memberikan dukungan fisik dan emosional secara optimal (posisi, teknis napas, relaksasi)
Pencegahan Komplikasi	Tidak melakukan upaya pencegahan komplikasi	Melakukan upaya tetapi tidak lengkap	Melakukan pencegahan komplikasi dengan tepat (observasi ketat, deteksi dini)
Pemberian kebutuhan dasar ibu	Tidak memenuhi kebutuhan dasar ibu (makan, minum, eliminasi)	Memenuhi sebagian kebutuhan dasar	Memenuhi kebutuhan dasar ibu secara adekuat selama persalinan
Penerapan prinsip pencegahan infeksi	Tidak menerapkan pencegahan infeksi	Menerapkan tetapi tidak konsisten	Menerapkan pencegahan infeksi secara konsisten (cuci tangan, APD)
Edukasi kepada ibu dan keluarga	Tidak memberikan edukasi	Memberikan edukasi tetapi kurang jelas	Memberikan edukasi yang jelas tentang proses

Aspek Penilaian	Kriteria Tidak Kompeten (0)	Kriteria Cukup (1)	Kriteria Kompeten (2)
			persalinan dan tanda bahaya
Komunikasi terapeutik	Tidak berkomunikasi dengan baik	Komunikasi kurang efektif	Komunikasi efektif, empatik, dan mendukung ibu
profesionalisme	Tidak menjaga keselamatan dan etika	Menunjukkan profesionalisme terbatas	Bersikap profesional, menjaga keselamatan, dan bertindak sistematis

Skor Penilaian

- **0 = Tidak dilakukan / salah**
- **1 = Dilakukan tetapi kurang tepat**
- **2 = Dilakukan dengan benar**

Total skor maksimum: 16

H. Ringkasan

Persalinan merupakan proses fisiologis yang menandai akhir kehamilan, dimulai dari kontraksi uterus efektif hingga lahirnya bayi dan plasenta. Proses ini terbagi menjadi empat kala, yaitu kala I, II, III, dan IV. Kala I persalinan dimulai sejak kontraksi teratur hingga pembukaan serviks lengkap (10 cm), dan menjadi fase penting karena menentukan kelancaran persalinan selanjutnya.

Kala I terdiri dari dua fase, yaitu fase laten (0–3 cm) dengan kontraksi ringan dan fase aktif (4–10 cm) dengan kontraksi lebih kuat dan pembukaan lebih cepat. Selama fase ini terjadi perubahan fisiologis berupa dilatasi dan efasemen serviks, peningkatan frekuensi dan intensitas kontraksi, serta penurunan bagian terbawah janin. Pemantauan yang sistematis sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi.

Asuhan kebidanan pada kala I harus berlandaskan prinsip aman, bersih, berbasis evidence, dan berpusat pada ibu (woman-centered care). Kebutuhan ibu meliputi kebutuhan fisik (nutrisi, cairan, istirahat, mobilisasi), psikologis (rasa aman dan dukungan emosional), kebutuhan informasi (edukasi proses persalinan dan teknik relaksasi), serta kebutuhan lingkungan (privasi, kebersihan, dan kenyamanan).

Dukungan persalinan merupakan bagian penting dalam asuhan kala I. Dukungan ini meliputi dukungan emosional, fisik, informasional, serta spiritual dan

budaya. Dukungan yang diberikan secara kontinu dapat meningkatkan rasa nyaman, mengurangi kecemasan dan nyeri, mempercepat proses persalinan, serta mengurangi intervensi medis.

Nyeri pada kala I disebabkan oleh kontraksi uterus, dilatasi serviks, dan tekanan saraf. Penatalaksanaan nyeri dapat dilakukan secara non-farmakologis seperti teknik relaksasi pernapasan, massage, kompres hangat atau dingin, hidroterapi, serta pengaturan posisi persalinan (berdiri, jongkok, miring). Lingkungan yang nyaman, bersih, tenang, serta adanya pendamping juga berperan penting dalam meningkatkan kenyamanan ibu.

Pencegahan komplikasi dilakukan melalui deteksi dini, pemantauan ketat, dan intervensi tepat waktu. Pemantauan meliputi penggunaan partograf untuk menilai kemajuan persalinan, pemantauan detak jantung janin (normal 120–160 x/menit), serta tanda vital ibu. Selain itu, pencegahan infeksi dengan teknik aseptik, sterilisasi alat, dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting. Risiko seperti persalinan lama, ketuban pecah dini, dan distress janin harus dikenali sejak dini agar dapat dilakukan rujukan dan kolaborasi secara tepat.

Pendekatan asuhan kala I meliputi pengkajian, penegakan diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Asuhan yang tepat, sistematis, dan sesuai standar akan meningkatkan keselamatan ibu dan bayi serta mendukung proses persalinan yang aman dan nyaman.

I. Daftar Pustaka

- Achmad, I., & Hermanses, S. (2025). Observasi persalinan sebagai strategi pencegahan komplikasi. *Jurnal Kebidanan*.
- Aristina, N. E., & Diana, K. I. (2023). Asuhan persalinan kala I fase laten dengan ketuban pecah dini. *Jurnal Berita Kesehatan*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022.
- Lestari, N. I., Aslina, W. I., & Safitri, Y. R. (2025). Hubungan kunjungan ANC terhadap komplikasi persalinan. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*.
- Padhan, A. K., et al. (2024). Monitoring persalinan berbasis evidence.

- Rahakbauw, G. Z., & Ernawati. (2025). Standar asuhan persalinan yang bersih dan aman. Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan.
- Sulistyowati, E. (2024). Asuhan kebidanan berkelanjutan pada ibu bersalin. Inovasi Kesehatan Global.
- Wulandari, S., & Wahyuni, I. (2025). Penerapan relaksasi pernapasan untuk mengurangi nyeri persalinan kala I. Jurnal Ilmiah Kesehatan Indonesia.

BAB 5

MANAJEMEN NYERI PERSALINAN: TEKNIK NONFARMAKOLOGIS DAN KOLABORASI FARMAKOLOGIS

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi efektif dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko pada asuhan intrapartum.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan clinical reasoning berbasis data untuk penapisan masalah dan pengambilan keputusan intrapartum.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan asuhan persalinan kala I-IV serta tindakan awal kegawatdaruratan intrapartum secara aman dan bermutu.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Mendokumentasikan asuhan dan rujukan secara akurat serta memanfaatkan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi mutu dan pengembangan diri.	CPMK-7; CPMK-4; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam asuhan persalinan dan situasi kegawatdaruratan intrapartum.
CPMK-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, informed consent, dan kolaborasi interprofesional pada asuhan dan rujukan intrapartum.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menerapkan keselamatan ibu-bayi melalui PPI, K3, pemantauan terstruktur, dan manajemen risiko intrapartum.
CPMK-4	Melakukan pengkajian komprehensif ibu bersalin dan kesejahteraan janin serta menafsirkan temuan untuk penetapan masalah/prioritas.
CPMK-5	Merencanakan dan melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV berbasis bukti termasuk dukungan, kenyamanan, manajemen nyeri, dan pencegahan komplikasi.
CPMK-6	Melakukan penatalaksanaan awal kegawatdaruratan intrapartum dan menetapkan indikasi rujukan berdasarkan kondisi klinis.
CPMK-7	Menyusun dokumentasi klinis (termasuk partograf) dan dokumen rujukan secara akurat serta menggunakan data untuk evaluasi mutu.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Keselamatan Intrapartum	1.1 Menjelaskan ruang lingkup, prinsip, dan standar asuhan persalinan berorientasi ibu-bayi.	1.2 Menganalisis isu etik–legal, hak pasien, dan keselamatan intrapartum pada skenario pelayanan.	CPMK-1	CPMK-3; CPMK-7
Bab 2. Anatomi–Fisiologi Persalinan dan Faktor yang Mempengaruhi Kemajuan Persalinan	2.1 Menguraikan anatomi jalan lahir dan fisiologi persalinan yang relevan untuk pemantauan kemajuan.	2.2 Mengevaluasi faktor maternal–janin–lingkungan yang memengaruhi kemajuan persalinan dan implikasi klinisnya.	CPMK-4	CPMK-5
Bab 3. Pengkajian Ibu Bersalin: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Penilaian Kesejahteraan Janin	3.1 Melakukan anamnesis terarah dan pemeriksaan obstetri untuk memperoleh data klinis prioritas.	3.2 Menilai kesejahteraan janin dan menginterpretasikan temuan untuk identifikasi risiko.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Pemantauan Kemajuan Persalinan dengan Partograf dan Pengambilan Keputusan Klinis	4.1 Mengisi partograf tepat waktu, lengkap, dan konsisten berdasarkan data pemantauan.	4.2 Menetapkan keputusan klinis (observasi, tindakan, kolaborasi, rujukan) berdasarkan tren partograf dan kondisi ibu-janin.	CPMK-7	CPMK-4; CPMK-6
Bab 5. Asuhan Persalinan Kala I: Dukungan, Kenyamanan, dan Pencegahan Komplikasi	5.1 Merancang dan memberikan dukungan, kenyamanan, serta pemenuhan kebutuhan dasar ibu pada kala I.	5.2 Menerapkan pencegahan komplikasi kala I melalui pemantauan terstruktur dan intervensi sesuai indikasi.	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-4
Bab 6. Manajemen Nyeri Persalinan: Teknik Nonfarmakologis dan Kolaborasi Farmakologis	6.1 Memilih dan menerapkan teknik nonfarmakologis untuk manajemen nyeri dan kecemasan ibu.	6.2 Melakukan kolaborasi farmakologis secara aman (indikasi, monitoring efek, edukasi) sesuai kewenangan.	CPMK-5	CPMK-2; CPMK-3
Bab 7. Asuhan Persalinan Kala II: Pimpin Persalinan, Perlindungan Perineum, dan Pencegahan Asfiksia	7.1 Memimpin kala II dengan teknik aman sesuai kondisi ibu-janin (posisi, bimbingan, pemantauan).	7.2 Menerapkan perlindungan perineum dan pencegahan asfiksia melalui tindakan intrapartum yang tepat.	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-4
Bab 8. Asuhan Persalinan Kala III: Manajemen Aktif, Penilaian Plasenta, dan Pencegahan Perdarahan	8.1 Melaksanakan manajemen aktif kala III sesuai standar untuk menurunkan risiko perdarahan.	8.2 Menilai kelengkapan plasenta/selaput dan melakukan tindak lanjut pencegahan/penanganan dini perdarahan.	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-7

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 9. Asuhan Persalinan Kala IV: Pemantauan, Deteksi Dini Syok, dan Stabilitas Ibu	9.1 Melaksanakan pemantauan kala IV dan mencatat hasil pemantauan secara sistematis.	9.2 Mengidentifikasi dini tanda syok dan melakukan stabilisasi awal serta eskalasi kolaborasi sesuai prioritas.	CPMK-3	CPMK-6; CPMK-7
Bab 10. Kegawatdaruratan Intrapartum: Perdarahan, Syok, dan Stabilisasi Awal	10.1 Mengenali cepat perdarahan intrapartum/postpartum awal dan melakukan tindakan awal sesuai algoritme.	10.2 Melakukan stabilisasi awal pada syok dan menyiapkan kolaborasi/rujukan dengan komunikasi efektif.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-3
Bab 11. Distosia dan Partus Lama: Identifikasi, Tindakan Awal, dan Indikasi Rujukan	11.1 Menganalisis distosia/partus lama berdasarkan data klinis dan pemantauan kemajuan persalinan.	11.2 Melakukan tindakan awal yang aman dan menetapkan indikasi rujukan tepat waktu.	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-7
Bab 12. Gawat Janin dan Masalah Air Ketuban: Deteksi Dini, Tindakan Awal, dan Rujukan	12.1 Menginterpretasikan tanda gawat janin dan masalah air ketuban untuk penetapan derajat urgensi.	12.2 Melakukan tindakan awal dan rencana rujukan untuk mencegah perburukan kondisi ibu-janin.	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-2
Bab 13. Preeklamsia/Eklamsia saat Intrapartum: Penanganan Awal, Pencegahan Kejang, dan Rujukan	13.1 Mengidentifikasi preeklamsia berat/eklamsia intrapartum dan melakukan penanganan awal hipertensi sesuai protokol.	13.2 Melaksanakan pencegahan kejang, monitoring ibu-janin, serta koordinasi rujukan aman dan cepat.	CPMK-6	CPMK-3; CPMK-2
Bab 14. Rujukan Intrapartum dan	14.1 Menyampaikan informasi rujukan	14.2 Menyusun dokumentasi rujukan	CPMK-2	CPMK-7;

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Transport Aman: Komunikasi, Dokumentasi, dan Pendampingan Keluarga	terstruktur (mis. SBAR) dan memperoleh persetujuan tindakan secara etis.	dan rencana transport aman termasuk pendampingan keluarga dan serah-terima.		CPMK-1

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian kasus tertulis; esai refleksi terstruktur	Mengidentifikasi ≥ 3 isu etik–legal dan hak pasien pada skenario; memilih tindakan sesuai kewenangan & standar	10	Lembar jawaban kasus; esai refleksi
CPMK-2	Observasi role-play; lembar rating komunikasi	Menyampaikan informasi dengan empati & bahasa jelas; melakukan komunikasi kolaboratif terstruktur (serah-terima/rujukan) tanpa kehilangan data kunci	10	Lembar observasi; rekaman/skrip role-play
CPMK-3	Checklist praktik PPI/K3; audit mini skenario	Melaksanakan hand hygiene & APD tepat; melakukan pemantauan terstruktur dan mengeksekusi pencegahan risiko (mis. identifikasi bahaya & eskalasi)	15	Checklist keterampilan; lembar audit
CPMK-4	Ujian studi kasus; OSCE pengkajian	Mengumpulkan data prioritas lengkap; menginterpretasikan temuan ibu-janin dan	15	Lembar kerja kasus; lembar OSCE

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		menetapkan masalah/prioritas yang konsisten dengan data		
CPMK-5	OSCE manajemen persalinan; demonstrasi terstruktur	Melaksanakan langkah asuhan kala I-IV sesuai SOP; menerapkan dukungan/nyeri dan tindakan pencegahan komplikasi sesuai indikasi	20	Checklist OSCE; logbook/dokumentasi simulasi
CPMK-6	Simulasi skenario kegawatdaruratan; uji keputusan klinis	Melakukan penilaian cepat dan stabilisasi awal sesuai prioritas; menetapkan indikasi rujukan/kolaborasi tepat waktu berdasarkan kondisi klinis	20	Checklist simulasi; catatan keputusan klinis
CPMK-7	Penugasan partograf & dokumentasi; portofolio	Mengisi partograf lengkap dan konsisten; menyusun catatan asuhan & dokumen rujukan dengan data kunci utuh; menyajikan 1 temuan perbaikan berbasis data	10	Partograf; catatan asuhan; dokumen rujukan; portofolio

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Identifikasi	Isu kunci tidak dikenali atau keliru;	Mengenali sebagian isu	Mengenali mayoritas	Mengenali isu secara lengkap,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
isu etik-legal	mengabaikan hak pasien	namun ada yang terlewat/kurang tepat	isu dan mengaitkan dengan hak pasien	memprioritaskan, dan menjustifikasi secara konsisten
1.2 Keputusan profesional sesuai kewenangan	Keputusan tidak sesuai standar/kewenangan; risiko keselamatan meningkat	Keputusan sebagian sesuai namun ragu/tidak konsisten	Keputusan sesuai standar dengan koreksi minor	Keputusan tepat, tegas, berbasis standar, dan mempertimbangkan keselamatan serta martabat pasien

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Komunikasi terapeutik ibu/keluarga	Tidak empatik; informasi membingungkan; tidak cek pemahaman	Empati terbatas; informasi sebagian jelas; cek pemahaman tidak konsisten	Empatik; informasi jelas; cek pemahaman dilakukan	Sangat empatik; informasi ringkas-akurat; cek pemahaman & respons kebutuhan emosional konsisten
2.2 Komunikasi kolaboratif terstruktur (serah-terima/rujukan)	Data kunci hilang; struktur tidak jelas	Struktur ada namun data penting belum lengkap	Struktur jelas; data kunci lengkap; pesan utama tersampaikan	Struktur sangat baik; data lengkap + prioritas/permintaan tindakan jelas; meminimalkan miskomunikasi

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Penerapan PPI dan K3	Tidak konsisten; langkah kritis terlewat	Cukup konsisten namun ada langkah yang kurang tepat	Konsisten dan benar pada langkah utama	Sangat konsisten; benar pada seluruh langkah; mampu mengoreksi risiko di tempat
3.2 Pemantauan terstruktur dan manajemen risiko	Pemantauan tidak terarah; risiko tidak dikenali	Pemantauan ada namun tidak sistematis; risiko dikenali terlambat	Pemantauan sistematis; risiko dikenali dan dicegah	Pemantauan sangat sistematis; antisipasi risiko proaktif dan eskalasi tepat waktu

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kelengkapan pengkajian (anamnesis & fisik)	Data prioritas banyak hilang; teknik tidak tepat	Data cukup namun masih ada bagian prioritas terlewat	Data prioritas lengkap; teknik pemeriksaan tepat	Data sangat lengkap, terfokus, dan efisien; mampu menyesuaikan pada kondisi klinis
4.2 Interpretasi temuan & penetapan prioritas	Interpretasi keliru; prioritas tidak sesuai data	Interpretasi sebagian benar; prioritas belum jelas	Interpretasi benar; prioritas logis dan konsisten	Interpretasi sangat akurat; prioritas tajam; menautkan data dengan rencana tindak lanjut yang tepat

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Pelaksanaan asuhan kala I-IV sesuai standar	Urutan kerja tidak tepat; langkah kritis terlewat	Urutan cukup benar namun ada langkah kurang tepat	Urutan benar; langkah kritis terpenuhi	Sangat terampil; langkah kritis lengkap; adaptif terhadap respons ibu-bayi
5.2 Dukungan/nyeri dan pencegahan komplikasi	Intervensi tidak sesuai kebutuhan/indikasi	Intervensi sesuai sebagian; evaluasi kurang	Intervensi sesuai kebutuhan; evaluasi respons dilakukan	Intervensi sangat tepat; edukasi + evaluasi respons konsisten; pencegahan komplikasi terintegrasi

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Pengenalan dan stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda gawat terlewat; stabilisasi tidak sesuai prioritas	Tanda gawat dikenali namun respon lambat/kurang tepat	Tanda gawat dikenali cepat; stabilisasi sesuai prioritas	Sangat cepat dan sistematis; stabilisasi tepat + antisipasi perburukan
6.2 Keputusan rujukan/kolaborasi dan persiapan aman	Indikasi rujukan tidak tepat; persiapan tidak aman	Indikasi rujukan cukup tepat namun persiapan belum lengkap	Indikasi tepat; persiapan dan komunikasi memadai	Indikasi sangat tepat; persiapan komprehensif; komunikasi jelas; monitoring selama proses terjaga

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Ketepatan partograf dan catatan asuhan	Banyak data tidak tercatat/keliru; tidak konsisten	Data tercatat namun ada bagian kunci belum lengkap	Data lengkap dan konsisten; mudah ditelusuri	Sangat lengkap, rapi, konsisten; mendukung keputusan klinis secara kuat
7.2 Dokumen rujukan dan evaluasi mutu berbasis data	Informasi rujukan tidak utuh; tanpa refleksi	Informasi cukup namun ringkasannya kurang jelas; refleksi dangkal	Informasi utuh; ringkasan jelas; ada temuan perbaikan	Informasi sangat utuh + prioritas jelas; refleksi tajam berbasis data dan menghasilkan rencana perbaikan konkret

Uraian Materi

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar. Persalinan mencakup proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya servik, dan janin turun kedalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 – 42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Sari et al., 2020)

Beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan antara lain:

- **Passenger**

Malpresentasi atau malformasi janin dapat mempengaruhi persalinan normal. Pada faktor passenger, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yakni ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin. Karena plasenta juga harus melalui jalan lahir, maka ia dianggap sebagai penumpang yang menyertai janin.

- **Passage**

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang yang padat, dasar panggul, vagina, dan introitus (lubang luar vagina). Meskipun jaringan lunak khususnya lapisan-lapisan otot dasar panggul ikut menunjang keluarnya bayi, tetapi panggul ibu jauh lebih berperan dalam proses persalinan. Janin harus berhasil menyesuaikan dirinya terhadap jalan lahir yang relatif kaku.

- **Power**

His adalah salah satu kekuatan pada ibu yang menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin ke bawah. Pada presentasi kepala, bila his sudah cukup kuat, kepala akan turun dan mulai masuk ke dalam rongga panggul. Ibu melakukan kontraksi involunter dan volunteer secara bersamaan.

- **Position**

Posisi ibu mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi persalinan. Posisi tegak memberi sejumlah keuntungan. Mengubah posisi membuat rasa letih hilang, memberi rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi. Posisi tegak meliputi posisi berdiri, berjalan, duduk dan jongkok.

- **Psychologic**

Respons Proses persalinan adalah saat yang menegangkan dan mencemaskan bagi wanita dan keluarganya. Rasa takut, tegang dan cemas mungkin mengakibatkan proses kelahiran berlangsung lambat. Pada kebanyakan wanita, persalinan dimulai saat terjadi kontraksi uterus pertama dan dilanjutkan dengan kerja keras selama jam dilatasi dan melahirkan kemudian berakhir ketika wanita dan keluarganya memulai proses ikatan dengan bayi. Perawatan ditujukan untuk mendukung wanita dan keluarganya dalam melalui proses persalinan supaya dicapai hasil yang optimal bagi semua yang terlibat. Wanita yang bersalin biasanya akan mengutarakan berbagai kekhawatiran jika ditanya, tetapi mereka jarang dengan spontan menceritakannya.

- **Penolong**

Penolong adalah bidan yang mengawasi ibu inpartu sebaik-baiknya dan melihat apakah semua persiapan untuk persalinan sudah dilakukan, memberikan obat atau melakukan tindakan hanya apabila ada indikasi untuk ibu maupun janin.

A. Manajemen Nyeri Persalinan

1. Definisi Nyeri Persalinan

Nyeri merupakan salah satu respon sensoris yang di bawa oleh stimulus karena adanya ancaman atau kerusakan jaringan. Nyeri persalinan dapat berupa pengalaman subjektif seseorang tentang sensasi fisik yang disebabkan oleh kontraksi uterus, dilatasi serviks, dan pendataran serviks, serta penurunan janin selama proses persalinan. Akibat dari respon fisiologis terhadap nyeri yaitu peningkatan tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, keringat, diameter pupil, dan ketegangan otot. Salah satu penyebab nyeri adalah adanya kontraksi uterus, nyeri yang timbul disebut nyeri viseral sehingga menimbulkan rasa sakit pada pinggang, daerah perut, dan menjalar ke arah paha. Rasa nyeri persalinan sering digambarkan sebagai sensasi terbakar yang dirasakan saat jaringan meregang (Dahlan et al., 2023). Nyeri persalinan berlangsung sesuai dengan fase persalinan. Penyebab nyeri pada persalinan yaitu disebabkan oleh kontraksi uterus yang menyebabkan uterus tertarik dan serviks mendatar (effacement) dan terjadi dilatasi serviks. Nyeri akan bertambah saat kepala bayi mengalami penurunan hingga rongga pelvis dan menyebabkan peregangan jalan lahir bagian bawah (Bonarska et al., 2025).

2. Penyebab Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan dapat mempengaruhi kecemasan dan kenyamanan ibu saat proses melahirkan, nyeri pada persalinan disebabkan oleh sebagai berikut:

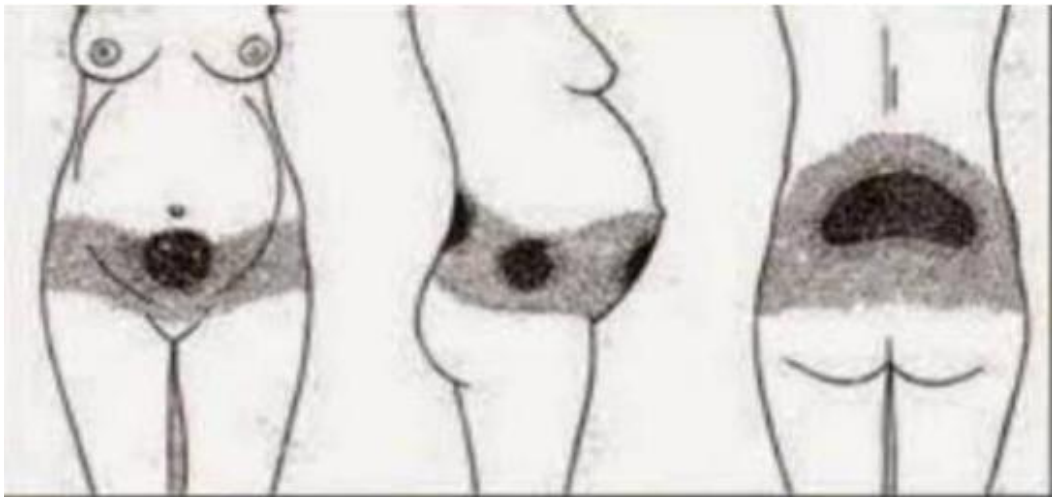
a. Kala I

Nyeri pada kala I persalinan merupakan nyeri viseral yang disebabkan oleh kontraksi rahim dan penipisan serviks. Intensitas nyeri awal tergantung pada bertambahnya proses pembukaan serviks. Pada kala II nyeri yang ditimbulkan karena adanya penekanan pada daerah vagina dan dasar panggul, nyeri ini biasa disebut dengan nyeri somatik.

b. Kala II

Nyeri yang dirasakan saat persalinan kala II adalah nyeri somatik. Nyeri somatik ini terdapat pada tulang, pembuluh darah, syaraf, otot, dan jaringan penyangga lainnya. Ketidaknyamanan yang dirasakan dibagian perineum merupakan nyeri yang tumpul yang sulit dilokalisasi. Nyeri kala II disebabkan oleh tekanan bagian terbawah janin pada vagina, peregangan struktur pelvis, regangan pada organ - organ yang ada didasar panggul seperti (kandung kemih, uretra, rectum, vagina, perineum) dan tekanan pada pleksus lumbo sakralis. Sinyal nyeri dibawa dari perineum ke sacrum 2, 3, 4 dan di hantarkan ke saraf pudendal. Ciri – ciri nyeri yang akan dirasakan pada kala II persalinan ini seperti rasa menyengat, tajam, tarikan, tekanan, rasa terbakar, seperti diplintir serta kram. Nyeri ini dirasakan dibagian regio lumbal (Bonarska et al., 2025).

Area nyeri meliputi dinding abdomen bawah dan area pada bagian lumbal bawah dan sacrum atas.



Gambar 6.1 Area nyeri

(Sumber: Anis Nikmatul Nikmah et al., 2022)

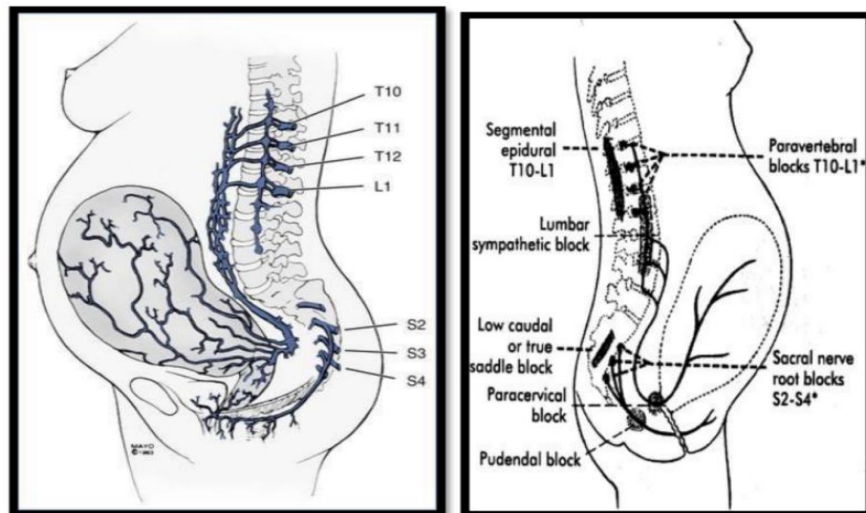
3. Fisiologi Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan adalah proses fisiologis bagi setiap ibu yang melahirkan. Nyeri ini terjadi karena adanya kontraksi uterus akibat proses hormonal dalam persalinan seperti naiknya kadar oksitosin, kadar prostaglandin dan turunnya kadar progesteron. Rasa nyeri selama persalinan kala I disebabkan oleh dilatasi

dan penipisan serviks serta iskemia uterus dikarenakan penurunan aliran darah sehingga oksigen lokal mengalami defisit oksigen akibat kontraksi arteri miometrium, nyeri ini disebut nyeri viseral. Pada persalinan kala II, nyeri yang dirasakan adalah nyeri somatic dimana terjadi pada daerah perineum yang akibat peregangan perineum, tarikan peritonium dan daerah uteroservikal saat kontraksi, penekanan vesika urinaria, usus dan struktur sensitif panggul oleh bagian terendah janin (Purnamawati et al., 2018)

a. Nyeri didasarkan letak dan tingkat kedalamannya

Rasa nyeri persalinan kala I disalurkan melalui segmen saraf spinalis T11-12 dan saraf-saraf asesori torakal bawah serta saraf simpatik lumbal atas. Saraf keluar dari bagian korpus uterus dan serviks. Rasa ketidaknyamanan akibat perubahan pada serviks dan iskemia uterus disebut nyeri viseral. Rasa nyeri dirasakan pada bagian bawah abdomen dan menjalar ke daerah lumbal punggung dan menurun sampai paha. Rasa nyeri yang berasal dari serviks dan korpus uteri disalurkan oleh serabut saraf aferen melalui plexus uterus, plexus pelviks, plexus hipogastrik inferior, middle, posterior dan masuk ke lumbal kemudian masuk ke daerah spinal melewati L1, T12, T11 dan T10. Umumnya ibu akan mengalami rasa nyeri ketika adanya kontraksi dan dari rasa nyeri akan hilang ketika kontraksi berhenti (Fitrianingsih et al., 2025). Kala II persalinan merupakan proses atau tahap pengeluaran bayi, dimana ibu akan merasakan pada perineum (nyeri somatik). Rasa tidak nyaman pada perineum ini timbul akibat peregangan pada jaringan perineum akibat tekanan bagian terendah janin yang akan menekan bagian kandung kemih, usus atau struktur sensitif panggul yang lain. Sinyal nyeri ini diteruskan melewati saraf pudendal menuju S1-4 dan sistem parasimpatis. Nyeri yang dirasakan akan timbul nyeri pada bagian vulva dan sekitarnya serta pinggang. Nyeri pada persalinan kala III adalah nyeri lokal yang disertai kram disebabkan karena adanya robekan akibat distensi dan laserasi serviks, vagina atau jaringan perineum (Purnamawati et al., 2018).



Gambar 2 Fisiologi Nyeri Persalinan
(Sumber:Fitrianingsih et al., 2025)

b. Teori Kontrol Gerbang

Teori Gate Control atau Teori Kontrol Gerbang mengungkapkan bahwa selama proses persalinan implus nyeri berjalan dari uterus sepanjang serat-serat syaraf besar kearah uterus ke substansia gelatinosa di dalam spina kolumna, sel-sel transmisi memproyeksikan pesan nyeri ke otak, adanya stimulasi (seperti vibrasi atau massage) mengakibatkan pesan yang berlawanan yang lebih kuat, cepat dan berjalan sepanjang serat syaraf kecil. Pesan berlawanan ini menutup gate di substansi gelatinosa lalu memblokir pesan nyeri sehingga otak tidak mencatat pesan nyeri tersebut. Melzack dan Wall (1965) mengemukakan teori gate control atau control gerbang, mengusulkan bahwa impuls nyeri dapat diatur atau bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Teori ini menjelaskan bahwa Substansi Gelatinosa (SG) yang ada pada bagian ujung dorsal serabut saraf tulang belakang mempunyai peran sebagai pintu gerbang, mekanisme gate kontrol ini dapat memodifikasi dan merubah sensasi nyeri yang datang sebelum mereka sampai di korteks serebri dan menimbulkan nyeri. Impuls nyeri bisa lewat jika pintu gerbang terbuka dan impuls akan diblok ketika pintu gerbang tertutup. Neuromodulator bisa menutup pintu gerbang dengan cara substansi (Qu & Zhou, 2007).

c. Teori Hormon Endorphin

Endorphin berasal dari istilah kata, "endogen" dan "morfin". Kata endogen mempunyai arti bagian tubuh dan morfin mempunyai arti pereda nyeri opiat. Opiat merupakan obat pereda nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Hormon ini merupakan hormon yang diproduksi secara alami untuk pereda nyeri. Hormon endorfin ini dilepaskan ketika tubuh mengalami kesakitan, tujuan

dari hormon ini yaitu untuk meredakan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang dirasakan (Anis Nikmatul Nikmah et al., 2022).

4. Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri Persalinan

Beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan yaitu sebagai berikut:

a. Usia

Usia seseorang sangat mempengaruhi respon terhadap nyeri. Ibu yang melahirkan diusia muda akan menggambarkan nyeri sebagai sensasi yang sangat menyakitkan disetiap fase dalam persalinan.

b. Kultur

Kepercayaan warga disuatu daerah terhadap nyeri adalah sesuatu yang harus diterima oleh seorang wanita yang melahirkan. Dan mereka menganggap bahwa seseorang harus mengalami nyeri saat bersalin ketika ingin melahirkan anaknya dan hal tersebut bersifat wajar.

c. Makna Nyeri Jika riwayat persalinan ibu sebelumnya tidak menyenangkan maka persalinan saat ini, nyeri bisa dipresepsikan sebagaimana nyeri sebelumnya. Seseorang yang pernah berhasil mengatasi nyeri dimasa lampau, dan saat ini nyeri yang sama timbul, maka ia akan lebih mudah mengatasi nyerinya. Mudah atau tidaknya seseorang dalam mengatasi nyerinya itu tergantung dengan pengalaman nyeri yang dirasakan.

d. Perhatian Apabila seseorang mendapatkan perhatian yang sangat lebih maka seseorang tersebut bisa merasa lebih nyaman dan rileks ketika mengalami nyeri (Curran, 1990).

5. Pengurangan Nyeri Persalinan

Manajemen nyeri persalinan bertujuan meningkatkan kenyamanan ibu melalui teknik nonfarmakologis dan kolaborasi farmakologis.

Teknik Nonfarmakologis diantaranya:

a. Teknik Relaksasi

Prinsip dari teknik ini yaitu untuk meningkatkan relaksasi klien, manfaatnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan aliran darah pada uterus dan oksigenasi janin
- 2) Mengurangi ketegangan pasien
- 2) Meningkatkan efesiensi kontraksi
- 3) Menghambat ketegangan yang dapat menghambat penurunan janin.

Berbagai teknik relaksasi yang dimaksud yaitu:

- 1) Hypnobirthing: membantu mengubah persepsi nyeri melalui pengaruh sugesti positif seperti memberikan keyakinan dan insting terhadap ibu bersalin bahwa ibu bisa bersalin dan bersalin itu nikmat.
- 2) Akupuntur

Suatu pengobatan alternative menggunakan jarum yang ditempatkan dititik – titik tertentu.

3) Akupresur

Memberikan stimulus untuk energi yang bisa mempengaruhi kesehatan dan nyeri persalinan dapat dikontrol.

4) Teknik pernafasan

Teknik ini diusahakan pasien dalam keadaan serileks mungkin, menarik nafas dari hidung tahan sekitar 5 – 10 detik dan hembuskan nafas lewat mulut secara perlahan. Teknik relaksasi ini akan berhasil jika lingkungan mendukung, mendapat dukungan dari keluarga, pendampingan saat bersalin. Teknik pernafasan dalam persalinan normal bertujuan mengelola nyeri, menjaga suplai oksigen ke janin, dan menjaga ibu tetap tenang. Metode utamanya meliputi napas lambat (inhalasi hidung, ekshalasi mulut perlahan) saat kontraksi awal, serta napas dada/perut yang teratur. Penting untuk merelaksasi bahu dan fokus padaperut.

Berikut adalah panduan teknik pernafasan berdasarkan tahap persalinan:

- a) Awal Kontraksi (Pembukaan Kecil): Gunakan teknik slow breathing. Tarik napas dalam dan lambat melalui hidung, hembuskan perlahan melalui mulut (seperti meniup). Ini membantu merilekskan tubuh.
- b) Kontraksi Intens (Pembukaan Besar): Terapkan teknik pant-pant blow— dua hembusan napas pendek diikuti satu hembusan panjang, juga bisa menggunakan pursed lip breathing (menghirup lewat hidung dan mengembuskan napas melalui bibir yang mengerucut).
- c) Saat Mengejan (Pembukaan Lengkap): Ambil napas dalam-dalam saat kontraksi datang, lalu tahan sebentar sambil mengejan kuat ke arah pantat, kemudian hembuskan napas.
- d) Di Antara Kontraksi: Lakukan napas santai dan normal untuk memulihkan energi

b. Stimulasi Cutaneus

Menstimulasi mekanoreseptor yakni neuron beta-A suatu neuron yang lebih tebal, dan lebih cepat melepaskan neurotransmitter penghambat impuls nyeri. Beberapa teknik stimulasi cutaneous yaitu:

1) Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)

Merupakan metode manajemen nyeri non farmakologis untuk persalinan, dengan menggunakan perangkat portabel untuk mengirimkan denyut listrik ringan melalui elektroda kulit, yang sering diaplikasikan pada punggung bawah. Studi menunjukkan bahwa metode ini dapat mengurangi intensitas nyeri dan meningkatkan rasa kendali terutama pada kala I persalinan.

Tujuan menggunakan TENS sebagai teknik elektroanalgesia untuk membantu klien mengatasi nyeri persalinan dan meningkatkan kenyamanan. TENS dianggap aman untuk ibu dan bayi, serta tidak menyebabkan efek samping seperti kantuk. TENS beroperasi dengan mengalirkan arus listrik rendah melalui kulit menggunakan elektroda yang diletakkan pada punggung ibu. Elektroda TENS tidak boleh ditempatkan di perut ibu hamil

2) Massage (effleurage)

Merupakan teknik pemijatan berupa usapan lembut, lembut dan panjang atau tidak putus – putus selama 3 sampai 10 menit dan dapat digunakan di seluruh bagian tubuh.

3) Massage (counterpressure)

Adalah pijatan tekanan kuat dengan cara meletakkan tumit tangan atau bagian datar dari tangan gerakannya memutar di daerah sakrum ibu.

4) Stimulasi termal (kompres panas /dingin)

Stimulasi Cutaneus Menstimulasi mekanoreseptor yakni neuron beta-A suatu neuron yang lebih tebal, dan lebih cepat melepaskan neurotransmitter penghambat impuls nyeri.

Beberapa teknik stimulasi cutaneous yaitu:

a) Massage (effleurage) Merupakan teknik pemijatan berupa usapan lembut, lembut dan panjang atau tidak putus – putus selama 3 sampai 10 menit dan dapat digunakan di seluruh bagian tubuh.

b) Massage (counterpressure) Adalah pijatan tekanan kuat dengan cara meletakkan tumit tangan atau bagian datar dari tangan gerakannya memutar di daerah sakrum ibu.

c. Stimulasi Mental

Komponen ini terdiri dari

1. *Imagery*

Adalah metode relaksasi untuk mengkhayalkan tempat dan kejadian berhubungan dengan rasa relaksasi yang menyenangkan.

2. *Distraksi*

3. *Meditasi*

4. *Aromaterapi*

Kegiatan diatas bertujuan untuk melepaskan hormone endorphin supaya tubuh menjadi rileks dan perlu dukungan lingkungan yang aman dan nyaman (Choi et al., 2003).

B. Teknik Farmakologis

1. Epidural anestesi

Epidural adalah salah satu bentuk anestesi atau bius lokal yang digunakan untuk membuat bagian tubuh tertentu mati rasa sehingga pasien tidak merasakan sakit. Pada proses persalinan, bius epidural akan menyebabkan mati rasa dari area pusar sampai kaki. Karena hanya membuat mati rasa sebagian anggota tubuh, maka tidak akan kehilangan kesadaran selama proses persalinan. Obat bius epidural akan bekerja dengan cara menghentikan kinerja saraf sensoris pada tulang belakang bagian bawah. Normalnya, saraf sensoris bertugas untuk mengirimkan berbagai sinyal pada otak, termasuk rasa sakit. Rasa sakit yang seharusnya dirasakan pada rahim, leher rahim, dan bagian atas vagina akan jauh berkurang. Meski begitu, saraf sensoris tetap bisa mengirimkan perintah bagi panggul dan bagian tubuh lainnya untuk bekerja sesuai kebutuhan. (Bucklin et al., 2002)

Dengan epidural reguler, ibu bersalin akan mendapatkan bius melalui kateter yang ditusukkan ke bagian punggung bawah, tepatnya ruang kecil pada bagian luar sumsum tulang belakang.

Kateter akan tetap berada di tempat tersebut selama proses persalinan sehingga dokter bisa memberikan lebih banyak obat jika dibutuhkan.

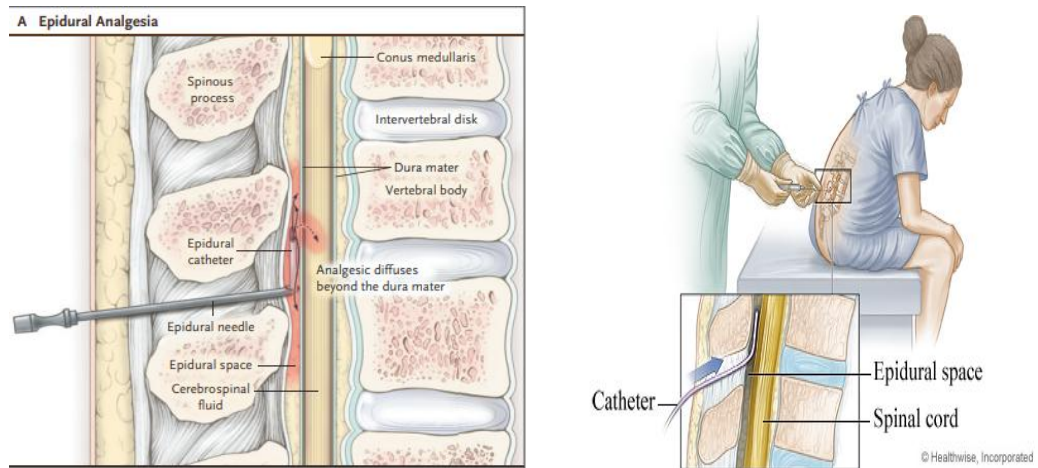
Suntikan tambahan biasanya dibutuhkan jika efek anestesi mulai berkurang setelah 1–2 jam dan proses persalinan belum selesai. Umumnya, dibutuhkan waktu sekitar 1–15 menit agar obat anestesi mulai bekerja. Pemberian epidural biasanya disarankan bagi ibu hamil dengan toleransi sakit yang rendah supaya ibu bisa melahirkan dengan lebih nyaman. Selain itu, obat bius ini tidak disarankan bagi ibu hamil yang mengalami perdarahan, tekanan darah rendah, infeksi pada punggung, dan mengonsumsi obat pengencer darah.

Pada proses persalinan normal, anestesi ini biasanya diberikan setelah pembukaan lahiran mencapai 4 atau 5 sentimeter.

Penggunaan epidural biasanya tidak dianjurkan jika tanda-tanda akan melahirkan sudah terlihat jelas, misalnya bukaan yang mencapai lebih dari 5 cm. (Choi et al., 2003)

Manfaat anestesi epidural :

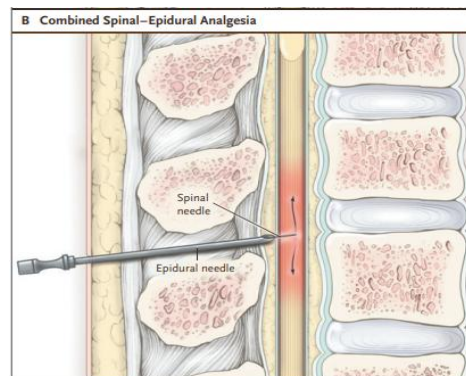
- a. Mengurangi nyeri selama persalinan
- b. Kontraksi terasa lebih ringan karena otot panggul yang lemas.
- c. Mengurangi rasa lelah, terutama pada proses persalinan yang cukup panjang.
- d. Bagi ibu bersalin dengan tekanan darah tinggi, anestesi ini bisa membantu menurunkan tekanan darah sehingga risiko komplikasi persalinan ikut berkurang.
- e. Membantu mengurangi rasa sakit pasca-operasi.



Gambar 3. Epidural
(Sumber: (Choi et al., 2003))

2. Kombinasi spinal epidural anestesi

Kombinasi spinal epidural adalah anestesi gabungan dari bius epidural dan bius tulang belakang (spinal). Anestesi kombinasi ini biasanya disuntikkan pada membran yang melapisi tulang belakang hingga mencapai rongga epidural. Kateter juga akan dibiarkan untuk menambahkan injeksi bila dibutuhkan. CSE bisa bekerja lebih cepat dan membuat pasien lebih leluasa bergerak. Efek kombinasi spinal epidural biasanya mulai berkurang setelah 4–8 jam.



Gambar 4. Kombinasi spinal epidural anestesi
(Sumber :Curran, 1990)

3. Blok saraf pudendal

Blok saraf pudendal adalah teknik penyuntikan anestesi lokal di dekat saraf pudendal di area panggul untuk meredakan nyeri sementara (neuralgia, nyeri persalinan, atau pascaoperasi). Prosedur ini menargetkan saraf yang mensuplai sensasi ke area genital (vagina, penis, anus, perineum) dan sering dipandu oleh USG atau CT scan.

Tujuan dan Manfaat:

- a. Manajemen Nyeri Kronis: Mengobati neuralgia pudendal (nyeri tajam, terbakar, atau mati rasa di area panggul).
- b. Obstetri: anestesi perineum selama persalinan.
- c. Pascaoperasi: Mengurangi nyeri setelah operasi wasir, urologi, atau ginekologi.
- d. Diagnostik: Memastikan apakah nyeri panggul memang bersumber dari saraf pudendal

Prosedur dan Teknik:

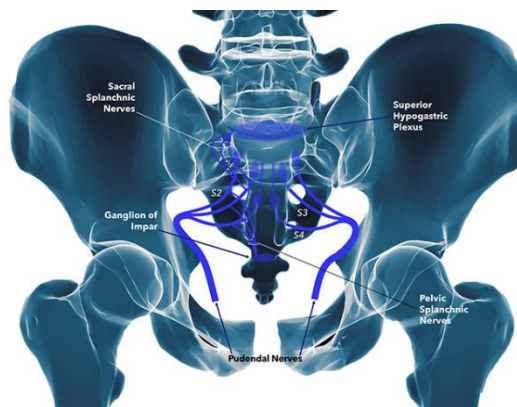
- a. Obat: Umumnya menggunakan lidokain 1% atau bupivakain 0,25%, kadang dikombinasikan dengan steroid untuk efek jangka panjang.
- b. Panduan: Meskipun bisa dilakukan secara "buta" (meraba spina iskiadika), penggunaan USG sangat direkomendasikan untuk akurasi dan keamanan, terutama pada pria.
- c. Posisi: Pasien biasanya dalam posisi litotomi dorsal (terlentang dengan kaki diangkat).

Keamanan dan Efek Samping:

- a. Prosedur ini dianggap berisiko sangat rendah.
- b. Efek samping jarang terjadi, namun bisa meliputi memar, infeksi, atau perdarahan.
- c. Mati rasa sementara di area genital adalah respon yang diharapkan.

Kontraindikasi:

- a. Infeksi aktif pada lokasi suntikan.
- b. Gangguan pembekuan darah.
- c. Alergi terhadap bahan anestesi lokal



Gambar 5. Pudendal Nerves
(Sumber : (Anim-Somuah et al., 2018))

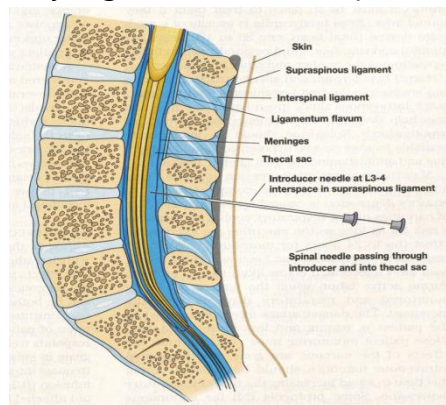
4. Intratekal opioid analgesia

Berbagai jenis obat dan mekanisme kerja obat dapat digunakan dalam persalinan intratekal analgesia. Pada umumnya dipakai obat-obatan, dan yang

paling populer adalah kombinasi antara anestesi lokal dan opioid. Analgesia persalinan di Indonesia yang ideal haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Analgesia adekuat
- b. Aman untuk ibu dan bayi
- c. Mudah diberikan
- d. Tidak terlalu banyak memakan biaya
- e. Tidak memengaruhi kontraksi rahim, bahkan harus sebaliknya yaitu dapat memperbaikinya
- f. Pemantauan dokter spesialis anestesi tidak harus sampai bayi lahir
- g. Efek samping yang timbul tidak potensial membahayakan ibu dan bayi.

Anestesi intratekal yang diberikan sesaat sebelum kelahiran terjadi, dikenal juga dengan blok Saddle, menyediakan anestesi yang cukup baik untuk persalinan spontan pervaginam. 500 mL – 1000 mL cairan diberikan secara bolus intravena sebelum dilakukannya tindakan, yang dilakukan dengan pasien pada posisi duduk. Menggunakan jarum spinal yang kecil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya PDPH (Post Dural Puncture Headache). Tetrakain hiperbarik (3-4 mg), bupivacaine (6-7 mg), atau lidocain (20-40 mg) biasanya menyediakan anestesi perineal yang sempurna. Blok sensorik hingga level T10 dapat dicapai dengan dosis anestesi yang sedikit lebih besar. Suntikan intratekal harus diberikan secara perlahan lebih dari 30 detik dan diantara kontraksi untuk meminimalkan penyebaran yang hebat kearah kepala. (Haso et al., 2021)



Gambar 6. Intratekal opioid analgesia
(Sumber: (Qu & Zhou, 2007))

C. Kolaborasi

Kolaborasi dalam manajemen nyeri persalinan melibatkan tim kesehatan (bidan, dokter, perawat) dan pendamping persalinan (suami/keluarga) untuk

memberikan asuhan yang berpusat pada ibu, menggabungkan metode non-farmakologis dan farmakologis guna menciptakan pengalaman melahirkan yang aman dan nyaman.

Kolaborasi manajemen nyeri persalinan:

1. Tim Kolaboratif

Bidan/Perawat: Garda terdepan dalam memantau kontraksi, memfasilitasi teknik relaksasi, dan memberikan dukungan emosional. Dokter Obgyn memutuskan intervensi medis jika diperlukan, termasuk manajemen nyeri farmakologis. Pendamping (Suami/Keluarga) dapat memberikan dukungan fisik seperti masase dan dukungan emosional

2. Metode Farmakologis

Digunakan saat nyeri tidak teratasi dengan metode non-farmakologis, meliputi analgesik yaitu pemberian obat penghilang nyeri atau Anestesi epidural untuk memblokir rasa nyeri, di bawah pengawasan dokter spesialis anestesi.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Seorang perempuan usia 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke Puskesmas dengan keluhan mulas sejak 6 jam yang lalu. Ibu tampak cemas dan mengatakan tidak tahan dengan rasa nyeri yang dirasakan.

Hasil pemeriksaan:

1. TD: 120/80 mmHg
2. Nadi: 96 x/menit
3. Suhu: 36,7°C
4. DJJ: 148 x/menit
5. His: 3 kali/10 menit durasi 40 detik
6. Pembukaan serviks: 4 cm

Selama observasi, ibu tampak gelisah, sering mengeluh nyeri hebat, dan sulit mengikuti instruksi bidan saat kontraksi.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi nyeri pada ibu tersebut?
3. Jenis nyeri apa yang dialami ibu berdasarkan fase persalinan?
4. Intervensi nonfarmakologis apa yang dapat dilakukan pada kasus ini?
5. Kapan diperlukan kolaborasi farmakologis pada kasus nyeri persalinan?
6. Bagaimana peran bidan dalam membantu ibu mengatasi nyeri dan kecemasan?
7. Edukasi apa yang perlu diberikan kepada ibu dan keluarga terkait nyeri persalinan?

D. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Manajemen nyeri persalinan kala I
3	Kasus	Nyeri persalinan kala I dengan interview nonfarmakologi dan edukasi
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta mampu melakukan asuhan kebidanan dalam manajemen nyeri persalinan secara tepat, aman, dan berpusat pada ibu
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik 3. Analisis masalah 4. Tindakan nonfarmakologis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke Puskesmas dengan keluhan mulas sejak 6 jam yang lalu. Ibu tampak cemas dan mengatakan nyeri sangat hebat. Hasil pemeriksaan: • TD: 120/80 mmHg • N: 96 x/menit • S: 36,7°C • DJJ: 148 x/menit • His: 3x/10 menit/40 detik • Pembukaan: 4 cm Ibu tampak gelisah dan sulit mengontrol napas saat kontraksi. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah 2. Lakukan pemeriksaan fisik 3. Tentukan masalah kebidanan 4. Lakukan manajemen nyeri nonfarmakologis 5. Berikan KIE singkat kepada ibu

No.	Komponen	Isi
		6. Jelaskan indikasi kolaborasi bila perlu
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan teknik relaksasi -> ibu tampak lebih tenang 2. Jika peserta melakukan teknik napas -> ibu mulai mengikuti 3. jika peserta melakukan massage -> ibu mengatakan nyeri berkurang TINDAKAN YANG DIHARAPKAN 1. Penilaian nyeri 2. Teknik persnapasan 3. Relaksasi 4. massage (effleurage/counterpressure) 5. Dukungan emosional 6. Edukasi
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. Tampak cemas, meringis saat kontraksi 2. Mengeluh : " sakit banget buuu" 3. Kooperatif jika dibimbing
9	Dialog PS	Peserta: Peserta: Apa keluhan ibu? PS: Perut saya sakit sekali, Bu Peserta: Sejak kapan? PS: Dari tadi pagi Peserta: Apakah ibu cemas? PS: Iya, saya takut Peserta: Saya akan bantu mengurangi nyeri ya PS: Iya Bu, tolong Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS

No.	Komponen	Isi
		memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan dalam - Lembar partograf kasus
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Lembar partograf kasus — 1 set 5. Tensimeter — 1 6. Stetoskop — 1 7. Doppler/Pinard — 1 8. Jam tangan/stopwatch — 1 9. Termometer — 1 10. Sarung tangan bersih — 1 pasang 11. Handrub — 1 botol 12. Kain penutup/selimut — 1 13. Tisu — 1 pack 14. Infus set dummy — 1 set 15. Cairan RL/NaCl dummy — 1 16. Abocath dummy — 1 17. Formulir rujukan — 1 lembar 18. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 19. Pena — 1
13	Penulis	
14	Referensi	1. Anim-Somuah, M., Smyth, R. M. D., Cyna, A. M., & Cuthbert, A. (2018). Epidural versus non-epidural or no analgesia for pain management in labour. <i>Cochrane Database of Systematic Reviews</i> , 2018(5). https://doi.org/10.1002/14651858.CD000331.pub4 Anis Nikmatul Nikmah, Dhita Kris Prasetyanti, Eko Winarti,

No.	Komponen	Isi
		Karima Meireza, & Hiromi Ogasawara. (2022). Effect Endorphin Massage on Anxiety Labor Levels of First Stage. <i>Journal Of Nursing Practice</i>, 5(2), 261–265. https://doi.org/10.30994/jnp.v5i2.219 Bonarska, M., Adasik, D., Szymczyk, S., Łocik, G., & Stanirowski, P. (2025). A Systematic Review of Contemporary and Emerging Analgesia Techniques for Natural Labor–Patient-Centered Approaches and Technological Advances. <i>Journal of Clinical Medicine</i>, 14(11), 1–18. https://doi.org/10.3390/jcm14113977

E. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan

Stase 1: Persalinan Gawatdarurat

KOMPETENSI 1. Pengkajian

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat nyeri (lokasi, intensitas, durasi, frekuensi)		
3. Riwayat persalinan sekarang (awal kontraksi, pola his)		
4. faktor psikologis (cemas, takut, pengalaman sebelumnya)		
5. persepsi ibu terhadap nyeri		
6. dukungan keluarga/pendamping		
7. Riwayat kesehatan/obstetri		
8. Kebutuhan dasar (makan, minum, istirahat)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = melakukan semua 8 langkah dengan benar
- **2** = melakukan 5-7 langkah
- **1** = melakukan 1-4 langkah
- **0** = tidak melakukan

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dan memperkenalkan diri		
b. Menjelaskan tujuan tindakan		
c. Informed consent		
d. Menjaga privasi		
e. Hand hygiene		
f. Menyiapkan alat		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Menilai his		
d. Menilai tingkat nyeri (skala nyeri)		
e. mengidentifikasi faktor penyebab nyeri		

f. Memberikan teknik nonfarmakologis (napas, relaksasi, massage, ddl)		
g. Mmemberikan dukungan emosional		
h. Mengevaluasi respon ibu		
i. menentukan kebutuhan kolaborasi farmakologis		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan		
b. Dokumentasi		
c. Merapikan alat dan cuci tangan		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = 15-19 langkah benar dan sistematis
- **2** = 10-14 langkah benar
- **1** = 1-9 langkah
- **0** = tidak melakukan

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan nyeri persalinan secara sederhana		
3. Edukasi teknik mengurangi nyeri		
4. Memberikan dukungan emosional		
5. Melibatkan keluarga		
6. memberi kesempatan bertanya		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = semua dilakukan
- **2** = 4-5 dilakukan
- **1** = 1-3 dilakukan
- **0** = tidak dilakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sistematis		
2. Menjaga privasi		
3. Empati terhadap nyeri ibu		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
4. komunikasi jelas		
5. Percaya diri		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3 = semua benar
- 2 = 4 benar
- 1 = 1-3 benar
- 0 = tidak dilakukan

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3
(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada manajemen nyeri persalinan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta dan memberikan umpan balik setelah tindakan selesai. Domain yang dinilai meliputi komunikasi, keterampilan teknis, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan pengkajian nyeri persalinan, memberikan teknik nonfarmakologis seperti relaksasi dan massage, serta mengevaluasi respon ibu terhadap tindakan yang diberikan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan tindakan klinis secara langsung, aman, dan sistematis serta berpusat pada pasien.	Mahasiswa dinilai tidak hanya memahami teori nyeri persalinan, tetapi mampu mengkaji tingkat nyeri, memilih teknik yang tepat, serta memberikan dukungan emosional untuk meningkatkan kenyamanan ibu.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi nyata yang sesuai dengan kompetensi mahasiswa dalam praktik kebidanan.	Seorang ibu bersalin kala I fase aktif mengeluh nyeri hebat, tampak gelisah dan cemas. Pembukaan 5 cm, his adekuat, tanda vital dalam batas normal.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan prosedur klinik secara langsung, bukan hanya diskusi kasus.	Mahasiswa melakukan pengkajian nyeri (lokasi, intensitas, durasi), menilai kondisi ibu, memberikan teknik pernapasan dan relaksasi, melakukan massage

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		(effleurage atau counterpressure), serta memberikan dukungan emosional.
Aspek yang dinilai	Aspek meliputi pengkajian, keterampilan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi nyeri dengan tepat, memilih teknik yang sesuai, serta melakukan tindakan dengan aman dan efektif.
Fokus observasi pembimbing	Fokus pada performa nyata mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu mengurangi nyeri ibu, memberikan kenyamanan, serta berkomunikasi dengan empati dan jelas kepada ibu.
Umpan balik	Diberikan segera setelah observasi untuk memperbaiki kinerja mahasiswa.	Pembimbing memberikan masukan, misalnya mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, tetapi perlu meningkatkan teknik massage atau evaluasi respon ibu.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS dikategorikan menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan manajemen nyeri secara sistematis dan efektif.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik capaian pembelajaran berbasis praktik langsung	Mahasiswa menunjukkan kemampuan nyata dalam mengelola nyeri persalinan, tidak hanya secara teori tetapi juga praktik klinik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada manajemen nyeri persalinan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Pada topik manajemen nyeri persalinan, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu mengkaji nyeri, memahami penyebab nyeri, memberikan intervensi yang tepat, serta mengevaluasi respon ibu terhadap tindakan yang diberikan.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa menunjukkan bagaimana kemampuannya dalam mengelola nyeri persalinan berkembang setelah mendapatkan pengalaman praktik dan umpan balik dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan mahasiswa baik di laboratorium maupun praktik klinik.	OSCE berisi simulasi manajemen nyeri seperti teknik relaksasi dan pernapasan, sedangkan DOPS berisi observasi langsung saat mahasiswa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		memberikan intervensi nyeri pada ibu bersalin di lahan praktik.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus berisi ringkasan kasus pasien yang ditangani mahasiswa, meliputi data subjektif, objektif, analisis, tindakan, dan evaluasi.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu bersalin kala I dengan nyeri hebat, mencatat intensitas nyeri, kondisi ibu, intervensi yang diberikan (misalnya massage atau teknik napas), serta perubahan yang terjadi setelah tindakan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien dan menyusun langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa nyeri yang tidak ditangani dapat meningkatkan kecemasan ibu dan memperlambat persalinan, sehingga diperlukan intervensi yang tepat dan dukungan emosional yang baik.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing klinik atau dosen menunjukkan area kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi terapeutik, namun perlu meningkatkan keterampilan teknik massage dan evaluasi nyeri secara lebih sistematis.
Karakteristik penilaian	Portofolio bersifat berkelanjutan dan menilai konsistensi performa mahasiswa dalam praktik.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman dalam menangani nyeri persalinan, bukan hanya satu kasus, sehingga terlihat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		konsistensi kemampuan dalam praktik
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan kompetensi dalam berbagai situasi klinik.	Dari hasil OSCE, DOPS, dan catatan kasus, mahasiswa menunjukkan kemampuan konsisten dalam mengkaji nyeri, memberikan intervensi, dan mengevaluasi hasil.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tercapai melalui praktik nyata.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori nyeri persalinan, tetapi mampu menerapkannya secara langsung dan konsisten dalam asuhan kebidanan.

Tabel. Case Report pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menganalisis kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan tentang seorang ibu bersalin kala I yang mengalami nyeri hebat selama proses persalinan dan memerlukan intervensi manajemen nyeri.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, analisis masalah, perencanaan, tindakan, dan evaluasi asuhan kebidanan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan kondisi ibu, tetapi juga menjelaskan penyebab nyeri, intervensi yang diberikan, serta hasil dari tindakan tersebut.
Isi laporan	Isi case report meliputi identitas pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis, tindakan, implementasi, dan evaluasi.	Mahasiswa menuliskan ibu G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu dengan keluhan nyeri hebat, his teratur, pembukaan 4 cm, ibu tampak cemas, dilakukan teknik relaksasi dan massage, kemudian dievaluasi penurunan intensitas nyeri.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, analisis masalah, logika klinis, ketepatan tindakan, dan evaluasi hasil.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan nyeri dengan proses fisiologis persalinan serta memilih intervensi yang tepat untuk mengurangi nyeri.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan	Dari kasus nyeri persalinan, mahasiswa belajar pentingnya

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	berpikir kritis (clinical reasoning), dokumentasi, dan refleksi praktik klinik.	manajemen nyeri untuk meningkatkan kenyamanan ibu dan memperlancar proses persalinan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam praktik nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya memahami konsep nyeri persalinan, tetapi mampu mengelola dan mendokumentasikan asuhan secara lengkap.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Kegawatdaruratan Persalinan: Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis penyebab, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus nyeri persalinan, mahasiswa merefleksikan bahwa nyeri yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis ibu serta jalannya persalinan.
Tujuan	Refleksi bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa penanganan nyeri yang tepat dapat meningkatkan kenyamanan ibu dan mencegah komplikasi selama persalinan.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan pengalaman dalam menangani ibu bersalin dengan nyeri hebat, serta mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi pada pasien.	Risiko yang diidentifikasi meliputi peningkatan kecemasan, kelelahan ibu, peningkatan tekanan darah, serta kemungkinan persalinan menjadi lebih lama akibat nyeri yang tidak terkontrol.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah-langkah untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pengkajian nyeri secara berkala, pemberian teknik relaksasi, massage, dukungan emosional, serta kolaborasi bila diperlukan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal tersebut akan diterapkan ke depan.	Mahasiswa menyadari bahwa komunikasi terapeutik dan manajemen nyeri yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan ibu bersalin.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia mampu mengevaluasi tindakan yang dilakukan dan meningkatkan kualitas asuhan kebidanan secara berkelanjutan.

F. Ringkasan

Nyeri persalinan merupakan respon fisiologis akibat kontraksi uterus, dilatasi serviks, dan penurunan janin. Nyeri pada kala I bersifat viseral, sedangkan kala II bersifat somatik. Persepsi nyeri dipengaruhi oleh faktor fisik, psikologis, dan lingkungan.

Manajemen nyeri bertujuan meningkatkan kenyamanan ibu dan mendukung persalinan normal. Teknik nonfarmakologis seperti relaksasi, pernapasan, massage, dan distraksi efektif dalam mengurangi nyeri. Teknik farmakologis seperti epidural digunakan sesuai indikasi.

Bidan berperan penting dalam memberikan asuhan holistik, termasuk dukungan emosional dan edukasi kepada ibu.

Alur asuhan singkat Ibu inpartu dengan kemajuan persalinan tidak memuaskan nilai cepat ibu dan janin telaah partograf dan kemajuan serial identifikasi kemungkinan partus lama/distosia lakukan stabilisasi awal dan dukungan tentukan kebutuhan kolaborasi/rujukan dokumentasi dan handover yang jelas.

G. Tabel Red Flags & Eskalasi

Manajemen Nyeri Persalinan: Teknik Nonfarmakologis dan Kolaborasi Farmakologis

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Nyeri sangat hebat tidak sesuai fase persalinan	Dapat mengindikasikan komplikasi (misalnya distosia, solusio plasenta, atau masalah lain)	Lakukan pengkajian ulang lengkap, nilai ibu dan janin, segera kolaborasi/rujuk
Nyeri tidak berkurang setelah intervensi nonfarmakologis	Manajemen nyeri tidak efektif atau ada faktor lain	Evaluasi ulang teknik, pertimbangkan kolaborasi farmakologis
Ibu tampak sangat cemas, panik, atau tidak kooperatif	Faktor psikologis memperberat nyeri dan dapat menghambat persalinan	Berikan dukungan emosional intensif, libatkan keluarga, komunikasi terapeutik
Tanda vital tidak normal (TD ↑, nadi ↑, RR ↑)	Respon fisiologis terhadap nyeri atau tanda komplikasi	Monitoring ketat, stabilisasi, evaluasi penyebab, kolaborasi bila perlu
DJJ tidak normal (<120 atau >160 x/menit)	Kemungkinan gawat janin	Segera lakukan penilaian lanjutan dan rujukan
His terlalu kuat atau tidak adekuat	Gangguan power yang mempengaruhi nyeri dan kemajuan persalinan	Evaluasi pola his, lakukan tindakan sesuai indikasi, kolaborasi
Ibu kelelahan berat	Nyeri berkepanjangan dapat menyebabkan kelelahan dan risiko komplikasi	Berikan istirahat, dukungan, pertimbangkan intervensi tambahan
Ibu tidak mampu mengikuti teknik relaksasi/pernapasan	Nyeri tidak terkendali atau kurang edukasi	Ulangi edukasi, berikan bimbingan lebih intensif

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Tidak ada kemajuan persalinan disertai nyeri hebat	Kemungkinan distosia atau partus lama	Evaluasi menyeluruh, siapkan rujukan

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: manajemen nyeri persalinan

Nama _____ Mahasiswa _____ :

NIM _____ :

Tanggal _____ :

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Menanyakan keluhan utama (nyeri persalinan)	☐	☐	_____
2	Mengkaji lokasi, intensitas, durasi nyeri	☐	☐	_____
3	Mengkaji Riwayat persalinan sekarang	☐	☐	_____
4	Menilai faktor psikologis (cemas/takut)	☐	☐	_____
5	Menilai dukungan keluarga	☐	☐	_____
6	Menilai tanda vital ibu	☐	☐	_____
7	Menilai his	☐	☐	_____
8	Menilai DJJ	☐	☐	_____
9	Menyapa dan memperkenalkan diri	☐	☐	_____
10	Menjelaskan tujuan tindakan	☐	☐	_____
11	Informed consent	☐	☐	_____
12	Menjaga privasi	☐	☐	_____
13	Hand hygiene	☐	☐	_____
14	Menilai tingkat nyeri (skala nyeri)	☐	☐	_____
15	Memberikan teknik relaksasi	☐	☐	_____
16	Melakukan massage (effleurage/counterpressure)	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Daftar Pustaka

- Anim-Somuah, M., Smyth, R. M. D., Cyna, A. M., & Cuthbert, A. (2018). Epidural versus non-epidural or no analgesia for pain management in labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018(5). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000331.pub4>
- Anis Nikmatul Nikmah, Dhita Kris Prasetyanti, Eko Winarti, Karima Meireza, & Hiromi Ogasawara. (2022). Effect Endorphin Massage on Anxiety Labor Levels of First Stage. *Journal Of Nursing Practice*, 5(2), 261–265. <https://doi.org/10.30994/jnp.v5i2.219>
- Bonarska, M., Adasik, D., Szymczyk, S., Łocik, G., & Stanirowski, P. (2025). A Systematic Review of Contemporary and Emerging Analgesia Techniques for Natural Labor–Patient-Centered Approaches and Technological Advances. *Journal of Clinical Medicine*, 14(11), 1–18. <https://doi.org/10.3390/jcm14113977>
- Bucklin, B. A., Chestnut, D. H., & Hawkins, J. L. (2002). Intrathecal opioids versus epidural local anesthetics for labor analgesia: A meta-analysis. *Regional Anesthesia and Pain Medicine*, 27(1), 23–30. <https://doi.org/10.1053/rapm.2002.29111>
- Choi, P., Bhandari, M., Scott, J., Douketis, J. D., & Cracknell, J. (2003). Epidural analgesia for pain relief following hip or knee replacement. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2003(3). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003071>
- Curran, M. J. A. (1990). Epidural analgesia for labor and delivery. *Anesthesiology Clinics of North America*, 8(1), 55–75. <https://doi.org/10.1097/01.aoa.0000397101.49686.99>
- Dahlan, F. M., Yanti, R., Suralaga, C., & Aulia, Y. (2023). Arantika Meidya Pra. *Health and Technology Journal (HTechJ)*, 1(4), 420–426.
- Fitrianingsih, J., Fitriani, F., & Yulis, D. M. (2025). Effectiveness of Endorphin Massage for Pain Reduction During the Active Phase of First-Stage Labor: A Quasi-Experimental Pretest–Posttest Study. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 20(2), 387–396. <https://doi.org/10.32382/medkes.v20i2.1711>
- Haso, T., Horeto, A., Abdu, S., & Neme, A. (2021). Utilization of non-pharmacological labor pain management methods and associated factors among women gave birth at Jimma medical center, Jimma, Southwest Ethiopia. *Clin Mother Child Health S*, 18, 1000003.

- Purnamawati, D., Faculty, P. H., & Selatan, T. (2018). *Proceeding The 4*. 8–13.
- Qu, F., & Zhou, J. (2007). Electro-acupuncture in relieving labor pain. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 4(1), 125–130.
<https://doi.org/10.1093/ecam/nel053>
- Sari, dyah permata, Rufaida, Z., & Lestari, sri wirdani. (2020). *NYERI PERSALINAN*.

BAB 6

ASUHAN PERSALINAN KALA II: PIMPINAN PERSALINAN, PERLINDUNGAN PERINEUM, DAN PENCEGAHAN ASFIKSIA

CP Bab (Capaian Pembelajaran Bab)

Mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan persalinan kala II yang aman, mengidentifikasi *red flags*, serta melakukan komunikasi klinis yang tepat sesuai kewenangan bidan dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi.

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi efektif dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko pada asuhan intrapartum.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan clinical reasoning berbasis data untuk penapisan masalah dan pengambilan keputusan intrapartum.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV serta tindakan awal kegawatdaruratan intrapartum secara aman dan bermutu.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Mendokumentasikan asuhan dan rujukan secara akurat serta memanfaatkan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi mutu dan pengembangan diri.	CPMK-7; CPMK-4; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menerapkan keselamatan ibu-bayi melalui PPI, K3, pemantauan terstruktur, dan manajemen risiko intrapartum.
CPMK-4	Melakukan pengkajian komprehensif ibu bersalin dan kesejahteraan janin serta menafsirkan temuan untuk penetapan masalah/prioritas.
CPMK-5	Merencanakan dan melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV berbasis bukti termasuk dukungan, kenyamanan, manajemen nyeri, dan pencegahan komplikasi.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 7. Asuhan Persalinan Kala II: Pimpin Persalinan, Perlindungan Perineum, dan Pencegahan Asfiksia	7.1 Memimpin kala II dengan teknik aman sesuai kondisi ibu-janin (posisi, bimbingan, pemantauan).	7.2 Menerapkan perlindungan perineum dan pencegahan asfiksia melalui tindakan intrapartum yang tepat.	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-4

Uraian Materi

Persalinan merupakan proses fisiologis yang menandai akhir masa kehamilan dan awal kehidupan ekstrauterin bagi bayi. Salah satu fase yang paling menentukan dalam proses tersebut adalah kala II persalinan, yaitu periode sejak pembukaan serviks lengkap hingga lahirnya bayi. Pada fase ini terjadi perubahan fisiologis yang signifikan, baik pada ibu maupun janin, sehingga membutuhkan keterampilan klinis, ketelitian, serta kewaspadaan tinggi dari tenaga kesehatan, khususnya bidan. Asuhan persalinan kala II tidak hanya berfokus pada keberhasilan kelahiran bayi, tetapi juga pada keselamatan ibu dan bayi, pencegahan komplikasi, serta penghormatan terhadap proses fisiologis persalinan. Pimpinan persalinan yang tepat membantu memastikan bahwa proses kelahiran berlangsung secara terkendali, meminimalkan trauma lahir, serta mencegah komplikasi seperti perdarahan, ruptur perineum berat, dan gangguan kesejahteraan janin.

Perlindungan perineum merupakan bagian penting dalam asuhan kala II karena bertujuan mengurangi risiko ruptur perineum derajat tinggi yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup ibu. Teknik yang benar, pengendalian lahirnya kepala, serta komunikasi yang efektif kepada ibu saat meneran menjadi komponen utama dalam upaya pencegahan trauma perineal. Di sisi lain, kala II persalinan juga merupakan periode kritis bagi bayi. Transisi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin menuntut adaptasi sistem pernapasan dan sirkulasi secara cepat. Keterlambatan atau gangguan adaptasi tersebut dapat menyebabkan asfiksia neonatorum, yang masih menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas neonatal. Oleh karena itu, pencegahan asfiksia harus dimulai sejak sebelum bayi lahir melalui pemantauan kesejahteraan janin, persalinan yang terkendali, serta kesiapan melakukan tindakan segera setelah bayi lahir.

Sebagai tenaga profesional, bidan memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan persalinan kala II yang aman, efektif, dan sesuai kewenangan. Kompetensi dalam mendemonstrasikan pimpinan persalinan, melakukan perlindungan perineum, serta mencegah asfiksia neonatorum merupakan bagian integral dari praktik kebidanan berbasis keselamatan pasien (patient safety) dan standar kompetensi profesi. Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai konsep, prinsip, langkah-langkah asuhan, identifikasi tanda bahaya (red flags), serta pendekatan klinis dalam asuhan persalinan kala II. Pembahasan disusun untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa agar mampu menerapkan asuhan secara sistematis, aman, dan bertanggung jawab dalam praktik kebidanan.

A. Konsep Dasar Kala II Persalinan

1. Definisi Kala II

Kala II persalinan adalah fase yang dimulai sejak pembukaan serviks lengkap (10 cm) sampai lahirnya bayi. Pada fase ini terjadi dorongan meneran ibu yang disertai kontraksi uterus efektif dan penurunan kepala janin.

2. Tanda-Tanda Kala II

- Pembukaan lengkap
- Ibu merasakan dorongan kuat untuk meneran
- Perineum menonjol
- Vulva membuka
- Kepala janin tampak di introitus vagina
- Pengeluaran lendir bercampur darah

3. Durasi Normal

- Primigravida: $\pm$ 1–2 jam
- Multigravida: $\pm$ 30–60 menit

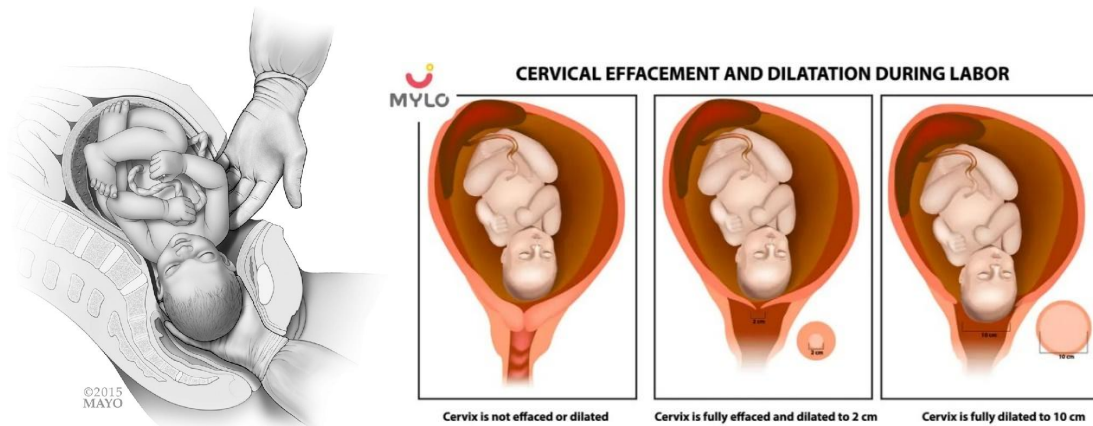
Perpanjangan kala II dapat meningkatkan risiko:

- Distosia
- Ruptur perineum berat
- Asfiksia neonatorum

B. Prinsip Pimpinan Persalinan Kala II

Pimpinan persalinan kala II merupakan upaya bidan dalam membimbing proses kelahiran bayi sejak pembukaan lengkap hingga bayi lahir secara aman, fisiologis, dan terkendali. Pada fase ini, bidan tidak sekadar “menolong kelahiran”, tetapi memastikan keselamatan ibu dan bayi melalui pengawasan klinis yang cermat serta intervensi yang tepat sesuai kewenangan.





Gambar 7.1 Pimpinan Persalinan Kala II

Sumber: Marshall & Raynor (2024)

Prinsip Utama:

1. Menjaga keselamatan ibu dan bayi
2. Menghormati proses fisiologis
3. Komunikasi empatik dan suportif
4. Pencegahan infeksi
5. Kesiapan resusitasi neonatus

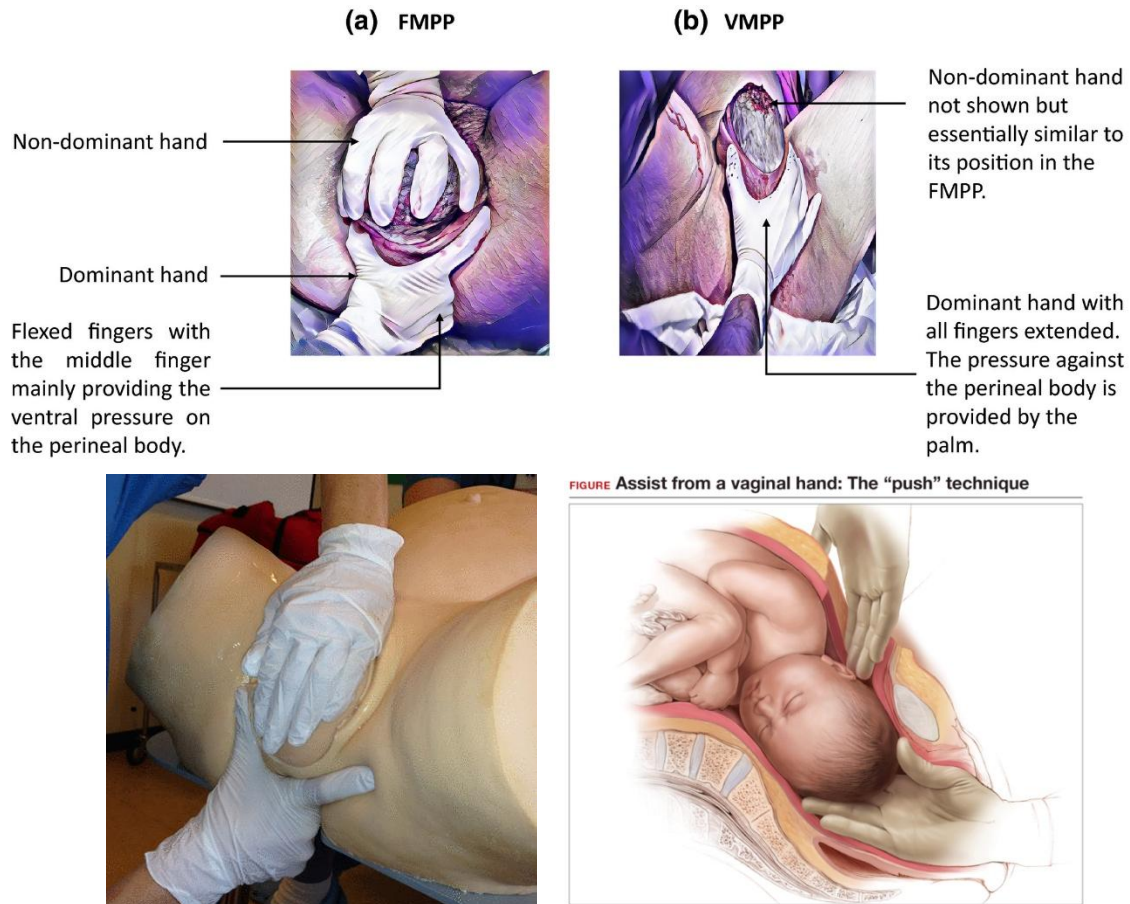
Langkah Pimpinan Persalinan:

1. Hand hygiene dan APD
2. Identifikasi ibu dan jaga privasi
3. Konfirmasi pembukaan lengkap
4. Posisikan ibu nyaman (setengah duduk/lateral)
5. Bimbing meneran efektif saat kontraksi
6. Observasi kemajuan penurunan kepala
7. Lakukan proteksi perineum saat crowning
8. Lahirkan kepala secara terkendali
9. Periksa lilitan tali pusat
10. Lahirkan bahu dan badan bayi secara hati-hati
11. Lakukan penilaian awal bayi

C. Perlindungan Perineum

Perlindungan perineum adalah tindakan yang dilakukan bidan pada saat kepala janin hampir lahir (fase *crowning*) untuk mencegah terjadinya ruptur perineum, khususnya ruptur derajat III dan IV yang dapat berdampak jangka panjang terhadap fungsi dasar panggul ibu. Pada kala II persalinan, jaringan perineum mengalami peregangan maksimal akibat penurunan dan lahirnya kepala janin. Jika proses kelahiran terjadi terlalu cepat atau tidak terkendali, risiko robekan

perineum akan meningkat. Oleh karena itu, bidan perlu melakukan pengendalian lahirnya kepala secara perlahan dan terkontrol.



Gambar 7.2 Perlindungan Perineum
Sumber: Genç Koyucu, R. et al. (2025)

Prinsip perlindungan perineum meliputi:

1. Mengontrol defleksi kepala janin agar lahir secara bertahap.
2. Memberikan instruksi kepada ibu untuk berhenti meneran sementara saat kepala hampir lahir.
3. Menopang perineum dengan teknik yang tepat (*hands-on technique*) bila diperlukan.
4. Menghindari tarikan berlebihan pada kepala dan bahu bayi.
5. Melakukan episiotomi hanya berdasarkan indikasi medis.

Faktor Risiko Ruptur:

1. Primigravida
2. Bayi besar (>4000 gram)
3. Persalinan cepat
4. Episiotomi tidak tepat indikasi

Perlindungan perineum merupakan bagian penting dari praktik kebidanan berbasis keselamatan pasien, karena tidak hanya mencegah trauma fisik, tetapi juga mengurangi risiko nyeri pascapersalinan, disfungsi dasar panggul, dan gangguan psikologis pada ibu.

D. Pencegahan Asfiksia Neonatorum

Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bayi memulai dan mempertahankan napas spontan setelah lahir. Pencegahan asfiksia neonatorum merupakan bagian penting dari asuhan persalinan kala II yang bertujuan memastikan bayi mampu melakukan adaptasi pernapasan secara optimal segera setelah lahir. Asfiksia neonatorum terjadi apabila bayi gagal memulai dan mempertahankan pernapasan spontan, yang dapat berdampak serius terhadap fungsi organ vital dan kelangsungan hidup bayi. Upaya pencegahan asfiksia dimulai sejak sebelum bayi lahir melalui pemantauan kesejahteraan janin, pengendalian proses persalinan agar tidak berlangsung terlalu lama, serta menghindari tindakan traumatik selama kelahiran. Pada saat persalinan, bidan perlu mengendalikan lahirnya kepala dan badan bayi secara perlahan untuk mencegah gangguan oksigenasi.

Segera setelah bayi lahir, pencegahan asfiksia dilanjutkan dengan tindakan awal berupa pengeringan, menjaga kehangatan, memposisikan jalan napas dengan benar, serta melakukan penilaian cepat terhadap pernapasan dan tonus otot bayi. Kesiapan alat dan kemampuan melakukan tindakan resusitasi awal sesuai kewenangan juga merupakan bagian dari pencegahan yang tidak terpisahkan. Dengan penerapan pencegahan asfiksia yang tepat dan sistematis, bidan berperan besar dalam menurunkan risiko morbiditas dan mortalitas neonatus serta menjamin keselamatan bayi baru lahir sebagai bagian dari praktik kebidanan profesional berbasis keselamatan pasien.

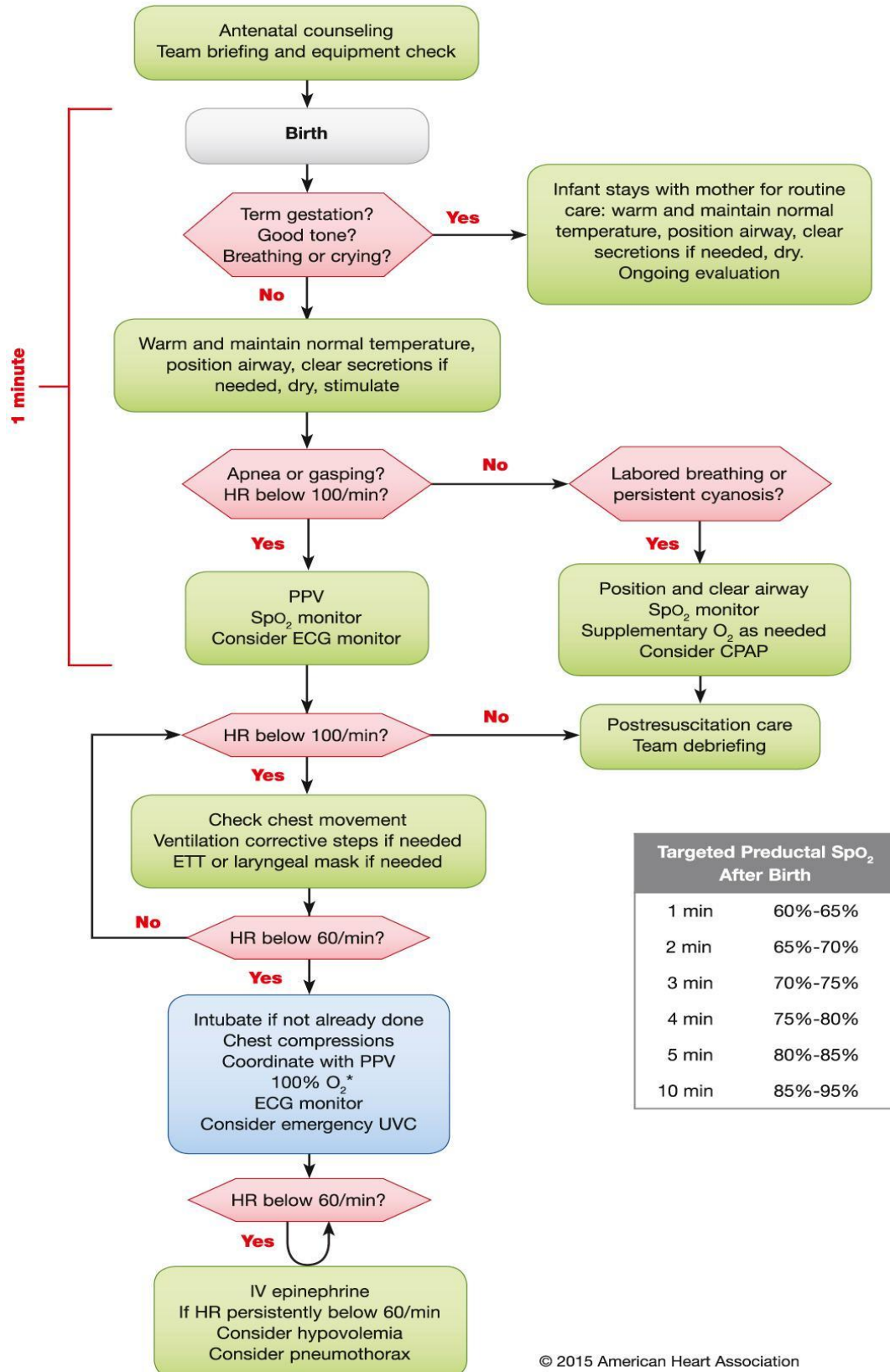
Pencegahan Dilakukan dengan:

1. Menghindari persalinan lama
2. Mengontrol kelahiran kepala
3. Menghindari trauma lahir
4. Segera mengeringkan bayi
5. Kontak kulit ke kulit
6. Penilaian APGAR menit ke-1 dan ke-5
7. Siapkan alat resusitasi sebelum persalinan



Gambar 7.3 Pencegahan Asfiksia NeonatorumSumber :
*American Academy of Pediatrics & American College
of Obstetricians and Gynecologists (2023)*

Neonatal Resuscitation Algorithm



Gambar 7.4 Algoritma Resusitasi Neonatus Sumber: *American Academy of Pediatrics & American College of Obstetricians and Gynecologists (2023)*

Alur Singkat:

Identifikasi Risiko Proses Persalinan Terkendali Pengeringan dan Kehangatan
Penilaian Napas dan Tonus Penilaian APGAR Tindakan atau Rujukan Dokumentasi

1. Persiapan Sebelum Bayi Lahir

Tujuan: mencegah terjadinya kekurangan oksigen sejak masa persalinan

- a. Mengidentifikasi faktor risiko ibu dan janin
(anemia, preeklamsia, ketuban hijau, denyut jantung janin abnormal)
- b. Memantau denyut jantung janin secara berkala
- c. Mencegah persalinan kala II berlangsung terlalu lama
- d. Melakukan pimpinan persalinan secara terkendali
- e. Menyiapkan alat resusitasi bayi baru lahir sebelum persalinan dimulai

2. Pengendalian Proses Kelahiran Bayi

Tujuan: mencegah gangguan pernapasan saat bayi lahir

- a. Mengendalikan lahirnya kepala bayi agar tidak terlalu cepat
- b. Memeriksa adanya lilitan tali pusat
- c. Menghindari tarikan berlebihan pada kepala dan badan bayi
- d. Melahirkan bahu dan badan bayi secara lembut dan terkontrol

3. Tindakan Segera Setelah Bayi Lahir

Tujuan: membantu bayi memulai pernapasan secara spontan

- a. Meletakkan bayi di atas perut atau dada ibu
- b. Segera mengeringkan seluruh tubuh bayi
- c. Menjaga kehangatan bayi
- d. Memposisikan kepala bayi sedikit ekstensi
- e. Membersihkan jalan napas bila diperlukan

4. Penilaian Awal Kondisi Bayi

Tujuan: mendeteksi dini tanda asfiksia neonatorum

- a. Menilai apakah bayi bernapas atau menangis
- b. Menilai tonus otot bayi
- c. Menilai warna kulit bayi
- d. Melakukan penilaian skor APGAR pada menit ke-1 dan ke-5

5. Tindakan Berdasarkan Hasil Penilaian

Jika bayi bernapas spontan dan tonus baik:

- a. Melanjutkan kontak kulit ke kulit
- b. Melakukan inisiasi menyusui dini
- c. Melakukan observasi rutin

Jika bayi tidak bernapas atau pernapasan tidak efektif:

- a. Melakukan rangsangan taktil
- b. Melakukan ventilasi tekanan positif sesuai kewenangan

- c. Segera melakukan eskalasi atau rujukan sesuai prosedur

6. Dokumentasi dan Komunikasi

Tujuan: menjamin kesinambungan asuhan dan keselamatan pasien

- a. Mencatat kondisi bayi saat lahir
- b. Mencatat nilai APGAR
- c. Mencatat tindakan yang telah dilakukan
- d. Menyampaikan kondisi bayi kepada ibu dan keluarga

E. Red Flags Kala II dan Eskalasi

Red flags yang memerlukan rujukan atau kolaborasi:

1. Kala II memanjang
2. Gawat janin
3. Distosia bahu
4. Perdarahan abnormal
5. Lilitan tali pusat ketat
6. Ketuban hijau kental

Eskalasi dilakukan sesuai kewenangan bidan dan sistem rujukan yang berlaku.

Aktivitas Belajar (*Scaffolding*)

Aktivitas 1 – *Knows How*

Mini-case diskusi kelompok:

Seorang perempuan berusia 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu datang ke Puskesmas dengan keluhan mulas semakin kuat sejak 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum ibu baik, tekanan darah 118/80 mmHg, nadi 90 kali/menit, suhu 36,9°C. Denyut jantung janin 148 kali/menit. Kontraksi uterus 4–5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50 detik.

Pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan serviks lengkap (10 cm), ketuban telah pecah dengan air ketuban jernih, dan kepala janin sudah berada di dasar panggul. Ibu merasakan dorongan kuat untuk meneran setiap kali kontraksi datang.

Saat kepala bayi mulai terlihat pada vulva (*crowning*), perineum tampak menegang. Bidan bersiap melakukan pimpinan persalinan serta memberikan perlindungan pada perineum untuk mencegah robekan yang luas. Di sisi lain, bidan juga memastikan alat resusitasi bayi telah siap digunakan jika diperlukan setelah bayi lahir.

Lakukan Identifikasi:

1. Apa tanda-tanda bahwa ibu sudah memasuki kala II persalinan?
2. Data apa saja dari kasus yang menunjukkan bahwa proses persalinan berjalan fisiologis?

3. Bagaimana langkah-langkah pimpinan persalinan yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut?
4. Teknik apa yang digunakan untuk melakukan perlindungan perineum saat kepala bayi lahir?
5. Mengapa perlindungan perineum penting dalam proses persalinan?
6. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan robekan perineum saat persalinan?
7. Upaya apa yang harus dilakukan bidan untuk mencegah terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir?
8. Persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum bayi lahir untuk mengantisipasi kegawatdaruratan pada neonatus?

Aktivitas 2 – *Shows How*

Simulasi skill lab:

Mahasiswa mendemonstrasikan:

1. Pimpinan persalinan
2. Perlindungan perineum
3. Pencegahan asfiksia
4. Komunikasi terapeutik

Asesmen (Piramida Miller)

Level	Metode
<i>Knows/Knows How</i>	<i>Self-check & analisis mini-case</i>
<i>Shows How</i>	OSCE Asuhan Kala II
<i>Does</i>	DOPS di lahan praktik

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Persalinan : Fisiologis
3	Kasus	Asuhan Persalinan Kala II
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis

No.	Komponen	Isi
		5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 26 tahun G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu datang ke Puskesmas dengan keluhan mulas semakin kuat. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 118/80 mmHg, nadi 90 kali/menit, suhu 36,9°C, dan denyut jantung janin 148 kali/menit. Kontraksi uterus 4–5 kali dalam 10 menit dengan durasi ± 50 detik. Pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan serviks lengkap (10 cm), ketuban telah pecah dengan air ketuban jernih, dan kepala janin sudah di dasar panggul. Ibu merasakan dorongan kuat untuk meneran dan kepala bayi mulai tampak di vulva (crowning). TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga 6. Jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99, -3 digit jika peserta berjumlah 100–999, -4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian:

No.	Komponen	Isi
		- Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan komunikasi awal dengan ibu bersalin, PS menjawab sesuai dialog PS (ibu merasa ingin meneran, mulas kuat, dan merasa ada tekanan di perineum). 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan pemeriksaan kondisi ibu dan janin sebelum memimpin persalinan, penguji memberikan data: a. His kuat dan teratur (3–4 kali dalam 10 menit, durasi 40–60 detik) b. DJJ 140 x/menit c. Ibu tampak ingin meneran 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan dalam, penguji memberikan data: a. Pembukaan serviks lengkap (10 cm) b. Ketuban sudah pecah c. Kepala janin pada Hodge IV d. Perineum menonjol e. Tampak bagian kepala bayi di introitus vagina 4. Jika peserta menyatakan akan memimpin persalinan, tindakan yang diharapkan meliputi: a. Menjelaskan secara singkat kepada ibu bahwa proses kelahiran bayi akan segera berlangsung b. Membimbing ibu untuk mengejan saat ada his c. Mengatur posisi ibu yang aman dan nyaman d. Menyiapkan alat persalinan dan perlengkapan bayi baru lahir

No.	Komponen	Isi
		e. Melakukan perlindungan perineum saat kepala bayi lahir f. Mengendalikan pengeluaran kepala bayi secara perlahan g. Memeriksa kemungkinan lilitan tali pusat pada leher bayi h. Membantu kelahiran bahu dan tubuh bayi dengan teknik yang benar 5. Setelah bayi lahir, tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: a. Mengeringkan bayi segera setelah lahir b. Menjaga kehangatan bayi c. Menilai pernapasan atau tangisan bayi d. Memberikan stimulasi awal bila bayi belum menangis e. Menyiapkan tindakan resusitasi bila bayi tidak bernapas spontan 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang telah ditentukan. 7. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta oleh peserta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan dan tindakan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 4. PS berperan sebagai ibu inpartu kala II 5. PS tampak cemas, lelah, sesekali meringis saat kontraksi, memegang perut bawah, dan berbicara terputus saat nyeri datang. 6. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif.

No.	Komponen	Isi
		7. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan membantu persalinan ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa yang ibu rasakan sekarang? PS: Perut saya mulas sekali, Bu, seperti ingin mengejan. Peserta: Apakah dorongan untuk mengejan muncul setiap kali mulas datang? PS: Iya, Bu, setiap mulas saya ingin mengejan. Peserta: Apakah air ketuban sudah keluar? PS: Sudah, Bu, tadi sudah keluar. Peserta: Apakah ibu merasakan tekanan di bagian bawah atau seperti ingin buang air besar? PS: Iya, Bu, terasa sekali di bawah. Peserta: Baik, Bu. Saat ini pembukaan sudah lengkap dan bayi akan segera lahir. Saya akan membantu memimpin persalinan ibu. PS: Iya, Bu, saya siap.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Nanti saat mulas datang, ibu tarik napas dalam dan mengejan seperti saat buang air besar, ya. PS: Baik, Bu. Peserta: Sekarang ibu rileks dulu, tunggu sampai mulas datang lagi. PS: Iya, Bu. Peserta: Saat bayi akan lahir, saya akan membantu melindungi jalan lahir ibu dan memastikan bayi lahir dengan aman. PS: Baik, Bu, terima kasih Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan dalam - Phantom abdomen persalinan (terdapat bayi)
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen persalinan (terdapat bayi) — 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Lembar partograf kasus — 1 set 5. Set partus steril (gunting tali pusat, klem tali pusat, pinset anatomis, pinset chirurgis, gunting episiotomi) – 1 Set 6. Sarung tangan steril — 2 pasang 7. Sarung tangan bersih – 1 pasang 8. Kassa steril - ±10 lembar 9. Duk steril – 1

No.	Komponen	Isi
		10. Perlak dan alas bersih – 1 11. Handuk atau kain bersih untuk mengeringkan bayi - 2 buah 12. Pengisap lendir (mucus extractor / suction bulb) – 1 13. Alat resusitasi bayi (bag and mask neonatal) – 1 14. Penghangat bayi / selimut bayi – 1 15. Klem tali pusat tambahan – 1 16. Pengikat tali pusat / klem plastik – 1 17. Larutan antiseptik – 1 18. Kapas atau kassa untuk antiseptik – secukupnya 19. Bengkok – 1 20. Tempat sampah medis – 1 21. Jam atau stopwatch (menghitung kontraksi / Apgar) -1 22. Doppler -1 23. Oksitosin injeksi -1 24. Spuit 3 cc / 5 cc -1 25. Handrub — 1 botol 26. Tisu — 1 pack 27. Infus set — 1 set 28. Cairan RL/NaCl — 1 29. Abocath — 1 30. Formulir rujukan — 1 lembar 31. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 32. Pena — 1
13	Penulis	Arti Wardani, SST., M.Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). <i>Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020</i> . 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). <i>Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022</i> . 3. World Health Organization. (2018). <i>WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience</i> .

No.	Komponen	Isi
		4. World Health Organization. (2022). <i>Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care: A guide for essential practice (4th ed.)</i>. 5. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2024). <i>Clinical practice guideline: First and second stage labor management</i>. 6. National Institute for Health and Care Excellence. (2023). <i>Intrapartum care for healthy women and babies (updated guideline)</i>. Teknik seperti kompres hangat dan pijat perineum dapat membantu menurunkan risiko robekan perineum pada kala II. 7. Resuscitation Council UK. (2025). <i>Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth guidelines</i>. 8. American Heart Association. (2025). <i>Neonatal resuscitation guidelines</i>. Pedoman ini menekankan penilaian napas bayi, penghangatan, dan bantuan ventilasi bila bayi tidak bernapas spontan.

F. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan

Stase 1: Persalinan Fisiologis

Kompetensi 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat persalinan sekarang (sejak kapan mulas, pola his, kemajuan persalinan)		
3. Riwayat pengeluaran pervaginam (lendir darah, air ketuban, perdarahan)		
4. Gerak janin		
5. Rasa ingin meneran		
6. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
7. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
8. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat persalinan dan resusitasi bayi		
g. Memastikan lingkungan dan posisi ibu siap untuk persalinan		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Menilai denyut jantung janin (DJJ)		
d. Memastikan pembukaan serviks lengkap dan tanda kala II persalinan		
e. Mengobservasi dorongan meneran pada ibu		
f. Membimbing ibu meneran saat kontraksi		
g. Mengatur posisi ibu yang nyaman untuk persalinan		
h. Mengamati tanda crowning (kepala bayi tampak di vulva)		
i. Melakukan perlindungan perineum saat kepala bayi lahir		
j. Mengendalikan lahirnya kepala bayi secara perlahan		
k. Memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat		
l. Membantu kelahiran bahu anterior		
m. Membantu kelahiran bahu posterior		
n. Membantu kelahiran seluruh tubuh bayi		
o. Mengeringkan bayi segera setelah lahir		
p. Menilai pernapasan bayi		
q. Melakukan pencegahan asfiksia (membersihkan jalan napas bila perlu)		
r. Menjaga kehangatan bay		
s. Meletakkan bayi di dada ibu (kontak kulit ke kulit)		
3. Pasca tindakan		
a. Menilai kondisi ibu setelah bayi lahir		
b. Menilai kondisi bayi baru lahir		
c. Menjelaskan kondisi ibu dan bayi kepada ibu/keluarga		
d. Mendokumentasikan tindakan dan temuan penting pada catatan medis		
e. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **15–19 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **10–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan kondisi ibu dan bayi saat ini		
3. Menjelaskan proses persalinan yang akan dilakukan		
4. Menjelaskan tindakan bidan dalam membantu kelahiran bayi		
5. Menjelaskan tindakan segera setelah bayi lahir		
6. Memberikan dukungan emosional kepada ibu		
7. Memberikan kesempatan kepada ibu atau keluarga untuk bertanya		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama persalinan		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3
(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =
30

(Kota),

Penguji :.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Persalinan Kala II: Pimpinan Persalinan, Perlindungan Perineum, Dan Pencegahan Asfiksia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan mahasiswa kemudian memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa memimpin persalinan kala II, melakukan perlindungan perineum, serta melakukan tindakan pencegahan asfiksia pada bayi baru lahir

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
	yang dinilai meliputi informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah Menilai kemampuan mahasiswa melakukan asuhan persalinan kala II secara aman, efektif, dan berpusat pada ibu dan bayi.	Mahasiswa dinilai dari kemampuan memimpin persalinan, melindungi perineum, memantau kondisi janin, serta melakukan pencegahan asfiksia pada bayi baru lahir
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan asuhan persalinan kala II	Seorang perempuan 25 tahun, G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu datang ke ruang bersalin dengan pembukaan lengkap. Ibu merasakan dorongan kuat untuk meneran. DJJ 142 x/menit, ketuban sudah pecah, kepala janin terlihat di vulva
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu secara langsung, bukan sekadar mendiskusikan kasus. Pada topik asuhan persalinan kala II, keterampilan yang relevan antara lain menilai kesiapan ibu untuk meneran, memantau kondisi ibu dan janin, termasuk tanda vital ibu dan denyut jantung janin (DJJ), serta memastikan pembukaan serviks telah lengkap dan bagian	Mahasiswa memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur kepada ibu, mempersiapkan alat dan lingkungan bersih, memimpin ibu saat meneran, melakukan perlindungan perineum saat kepala lahir, memeriksa lilitan tali pusat, membantu kelahiran bahu dan badan bayi, mengeringkan bayi, serta memastikan bayi bernapas spontan sebagai upaya pencegahan asfiksia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
	terendah janin telah turun. Mahasiswa juga diamati dalam memimpin proses persalinan dengan memberikan arahan yang tepat saat ibu meneran, menjaga lingkungan persalinan yang aman dan bersih, serta melakukan perlindungan perineum saat kepala bayi lahir untuk mencegah robekan yang tidak perlu. Selain itu, mahasiswa melakukan penilaian adanya lilitan tali pusat, membantu kelahiran bahu dan badan bayi dengan teknik yang benar, serta segera melakukan tindakan pencegahan asfiksia pada bayi baru lahir seperti mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, menilai pernapasan bayi, dan melakukan stimulasi awal bila diperlukan. Pedoman internasional juga menekankan pentingnya keterampilan memimpin persalinan secara aman, perlindungan jaringan perineum, pemantauan kondisi ibu dan janin selama kala II, serta kesiapan melakukan tindakan awal resusitasi bila bayi tidak segera bernapas.	
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi Persiapan tindakan, teknik pimpinan persalinan, teknik perlindungan perineum, pencegahan asfiksia bayi baru	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali tanda bahwa persalinan telah memasuki kala II dengan pembukaan serviks lengkap,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
	lahir, komunikasi dengan ibu, keselamatan pasien, serta profesionalisme.	dorongan kuat untuk meneran, dan penurunan kepala janin yang semakin tampak di vulva. Selain itu, pembimbing menilai apakah mahasiswa dapat memimpin proses persalinan secara tepat dengan memberikan arahan meneran yang efektif, melakukan perlindungan perineum saat kepala bayi lahir untuk mencegah robekan yang tidak perlu, serta memantau kondisi ibu dan janin selama proses kelahiran. Pembimbing juga menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan tindakan segera setelah bayi lahir, seperti mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, menilai pernapasan dan tonus bayi, serta melakukan langkah awal pencegahan asfiksia bila bayi tidak segera bernapas, sehingga keselamatan ibu dan bayi tetap terjaga selama proses persalinan kala II.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah Ketepatan langkah mahasiswa dalam memimpin persalinan, kemampuan menjaga keamanan ibu dan bayi, ketepatan teknik perlindungan perineum, serta kesiapan melakukan	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu memimpin proses persalinan kala II secara tepat dan sistematis, memberikan arahan meneran yang efektif kepada ibu, serta menjaga keselamatan ibu dan bayi selama proses

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
	tindakan awal bila bayi tidak segera bernapas	kelahiran. Selain itu, pembimbing menilai apakah mahasiswa melakukan perlindungan perineum dengan teknik yang benar saat kepala bayi lahir untuk meminimalkan risiko robekan, membantu kelahiran bahu dan badan bayi secara hati-hati, serta segera melakukan penilaian kondisi bayi setelah lahir. Pembimbing juga memperhatikan kesiapan mahasiswa dalam melakukan langkah awal pencegahan asfiksia, seperti mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, menilai pernapasan, dan memberikan stimulasi awal bila diperlukan, serta memastikan seluruh tindakan dilakukan dengan urutan yang benar, aman, dan sesuai dengan standar praktik kebidanan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing memberikan umpan balik segera setelah tindakan selesai mengenai kelebihan mahasiswa serta aspek yang masih perlu diperbaiki, misalnya teknik perlindungan perineum atau koordinasi saat membantu kelahiran bahu bayi
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
	kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level 'does', karena performa mahasiswa diamati langsung saat melakukan tindakan klinik pada persalinan kala II	Pada asuhan persalinan kala II, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami konsep teori tentang proses kelahiran bayi, tetapi juga mampu memimpin persalinan secara langsung dengan aman dan terampil di lahan praktik. Mahasiswa diharapkan mampu memberikan arahan meneran yang tepat kepada ibu, melakukan perlindungan perineum saat kepala bayi lahir untuk mencegah trauma jalan lahir, serta membantu kelahiran bahu dan badan bayi dengan teknik yang benar. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu melakukan tindakan awal pencegahan asfiksia pada bayi baru lahir, seperti mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, menilai

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
		pernapasan, dan memberikan stimulasi awal bila diperlukan, sehingga keselamatan ibu dan bayi tetap terjaga selama proses persalinan kala II berlangsung

G. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Persalinan kala II: pimpinan persalinan, perlindungan perineum, dan pencegahan asfiksia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik asuhan persalinan kala II, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian kondisi ibu dan janin pada kala II, memimpin proses persalinan dengan memberikan arahan meneran yang tepat, melakukan perlindungan perineum untuk mencegah trauma jalan lahir, serta membantu kelahiran bayi dengan teknik yang aman. Selain itu, portofolio juga menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan tindakan awal pencegahan asfiksia pada bayi baru lahir, seperti mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, menilai pernapasan bayi, serta melakukan stimulasi awal bila diperlukan, sekaligus memperbaiki performa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		berdasarkan umpan balik dari pembimbing atau dosen klinik
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan asuhan persalinan kala II, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kemampuannya berkembang dalam memimpin persalinan, melakukan perlindungan perineum, serta melakukan langkah awal pencegahan asfiksia pada bayi baru lahir. Melalui portofolio, terlihat bagaimana mahasiswa meningkatkan keterampilan kliniknya setelah menerima masukan dan bimbingan dari dosen atau Clinical Instructor (CI), sehingga tindakan yang dilakukan menjadi lebih tepat, aman, dan sesuai dengan standar praktik kebidanan
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performanya nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan mahasiswa dalam mengenali tanda dimulainya kala II, memimpin proses persalinan dengan arahan meneran yang tepat, serta melakukan teknik perlindungan perineum saat kepala bayi lahir. Sementara itu, DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan persalinan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		kala II di ruang bersalin, termasuk memimpin kelahiran bayi, membantu kelahiran bahu dan badan bayi dengan teknik yang benar, serta melakukan langkah awal pencegahan asfiksia pada bayi baru lahir seperti mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, dan menilai pernapasan bayi segera setelah lahir
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu yang telah memasuki kala II persalinan dengan pembukaan lengkap, ibu merasakan dorongan kuat untuk meneran, dan kepala janin mulai tampak di vulva. Mahasiswa mendokumentasikan kondisi ibu dan janin, termasuk tanda vital ibu dan denyut jantung janin (DJJ), proses pimpinan persalinan yang dilakukan, teknik perlindungan perineum saat kepala bayi lahir, serta langkah membantu kelahiran bahu dan badan bayi. Selain itu, mahasiswa juga mencatat tindakan segera setelah bayi lahir, seperti mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, menilai pernapasan bayi, dan melakukan langkah awal pencegahan asfiksia, serta

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		hasil akhir kondisi ibu dan bayi setelah persalinan berlangsung
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya melakukan asuhan persalinan kala II secara tepat dan aman, termasuk ketelitian dalam memantau kondisi ibu dan janin selama proses kelahiran, memberikan arahan meneran yang efektif, serta melakukan perlindungan perineum untuk mencegah trauma jalan lahir. Mahasiswa juga merefleksikan pentingnya melakukan penilaian segera terhadap kondisi bayi setelah lahir, seperti menilai pernapasan dan tonus bayi, menjaga kehangatan, serta melakukan langkah awal pencegahan asfiksia bila bayi tidak segera bernapas. Selain itu, mahasiswa menyadari pentingnya komunikasi yang baik dengan ibu dan keluarga selama proses persalinan agar tindakan yang dilakukan dapat dipahami dan mendukung keselamatan ibu dan bayi
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam memimpin proses persalinan kala II dan memberikan arahan meneran kepada ibu, serta mampu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		membantu kelahiran bayi dengan teknik yang cukup tepat. Namun, mahasiswa masih perlu meningkatkan keterampilan dalam melakukan perlindungan perineum secara optimal saat kepala bayi lahir, menjaga koordinasi saat membantu kelahiran bahu dan badan bayi, serta meningkatkan ketelitian dalam melakukan penilaian kondisi bayi segera setelah lahir. Selain itu, mahasiswa juga perlu lebih percaya diri dalam melakukan langkah awal pencegahan asfiksia, seperti menilai pernapasan bayi, memberikan stimulasi awal bila diperlukan, dan memastikan bayi tetap hangat setelah lahir.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu pengalaman melakukan asuhan persalinan kala II, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia secara konsisten mampu memimpin proses persalinan dengan memberikan arahan meneran yang tepat, melakukan perlindungan perineum dengan teknik yang benar, serta membantu kelahiran bayi secara aman. Selain itu, mahasiswa juga dinilai dari

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		kemampuannya secara konsisten melakukan penilaian segera terhadap kondisi bayi setelah lahir dan melaksanakan langkah awal pencegahan asfiksia, sehingga keselamatan ibu dan bayi tetap terjaga selama proses persalinan berlangsung
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan asuhan persalinan kala II dengan baik, termasuk memimpin proses persalinan dengan arahan meneran yang tepat, melakukan perlindungan perineum saat kepala bayi lahir, serta membantu kelahiran bahu dan badan bayi secara aman. Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan kemampuan yang konsisten dalam melakukan penilaian kondisi bayi segera setelah lahir dan melaksanakan langkah awal pencegahan asfiksia, seperti mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, serta menilai pernapasan bayi secara cepat dan tepat
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi	Pada topik asuhan persalinan kala II, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep tentang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	pimpinan persalinan, perlindungan perineum, dan pencegahan asfiksia, tetapi juga secara konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata. Hal ini terlihat dari kemampuan mahasiswa dalam memimpin proses persalinan dengan arahan meneran yang tepat, melakukan perlindungan perineum untuk mencegah trauma jalan lahir, serta melakukan penilaian segera terhadap kondisi bayi setelah lahir dan melaksanakan langkah awal pencegahan asfiksia secara aman dan sesuai standar praktik kebidanan

Tabel. Case Report pada Asuhan Persalinan Kala II: Pimpinan Persalinan, Perlindungan Perineum, Dan Pencegahan Asfiksia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Asuhan persalinan kala II
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu bersalin primigravida dengan usia kehamilan cukup bulan yang telah memasuki kala II persalinan dengan pembukaan lengkap dan dorongan kuat untuk meneran. Kepala janin mulai tampak di vulva dan denyut jantung janin dalam batas normal. Mahasiswa mendokumentasikan proses pimpinan persalinan yang dilakukan, teknik perlindungan perineum saat kepala bayi lahir, serta langkah penilaian dan tindakan awal yang dilakukan untuk mencegah asfiksia pada bayi baru lahir
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu bersalin, tetapi juga menjelaskan kondisi klinis yang menjadi fokus asuhan pada kala II persalinan, langkah-langkah pimpinan persalinan yang dilakukan, serta teknik perlindungan perineum saat kelahiran kepala bayi. Selain itu, mahasiswa juga mendokumentasikan tindakan yang diberikan setelah bayi lahir, termasuk penilaian kondisi bayi baru lahir dan langkah awal pencegahan asfiksia seperti mengeringkan bayi, menjaga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Asuhan persalinan kala II
		kehangatan, dan menilai pernapasan bayi. Mahasiswa kemudian menjelaskan perkembangan kondisi ibu dan bayi setelah proses persalinan dan tindakan awal tersebut dilakukan
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan bahwa ibu bersalin telah memasuki kala II persalinan dengan pembukaan serviks lengkap, ibu merasakan dorongan kuat untuk meneran, dan kepala janin mulai tampak di vulva. Mahasiswa mendokumentasikan kondisi ibu dan janin, termasuk tanda vital ibu dan denyut jantung janin (DJJ), proses pimpinan persalinan yang dilakukan, serta teknik perlindungan perineum saat kepala bayi lahir. Selain itu, mahasiswa juga menuliskan langkah-langkah yang dilakukan setelah bayi lahir, seperti membantu kelahiran bahu dan badan bayi, mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, menilai pernapasan bayi, serta melakukan tindakan awal pencegahan asfiksia, dan mencatat kondisi akhir ibu dan bayi setelah proses persalinan berlangsung.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali bahwa persalinan telah memasuki kala II dengan pembukaan serviks lengkap dan adanya dorongan kuat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Asuhan persalinan kala II
	kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	untuk meneran, serta mampu memimpin proses kelahiran bayi secara tepat dan aman. Selain itu, pembimbing menilai apakah mahasiswa dapat melakukan perlindungan perineum saat kepala bayi lahir untuk mencegah robekan jalan lahir, membantu kelahiran bahu dan badan bayi dengan teknik yang benar, serta segera melakukan penilaian kondisi bayi setelah lahir. Pembimbing juga memperhatikan kemampuan mahasiswa dalam melakukan langkah awal pencegahan asfiksia, seperti mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, menilai pernapasan, dan memberikan stimulasi awal bila diperlukan untuk memastikan bayi dapat bernapas dengan baik setelah lahir
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus asuhan persalinan kala II, mahasiswa belajar bahwa pimpinan persalinan yang tepat, pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkelanjutan, serta penerapan teknik perlindungan perineum merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan ibu selama proses kelahiran. Selain itu, mahasiswa juga memahami bahwa penilaian segera terhadap kondisi bayi setelah lahir dan pelaksanaan langkah awal pencegahan asfiksia, seperti mengeringkan bayi,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Asuhan persalinan kala II
		menjaga kehangatan, dan menilai pernapasan bayi, merupakan inti keselamatan dalam asuhan persalinan bagi ibu dan bayi
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep asuhan persalinan kala II, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan proses pimpinan persalinan, penerapan teknik perlindungan perineum, serta langkah-langkah pencegahan asfiksia pada bayi baru lahir secara sistematis. Laporan tersebut mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam mendokumentasikan pengkajian, tindakan yang dilakukan selama proses kelahiran, serta kondisi ibu dan bayi setelah persalinan secara utuh sesuai dengan prinsip asuhan kebidanan.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Persalinan Kala II: Pimpinan Persalinan, Perlindungan Perineum, Dan Pencegahan Asfiksia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi	Pada kasus persalinan kala II, mahasiswa merefleksikan bahwa ketidaktepatan dalam memimpin proses persalinan, kurangnya perlindungan perineum saat kepala bayi lahir, atau keterlambatan melakukan penilaian kondisi bayi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
	masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	setelah lahir dapat meningkatkan risiko cedera jalan lahir pada ibu maupun asfiksia pada bayi baru lahir. Oleh karena itu, mahasiswa menyadari pentingnya melakukan pimpinan persalinan secara tepat, menerapkan teknik perlindungan perineum yang benar, serta melakukan penilaian dan tindakan awal pencegahan asfiksia secara cepat untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil dalam asuhan persalinan kala II, seperti kurang tepat dalam memimpin proses meneran, tidak melakukan perlindungan perineum dengan benar saat kepala bayi lahir, atau terlambat melakukan penilaian kondisi bayi setelah lahir, dapat berdampak pada keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, keterlambatan dalam melakukan langkah awal pencegahan asfiksia, seperti mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, dan menilai pernapasan bayi, juga dapat meningkatkan risiko komplikasi pada bayi baru lahir. Oleh karena itu, ketelitian, ketepatan tindakan, dan kesiapan melakukan penanganan segera menjadi sangat penting dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada asuhan persalinan kala II

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
	penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	antara lain terjadinya robekan perineum yang berat bila perlindungan perineum tidak dilakukan dengan baik, kelelahan ibu akibat proses meneran yang tidak efektif, serta risiko asfiksia pada bayi baru lahir apabila penilaian kondisi bayi dan tindakan awal tidak dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, keterlambatan dalam melakukan penilaian kondisi bayi setelah lahir atau kurangnya kesiapan dalam melakukan tindakan awal juga dapat meningkatkan risiko komplikasi pada bayi, sehingga pemantauan yang cermat dan tindakan yang tepat waktu sangat penting untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan..
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi pada asuhan persalinan kala II antara lain ketidaktepatan dalam memimpin proses meneran, tidak optimalnya perlindungan perineum sehingga meningkatkan risiko robekan jalan lahir, serta kurang cermatnya pemantauan kondisi ibu dan janin selama proses kelahiran. Selain itu, keterlambatan dalam melakukan penilaian kondisi bayi setelah lahir, seperti menilai pernapasan dan tonus bayi, atau kurang siapnya tindakan awal pencegahan asfiksia, dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan pada bayi baru lahir. Oleh

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
		karena itu, ketelitian dalam melakukan setiap langkah asuhan sangat penting untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi selama persalinan kala II
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya melakukan asuhan persalinan kala II secara sistematis dan sesuai standar, termasuk pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkelanjutan, pemberian arahan meneran yang efektif kepada ibu, serta penerapan teknik perlindungan perineum saat kepala bayi lahir untuk mencegah robekan jalan lahir. Selain itu, mahasiswa juga menekankan pentingnya melakukan penilaian segera terhadap kondisi bayi setelah lahir, menjaga kehangatan bayi, serta melaksanakan langkah awal pencegahan asfiksia seperti mengeringkan bayi dan menilai pernapasan bayi. Komunikasi yang baik dengan ibu dan keluarga selama proses persalinan juga dianggap penting agar setiap tindakan yang dilakukan dapat dipahami dan mendukung keselamatan ibu dan bayi.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada asuhan persalinan kala II, pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkelanjutan, kemampuan memimpin proses persalinan dengan tepat, serta penerapan teknik

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan persalinan kala II
		perlindungan perineum merupakan bagian penting dari praktik kebidanan yang aman. Selain itu, mahasiswa juga memahami bahwa penilaian segera terhadap kondisi bayi setelah lahir dan kesiapan melakukan langkah awal pencegahan asfiksia sangat penting untuk memastikan bayi dapat bernapas dengan baik dan tetap dalam kondisi stabil setelah proses kelahiran
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu melakukan asuhan persalinan kala II, tetapi juga mampu mengevaluasi potensi risiko yang dapat terjadi selama proses persalinan, seperti risiko robekan perineum atau gangguan pernapasan pada bayi baru lahir. Mahasiswa juga menunjukkan kemampuan untuk merefleksikan praktik yang telah dilakukan, memperbaiki teknik pimpinan persalinan, meningkatkan keterampilan perlindungan perineum, serta lebih siap melakukan langkah awal pencegahan asfiksia, sehingga kualitas praktik kebidanan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

H. Ringkasan

Persalinan kala II dimulai sejak pembukaan serviks lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. Pada tahap ini ibu biasanya merasakan dorongan kuat untuk meneran yang disertai dengan penurunan bagian terendah janin ke dasar panggul. Dalam praktik kebidanan yang aman, proses persalinan kala II harus dipantau secara cermat dengan memperhatikan kondisi ibu dan janin, termasuk kekuatan his, frekuensi dan efektivitas meneran, penurunan kepala janin, serta denyut jantung janin (DJJ). Pemantauan yang baik membantu bidan memastikan bahwa proses kelahiran berlangsung secara fisiologis dan aman bagi ibu maupun bayi.

Pada praktik klinik, bidan harus mampu memimpin persalinan dengan memberikan arahan yang tepat kepada ibu saat meneran, menjaga posisi ibu yang nyaman dan aman, serta memastikan lingkungan persalinan bersih dan siap untuk kelahiran bayi. Selain itu, bidan juga perlu melakukan perlindungan perineum saat kepala bayi lahir untuk mengurangi risiko robekan jalan lahir. Proses kelahiran bayi harus dibantu dengan teknik yang benar, termasuk membantu kelahiran bahu dan badan bayi secara hati-hati. Setelah bayi lahir, bidan harus segera melakukan penilaian awal terhadap kondisi bayi, menjaga kehangatan, serta melakukan langkah-langkah pencegahan asfiksia dengan mengeringkan bayi, menilai pernapasan, dan memberikan stimulasi awal bila diperlukan.

Tindakan bidan pada persalinan kala II berfokus pada pimpinan persalinan yang aman, perlindungan jaringan ibu, serta penilaian cepat terhadap kondisi bayi setelah lahir. Langkah penting meliputi memantau kondisi ibu dan janin secara berkala, memberikan dukungan emosional kepada ibu, membimbing ibu saat meneran secara efektif, melakukan perlindungan perineum saat kepala bayi lahir, memeriksa kemungkinan lilitan tali pusat, membantu kelahiran bahu dan badan bayi dengan teknik yang tepat, serta melakukan penilaian kondisi bayi segera setelah lahir. Upaya pencegahan asfiksia dilakukan dengan mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, memastikan jalan napas bebas, dan menilai pernapasan bayi secara cepat sehingga bayi dapat beradaptasi dengan baik setelah lahir.

Alur Asuhan Singkat

Ibu dengan pembukaan lengkap dan dorongan kuat untuk meneran pantau kondisi ibu dan janin pimpin proses meneran secara efektif lakukan perlindungan perineum saat kepala bayi lahir bantu kelahiran bahu dan badan bayi lakukan penilaian awal bayi baru lahir lakukan langkah awal pencegahan asfiksia dokumentasi dan pemantauan kondisi ibu dan bayi setelah persalinan

I. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Persalinan Kala II: Pimpinan Persalinan, Perlindungan Perineum, Dan Pencegahan Asfiksia

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Kepala bayi sudah tampak di introitus tetapi tidak terjadi kemajuan kelahiran dalam waktu lama	Menunjukkan kemungkinan persalinan kala II memanjang, kelelahan ibu, atau hambatan mekanis pada jalan lahir	Lakukan evaluasi ulang kekuatan his, posisi janin, dan kondisi ibu. Laporkan kepada pembimbing/DPJP serta siapkan kolaborasi atau rujukan bila persalinan tidak maju
DJJ <110 atau >160 x/menit saat kala II	Menunjukkan kemungkinan gawat janin akibat hipoksia selama proses persalinan	Secepatnya evaluasi kondisi ibu dan janin, optimalkan posisi ibu, percepat proses persalinan bila memungkinkan, dan segera laporkan ke pembimbing/DPJP untuk tindakan lebih lanjut
Bayi lahir tetapi tidak segera menangis atau bernapas spontan	Menunjukkan kemungkinan asfiksia neonatorum atau gangguan adaptasi pernapasan bayi baru lahir	Secepatnya lakukan langkah awal resusitasi bayi baru lahir: mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, membuka jalan napas, memberikan stimulasi, dan memulai resusitasi sesuai prosedur
Perineum tampak sangat tegang, pucat, dan berisiko robekan luas	Menunjukkan risiko tinggi ruptur perineum derajat berat	Lakukan perlindungan perineum dengan teknik hands-on, kontrol pengeluaran kepala bayi secara perlahan, serta koordinasi dengan pembimbing bila diperlukan tindakan tambahan
Bahu bayi sulit lahir setelah kepala keluar	Kemungkinan terjadi distosia bahu, yang dapat membahayakan bayi.	Secepatnya panggil bantuan, lakukan manuver penanganan distosia bahu sesuai protokol, dan siapkan tindakan lanjutan oleh tenaga yang lebih kompeten

Perdarahan banyak segera setelah bayi lahir	Menunjukkan kemungkinan perdarahan postpartum awal akibat trauma jalan lahir atau robekan perineum	Segera evaluasi sumber perdarahan, lakukan penanganan awal, dan laporkan kepada pembimbing/DPJP untuk penatalaksanaan lebih lanjut.
Ibu tampak sangat kelelahan dan tidak mampu mengejan efektif	Menunjukkan risiko kala II memanjang dan penurunan kemampuan ibu dalam membantu proses kelahiran	Berikan dukungan, posisi yang nyaman, pemantauan ketat kondisi ibu dan janin, serta evaluasi kemungkinan tindakan kolaboratif
Air ketuban berwarna hijau kental saat bayi lahir	Menunjukkan kemungkinan aspirasi mekonium dan risiko gangguan pernapasan bay	Siapkan penatalaksanaan bayi baru lahir dengan risiko asfiksia, lakukan penilaian napas segera setelah lahir, dan siapkan resusitasi bila diperlukan
Kelahiran kepala bayi terlalu cepat tanpa kontrol	Berisiko menyebabkan ruptur perineum dan trauma pada ibu	Lakukan pengendalian pengeluaran kepala bayi secara perlahan, berikan perlindungan perineum, serta arahkan ibu untuk mengejan terkontrol

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Asuhan Persalinan Kala II: Pimpinan Persalinan, Perlindungan Perineum, Dan Pencegahan Asfiksia

Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Tanggal : _____
Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian persalinan kala II dan tanda dimulainya kala II persalinan	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan pimpinan persalinan pada kala II untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan pengkajian cepat pada ibu bersalin kala II sebelum memimpin persalinan	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menilai tanda-tanda persalinan kala II seperti dorongan meneran, pembukaan lengkap, dan penurunan kepala janin	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mempersiapkan alat, lingkungan, dan posisi ibu yang aman sebelum proses kelahiran bayi	☐	☐	
6	Saya sudah bisa memimpin ibu untuk mengejan secara efektif dan aman selama kala II	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan teknik perlindungan perineum saat kepala bayi lahir untuk mencegah robekan	☐	☐	
8	Saya sudah bisa mengendalikan pengeluaran kepala bayi secara perlahan dan terkontrol	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher bayi setelah kepala lahir	☐	☐	
10	Saya sudah bisa membantu kelahiran bahu dan tubuh bayi dengan teknik yang benar dan aman	☐	☐	
11	Saya sudah bisa melakukan langkah awal pencegahan asfiksia bayi baru lahir segera setelah bayi lahir	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
12	Saya sudah bisa menilai pernapasan dan tangisan bayi sebagai tanda adaptasi awal bayi baru lahir	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menjaga kehangatan bayi dan melakukan pengeringan segera setelah lahir	☐	☐	
14	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya pada ibu dan bayi saat proses kelahiran berlangsung	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan bayi kepada keluarga dengan bahasa sederhana dan jelas	☐	☐	
16	Saya sudah bisa mendokumentasikan proses kelahiran bayi dan tindakan yang dilakukan secara ringkas dan tepat	☐	☐	
17	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama memimpin persalinan kala II			

Refleksi singkat mahasiswa:

J. Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics & American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). *Guidelines for perinatal care* (9th ed.). American Academy of Pediatrics.
- American Heart Association; American Academy of Pediatrics. (2023). *2023 focused update: Neonatal resuscitation guidelines. Circulation.*
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
- Dwan, K., Fox, T., Lutje, V., Lavender, T., & Mills, T. A. (2024). *Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma and postpartum complications* (Cochrane Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2024(1). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD016148>
- Fitriani, S., & Mustafa, A. R. (2024). *Hubungan lama persalinan kala II dengan kejadian asfiksia neonatorum di Rumah Sakit Bakti Timah. Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 14(3). <https://doi.org/10.33221/jiki.v14i03.3117>
- Herlina, N., Agustina, I. F., Ekowati, E., Perwitasari, T., & Rekan. (2025). *Asuhan Kebidanan Persalinan: Teori dan Implementasi*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Genç Koyucu, R., Ketenci Gencer, F., & Bilici, S. R. (2025). *Effects of manual perineal protection and pushing techniques used in the second stage of labor on perineal outcomes: A randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1), 671. <https://doi.org/10.1186/s12884-025-07564-6>
- Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2024). *Myles textbook for midwives* (18th ed.). Elsevier.
- Yulianti, N. T., Devitasari, I., Gustina S., R., Wulan, S., Sulikah, S., & Fithrotul U., (2025). *Peran bidan dalam persalinan normal yang aman* (ISBN 978-623-89965-3-7). Optimal Untuk Negeri.
- Zhang, J., Cai, F., Li, Y., & Xu, M. (2025). *Impact and safety of perineal massage in late pregnancy on delivery outcomes among primiparous women: A propensity score matching analysis. BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1), 1270. <https://doi.org/10.1186/s12884-025-08452-9>
- Zanah, M., & Armalini, R. (2022). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Bintang Semesta Media.

PROFIL PENULIS



Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes. Lahir di Banyuwangi, 04 Juni 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan, Stikes Husada Jombang pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 Kebidanan pada Stikes Husada Jombang dan lulus tahun pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan kembali pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 - 2013 di Stikes Dian Husada Mojokerto. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto sejak 2014 hingga sekarang. Mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar kebidanan, Asuhan Kebidanan Persalinan,

Dokumentasi Kebidanan, Komunikasi dan Konseling Pelayanan Kebidanan, Komplementer ibu dan Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: veryudhaekap@gmail.com



Imtihanatun Najahah, SST. M.Kes. Lahir di Dasan Agung, 24 Februari 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi D4 Pendidik, Universitas Padjajaran Bandung tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Udayana dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 Poltekkes Kemenkes Mataram. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mataram mengampu mata kuliah Komunikasi dan Konseling Dalam Praktek Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Metodologi penelitian. Penulis aktif dalam

berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengalaman menulis buku Monograf : Peningkatan Pengetahuan ASI Eksklusif Melalui Media E-Booklet, buku Referensi : Kelas ASI Eksklusif Untuk Kader, Book Chapter in Infant Nutrition and Feeding Book : Exclusive Breastfeeding, Buku OSCE Profesi Bidan, Buku Bunga rampai komunikasi efektif untuk S1 kebidanan, Buku Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Dan Anak Balita, Buku Tumbuh Kembang Anak Neonatologi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: imtihanatun4a@gmail.com

Motto: "Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain"

PROFIL PENULIS



Bdn. Meidayana Refisiliyani, S.Tr.Keb., M.Keb. Lahir di Tanete, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Mei 1998. Ia menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Makassar dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, ia melanjutkan studi di Program Studi D IV Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Kebidanan (S.Tr.Keb) pada tahun 2020. Semangatnya dalam bidang kebidanan mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di Program Studi Magister Ilmu Kebidanan, Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Ia menyelesaikan studi tersebut dan meraih gelar Magister Kebidanan (M.Keb) pada tahun 2022. Pada tahun 2025, ia menempuh Pendidikan Profesi Bidan di Politeknik Tiara Bunda dan berhasil menyelesaikannya pada tahun yang sama. Saat ini, Meidayana aktif sebagai staf pengajar di Akademi Kebidanan Murung Raya, Kalimantan Tengah. Selain mengajar, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus Kepakaran Persalinan serta peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan reproduksi, serta edukasi gizi keluarga. Dedikasinya dalam dunia akademik dan praktik kebidanan tercermin dari berbagai keterlibatannya dalam pengembangan kurikulum, pelatihan mahasiswa profesi bidan, serta penyuluhan berbasis bukti di tingkat komunitas.



Bdn. Dewi Hanifah, S.ST., M.Keb) Lahir di Sukabumi, 23 Februari 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D III pada Program Studi D III Kebidanan AKBID Muhammadiyah Jakarta lulus tahun 2006, kemudian melanjutkan S1 pada Program Studi D IV Kebidanan, Universitas Padjadjaran Bandung lulus tahun 2010, Pendidikan Profesi Kebidanan lulus tahun 2026. Pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran Bandung lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai Bidan di RS Islam Asyifa Sukabumi. Saat ini penulis bekerja di STIKes Sukabumi mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Asuhan Kebidanan Patologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewihanifah@dosen.stikesmi.ac.id
Motto: Sebaik-baik Manusia adalah yang bermanfaat untuk Sesama

PROFIL PENULIS



Naning Suryani, SST., Bdn., M.Keb, lahir di Garut pada tanggal 01 April 1974. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari SMA Negeri Malangbong, yang saat ini dikenal dengan SMAN 9 Garut, dan lulus pada tahun 1993. Selanjutnya, beliau menempuh pendidikan D3 Kebidanan di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun 2010, beliau menyelesaikan pendidikan D4 Bidan Pendidik di Universitas Padjadjaran. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2015. Selain itu, beliau juga telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Indonesia Maju (UIMA) pada tahun 2023.

Saat ini, Naning Suryani bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kesehatan Karsa Husada Garut. Beliau mengajar pada Program Studi D3 Kebidanan sejak tahun 2010 sampai dengan 2023, kemudian melanjutkan pengabdian sebagai dosen pada Program Studi S1 Kebidanan sejak tahun 2023 hingga sekarang.



Arti Wardani, SST., M.Keb. Penulis lahir di Beting pada 20 Oktober 1989 dan menetap di Malang, Provinsi Jawa Timur. Menyelesaikan Pendidikan DIII Program Studi Kebidanan di STIKes Kendedes Malang pada tahun 2010, lulus DIV Program Studi Kebidanan bidang ilmu bidan pendidik di Poltekkes Kemenkes Malang pada tahun 2011, lulus S2 Program Studi Kebidanan, Universitas Brawijaya pada tahun 2024. Penulis adalah dosen Program Studi Kebidanan STIKes Kendedes Malang dan mengampu mata

kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan Pada Persalinan, Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas, Asuhan Kebidanan Pada Bayi Balita dan Anak Prasekolah, Asuhan Kebidanan KB dan Pelayanan Kontrasepsi, Asuhan Kebidanan Pada Kasus Kompleks, Komplikasi Dalam Kehamilan Persalinan Nifas dan Bayi Baru Lahir, Pengantar Praktik Kebidanan, Praktik Profesional Bidan, Anatomi Fisiologi Manusia, Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi, Biologi Reproduksi, dan Asuhan Kebidanan Komplementer Herbal. Penulis aktif dalam melakukan riset di bidang kesehatan ibu dan anak. Penulis telah mempublikasikan beberapa hasil riset pada jurnal terakreditasi nasional.

Email : artiwardani5@gmail.com

Instansi Mengajar : Prodi Kebidanan STIKes Kendedes Malang

Sinopsis

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kegawatdaruratan Intrapartum disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami konsep dasar, prinsip, dan keterampilan asuhan kebidanan pada masa persalinan. Buku ini membahas proses persalinan normal secara sistematis, mulai dari perubahan fisiologis dan psikologis ibu bersalin, tahapan persalinan, pemantauan kemajuan persalinan, hingga penerapan asuhan sayang ibu dan bayi.

Selain membahas asuhan persalinan normal, buku ini juga memperkenalkan berbagai kondisi kegawatdaruratan intrapartum yang dapat terjadi selama proses persalinan. Pembaca diarahkan untuk mengenali tanda bahaya, melakukan deteksi dini, mengambil keputusan klinis secara tepat, serta memahami prinsip penatalaksanaan awal sesuai kewenangan bidan. Materi disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran praktik kebidanan.

Melalui buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, sikap profesional, dan keterampilan dasar dalam memberikan asuhan kebidanan persalinan yang aman, bermutu, berpusat pada perempuan, serta responsif terhadap kondisi kegawatdaruratan. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi pendidik, praktisi kebidanan, dan tenaga kesehatan yang ingin memperkuat pemahaman mengenai asuhan persalinan dan penanganan awal kegawatdaruratan intrapartum.

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kegawatdaruratan Intrapartum disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami konsep dasar, prinsip, dan keterampilan asuhan kebidanan pada masa persalinan. Buku ini membahas proses persalinan normal secara sistematis, mulai dari perubahan fisiologis dan psikologis ibu bersalin, tahapan persalinan, pemantauan kemajuan persalinan, hingga penerapan asuhan sayang ibu dan bayi.

Selain membahas asuhan persalinan normal, buku ini juga memperkenalkan berbagai kondisi kegawatdaruratan intrapartum yang dapat terjadi selama proses persalinan. Pembaca diarahkan untuk mengenali tanda bahaya, melakukan deteksi dini, mengambil keputusan klinis secara tepat, serta memahami prinsip penatalaksanaan awal sesuai kewenangan bidan. Materi disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran praktik kebidanan.

Melalui buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, sikap profesional, dan keterampilan dasar dalam memberikan asuhan kebidanan persalinan yang aman, bermutu, berpusat pada perempuan, serta responsif terhadap kondisi kegawatdaruratan. Buku ini juga dapat menjadi referensi bagi pendidik, praktisi kebidanan, dan tenaga kesehatan yang ingin memperkuat pemahaman mengenai asuhan persalinan dan penanganan awal kegawatdaruratan intrapartum.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-46-6 (PDF)



9

786347

756466